Hem��irelik Ausbildung ��� T��rk��e ��al����ma Rehberi

- Hemşirelik Ausbildung — Türkçe çalışma rehberi
  - Kullanım sırası
  - Bölümler
  - Ekler
  - İşaretler
- 00 — Dosya envanteri, kaynak kalitesi ve **çelişkiler**
  - 1. Nasıl okudum? (dürüst durum)
  - 2. Dosyalar (30)
  - 3. Öğrenme sırası
  - 4. Çelişkiler ve şüpheli noktalar (düzeltilmeden bırakıldı)
- 01 — Mesleki hemşireliğin temelleri (LF 1A)
  - 1. Hemşirelik nedir? (**Pflege**)
  - 2. Temel kavramlar
  - 3. Meslek rolü ve eylem yetkinliği (**Handlungskompetenz**)
  - 4. Krohwinkel'in 13 ABEDL'i
  - 5. Bakım süreci (**Pflegeprozess**) — Fiechter & Meier'e göre 6 aşama
  - 6. Yasal dayanak: **Pflegeberufegesetz (PflBG)**
  - 7. Kısa tekrar
  - 8. Almanca cevap kalıpları
- 02 — Hemşirelikte iletişim, dokunma, yakınlık–mesafe
  - 1. İletişim nedir? (**Kommunikation**)
  - 2. Selamlama, sessizlik, konuşmayı başlatma/bitirme (Sequenz 2)
  - 3. Duruma uygun dil ve çocuklaştırıcı dil (**infantilisierende Sprache**)
  - 4. Dokunma, yakınlık ve mesafe (LF 3a)
  - 5. Terimler
  - 6. Sınav bilgisi
- 02b — Pflegedeutsch: Hasta ve ekip iletişimi (Türkçe açıklamalı)
  - Mündlich (sözlü) simülasyon soruları
- 03 — Hijyen, enfeksiyonlar, enfeksiyondan korunma (LF 3a)
  - 1. Hijyen (**Hygiene**)
  - 2. Enfeksiyon kavramları ve bulaş yolları
  - 3. Bakım personelinin kişisel hijyeni (T1 S. 9)
  - 4. El hijyeni (**Händehygiene**)
  - 5. Eldiven ve koruyucu giysi
  - 6. Mikrop azaltma
  - 7. Enfeksiyon belirtileri: **5 iltihap bulgusu**
  - 8. Çoklu dirençli etkenler (**MRE**)
  - 9. İş güvenliği (BGW 2018)
  - 10. Terimler
  - 11. Sınav bilgisi
- 04 — Hücre, doku, cilt ve cilt değişiklikleri (LF 3a)
  - 1. Hücre (**Zelle**) — T1
  - 2. Doku (**Gewebe**)
  - 3. Cilt (**Haut**) — T2
  - 4. Hemşirelikte cilt gözlemi (sınav için kritik)
  - 5. Dekubitus (**bası yarası**)
  - 6. İyi/kötü huylu değişiklikler; **ABCDE kuralı**
  - 7. Yaşa bağlı özellikler
  - 8. Terimler
  - 9. Sınav bilgisi
- 05 — Vücut ısısı, ateş, hipotermi/hipertermi
  - 1. Fizyoloji (S. 2–4)
  - 2. Ne zaman / nereden ölçülür? (S. 5–14)
  - 3. Hipotermi (S. 15–17)

    - 4. Hipertermi (S. 17–21)
    - 5. Ateş (**Fieber**) (S. 21–29)
    - 6. Vaka: Herr Schneider ateşli (örnek)
    - 7. Terimler
    - 8. Sınav bilgisi
- 06 — LF 2: Hareketlilik, yaşlılıkta hareket ve düşme profilaksisi
    - 1. Kavramlar (EH S. 1–2, 4)
    - 2. Yaşlılıkta ne değişir? (EH S. 1–2)
    - 3. Hareketsizliğin sonuçları (EH S. 3)
    - 4. Prophylaxe ↔ Prävention (EH S. 4)
    - 5. Düşme profilaksisi (**Sturzprophylaxe**) — F
    - 6. Vaka: Herr Schneider (Operatoren-Übung) — cevaplarınıza geri bildirim
    - 7. Terimler
    - 8. Sınav bilgisi
- 07 — LF 2: Tromboz profilaksisi, pnömoni profilaksisi, kontraktür
- A. TROMBOZ PROFİLAKSİSİ (**Thromboseprophylaxe**)
    - 1. Temeller
    - 2. Önlemler (IC S. 3–6)
    - 3. Kontraktür (IC S. 6)
- B. PNÖMONİ PROFİLAKSİSİ (**Pneumonieprophylaxe**)
    - 4. Pneumonie (P S. 2–19)
    - 5. LISA prensibi (IC S. 1)
    - 6. Terimler
    - 7. Sınav bilgisi
- 08 — İlk yardım, temel yaşam desteği (BLS), AED, şok ve akut acil durumlar
    - 1. Neden anatomi? (ZF S. 1)
    - 2. Acil ve ilk yardım — tanım ve hukuk
    - 3. Güvenlik, acil çağrı, kurtarma zinciri
    - 4. İlk değerlendirme
    - 5. Temel yaşam desteği (BLS) ve AED
    - 6. Şok (ZF S. 16–17; F 195–204)
    - 7. Önemli acil durumlar
    - 8. Serviste akış (ZF S. 22–25) — "hasta yerde yatıyor"
    - 9. Terimler
    - 10. Sınav bilgisi
- 09 — Bakım süreci ve klinik düşünme (Bölüm E) — şablon + işlenmiş örnek
    - 1. 6 aşama — soru ve kontrol listesi
    - 2. İşlenmiş örnek: Herr Schneider (alıştırma kitapçığınızdaki vaka)
    - 3. Frau Berger — plan taslağı
    - 4. Sınavda 6 satırlık bakım planı kalıbı
- 10 — Bakım dokümantasyonu, operatörler ve sınavda yazma (Bölüm J)
    - 1. Operatörler (Handlungsanweisungen)
    - 2. Dokümantasyonun temel ilkeleri
    - 3. Yanlış ↔ doğru
    - 4. Şablonlar
    - 5. Sınavda yazma kalıpları (Bölüm J) — örneklerle
    - 6. Sınav bilgisi / hatırlatmalar
- 11 — Mesleki Almanca için gramer ve yazma becerisi (Bölüm I)
    - 1. Artikel ve hâller (**Fälle**)
    - 2. Zamanlar
    - 3. Modalverben
    - 4. Passiv
    - 5. Yan cümleler ve bağlaçlar (**fiil sonda**)
    - 6. Konjunktiv II — nazik rica ve teklif
    - 7. Imperativ — talimat
    - 8. Nesnel dil (rapor/dokümantasyon)
    - 9. Kelime türetme
    - 10. Hata analizi yöntemi
    - 11. Alıştırmalar (cevap altta)

- 12 — Almanya'daki mesleki bağlam (Bölüm K) ve çalışma planı (Bölüm L)
  - Bölüm K — Eğitim ve meslek bağlamı
  - Bölüm L — Esnek çalışma planı
- Ek 1 — Hemşirelik sözlüğü (Almanca–Türkçe)
  - 1. Anatomi ve fizyoloji
  - 2. Hastalıklar ve belirtiler
  - 3. İlaçlar ve uygulama (belgelerde sınırlı)
  - 4. Bakım ve hijyen
  - 5. Yaşamsal bulgular
  - 6. Yara bakımı / cilt (belgelerde sınırlı)
  - 7. Beslenme ve sıvı dengesi
  - 8. Hareket ve mobilizasyon
  - 9. Acil durumlar
  - 10. Gözlem ve dokümantasyon
  - 11. İletişim ve hasta yakınları
  - 12. Etik, mahremiyet, hasta hakları
  - 13. Hukuki sorumluluklar
  - 14. Ekip ve doktorla iletişim
  - 15. Karıştırılan kelime çiftleri (Bölüm C)
- Ek 2 — Sınavda kullanılacak Almanca cümle kalıpları (Türkçe açıklamalı)
  - Hasta ile iletişim kalıpları
- Ek 3 — En önemli konuların kısa tekrar notları (tek sayfa kartları)
  - 1. Bakım temelleri → 01
  - 2. İletişim → 02
  - 3. Hijyen → 03
  - 4. Cilt → 04
  - 5. Isı → 05
  - 6. Hareket & Düşme → 06
  - 7. Profilaksiler → 07
  - 8. İlk yardım → 08
  - 9. Operatörler & dokümantasyon → 10
- Ek 4 — Flashcard seti (119 kart, Türkçe)
  - Bakım
  - İletişim
  - Hijyen
  - Cilt
  - Isı
  - Hareket
  - Düşme
  - Tromboz
  - Pnömoni
  - İlk yardım
  - Operatör
- Ek 5 — Deneme sınavları (soru kitapçığı — **cevapsız**, Türkçe)
- Klausur 1 — Bakım temelleri, bakım süreci, operatörler, dokümantasyon *(01, 09, 10)*
- Klausur 2 — İletişim, dokunma, yakınlık–mesafe *(02, 02b)*
- Klausur 3 — İlk yardım / BLS / acil durumlar *(08)* ⚠ rakamları güncel standardınızla kontrol edin
- Klausur 4 — Hareket, düşme, tromboz/pnömoni, bakım süreci *(06, 07, 09)*
- Klausur 5 — Hijyen, cilt, vücut ısısı *(03, 04, 05)*
- Ek 5b — Deneme sınavları: cevap anahtarı ve açıklamalar (Türkçe)
  - Klausur 1
  - Klausur 2
  - Klausur 3
  - Klausur 4
  - Klausur 5
- Ek 5c — Operatör formatlı vaka sınavları (Übungsheft tarzı) — **soru kitapçığı (Türkçe)**
  - Fallbeispiel A: Frau Keller *(04, 06, 07)*
  - Fallbeispiel B: Herr Hoffmann *(05, 03)*
  - Fallbeispiel C: Stajyer Lena ve Herr Roth *(03)*

    - Fallbeispiel D: Frau Weber *(02, 02b)*
    - Fallbeispiel E: Herr Lang *(08, 02b)*
    - Fallbeispiel F: Frau Berger — bakım süreci *(01, 06, 09)*
- Ek 5d — Operatör vakaları: örnek cevaplar (Türkçe açıklama + Almanca model cümle)
    - Fall A: Frau Keller
    - Fall B: Herr Hoffmann
    - Fall C: Lena ve Herr Roth
    - Fall D: Frau Weber
    - Fall E: Herr Lang
    - Fall F: Frau Berger
- Ek 6 — Klinik vaka dosyası (Bölüm G, Türkçe)
    - Vaka 1 — Frau Berger (81): değişen hareketlilik
    - Vaka 2 — Herr Schneider (78): düşme, korku, yıkanma, az içme
    - Vaka 3 — Herr Aksoy (72): yatağa bağımlı, tromboz/pnömoni riski
    - Vaka 4 — Frau Wozny: C. difficile / el hijyeni
    - Vaka 5 — Frau Demir (84): dekubitus riski ve cilt gözlemi
    - Vaka 6 — Yerde yatan hasta (hastane içi ilk yardım)
    - Vaka 7 — Johanna: „Wie alt sind Sie überhaupt?“ (iletişim)
    - Vaka 8 — Herr Becker (66): yemekte öksürme (aspirasyon profilaksisi)
- Ek 7 — Kişisel gelişim takip tablosu
    - 1. Konu takibi
    - 2. Yanlış yapılan sorular (Zayıf konu listesi)
    - 3. Almanca hata günlüğü
    - 4. Haftalık özet
    - 5. Öğretmene sorulacaklar listesi
- Ek 8 — Kaynakça ve sayfa indeksi (Türkçe)
    - 1. Yüklenen kaynaklar ve önemli sayfalar
    - 2. Dış kaynaklar (PDF dışı ek bilgi)
    - 3. Doğrulanamayan / eksik

Hemşirelik Ausbildung — Türkçe çalışma rehberi

Almanya'da **Pflegefachfrau/-mann Ausbildung** öğrencisi için, yüklediğiniz **30 ders dosyasına** (28 PDF/PPTX + 2 el yazılı fotoğraf) dayanan **Türkçe çalışma sürümü**. Açıklamalar tamamen Türkçedir; **sınavda Almanca yazacağınız terimler ve kalıplar kalın Almanca** bırakılmıştır (her bölümde "Almanca cevap kalıbı").

> ⚠ **Önce okuyun:** 00 Envanter ve çelişkiler — OCR kalitesi, eksik kısımlar ve belgeler arasındaki **çelişkiler** (ör. kalp masajı 100–120 ↔ 80–100/dk). Bu rehber **eğitim amaçlıdır**; klinik talimat veya hukuki tavsiye değildir. Gerçekte Praxisanleitung, sorumlu PFK, kurum standardı ve güncel mevzuat geçerlidir.

Kullanım sırası

01 Temeller → 10 Operatörler → konu bölümleri → Flashcards → Sınavlar ve Operatör vakaları → Takip. Plan: 12.

Bölümler

#	Dosya
00	Envanter, kaynak kalitesi, çelişkiler
01	Hemşirelik temelleri, ABEDL, bakım süreci, PflBG
02	İletişim, dokunma, yakınlık–mesafe
02b	Hasta ve ekip diyalogları
03	Hijyen, enfeksiyon, BGW
04	Hücre, doku, cilt

#	Dosya
05	Vücut ısısı, ateş
06	Hareket, düşme profilaksisi
07	Tromboz ve pnömoni profilaksisi
08	İlk yardım, BLS, AED, şok
09	Bakım süreci ve klinik düşünme
10	Dokümantasyon ve operatörler
11	Almanca gramer
12	Meslek bağlamı ve çalışma planı

Ekler

Ek 1 Sözlük · Ek 2 Sınav kalıpları · Ek 3 Özetler · Ek 4 Flashcards / CSV · Ek 5 Deneme sınavları / Cevaplar · Ek 5c Operatör vakaları / Cevaplar · Ek 6 Klinik vakalar · Ek 7 Takip · Ek 8 Kaynakça

İşaretler

⚠ = PDF'de yok / doğrulanmadı / çelişki · ***kendi önerim*** = kaynak PDF'de yok · Örnekler **kurgusaldır** (gerçek hasta verisi yok). Almanca–Türkçe karma sürüm: ../README.md

00 — Dosya envanteri, kaynak kalitesi ve çelişkiler

1. Nasıl okudum? (dürüst durum)

- Metin katmanı olanlar doğrudan okundu: `Zusammenfassung Erste Hilfe B2`, `Sturzprophylaxe.pptx`.
- Diğer tüm PDF'ler **taranmış görüntüydü** → Almanca **OCR (Tesseract)**; şüpheli sayfalar (Erste Hilfe S. 22, 140, 172) ve 2 el yazılı fotoğraf **görüntüden** kontrol edildi. OCR'dan kaynaklı küçük hatalar olabilir.
- **Eksik/yalnızca taranan:** Erste Hilfe S. 1–57 (anatomi çizimleri) ve S. 234–254 (özet tekrarı); BGW S. 21–56 (öğretmen materyali).
- **Boş çalışma kâğıtları** (LF1A Arbeitsblatt, Hygiene-Handout, Pflegias-Übung): cevaplar sizde; rehberde "örnek" diye işaretlendi.
- **PDF'lerde olmayan konular:** ilaçlar, yara bakımı (pansuman tekniği), diyabet, demans, ağrı ölçekleri, delegation, hasta hakları.
- "S." = PDF sayfası; "bas. S." = kitabın basılı sayfası.

2. Dosyalar (30)

Lernskript LF1A · Arbeitsblatt LF1A · Handlungskompetenz (I care S. 47–48) · Einstieg/Fallbeispiel/Sequenz 2–5 (iletişim) · PPP Berührung AI 02/04/05 · Arbeitsinput 06b Tabuzonen · Hyg. Grundlagen Teil I/II · Handout hygienisches Handeln · Übung Händedesinfektion · BGW Take Care Infektionsschutz (56 S.) · Haut Teil 1/2 · Thieme Körpertemperatur (36 S.) · Erwartungshorizont Bewegung im Alter · Sturzprophylaxe PPP · Thromboseprophylaxe PPP · Auszug I care Thromboseprophylaxe · Pneumonieprophylaxe PPP · Erste Hilfe (254 S.) · Zusammenfassung Erste Hilfe B2 · 2 el yazılı sayfa (Operatoren-Training, Herr Schneider).

3. Öğrenme sırası

```
LF1A Hemşirelik temelleri
 ├─ İletişim → Dokunma/Yakınlık–mesafe
 ├─ Hijyen & enfeksiyon → Cilt/doku → Vücut ısısı
 ├─ Hareketlilik → Düşme → Tromboz/Pnömoni profilaksisi
 └─ İlk yardım (kalp-dolaşım-solunum → BLS/AED → şok/acil)
Hepsi → Bakım süreci & dokümantasyon → Operatörler/sınav tekniği
```

4. Çelişkiler ve şüpheli noktalar (düzeltilmeden bırakıldı)

#	Konu	Belge A	Belge B	Öneri
1	Kalp masajı frekansı	Folie 137 "**100**/dk"; 140 ve 172 (görüntüden doğrulandı) "**80–100**/dk"	Folie 121/163 ve Zusammenfassung "**100–120**/dk"	Sınavda **100–120/dk** yaz; öğretmene sor
2	Derinlik	"5–6 cm"	Folie 140/172: "5 cm veya ½ toraks"; 163: "≥ 5, ≤ 6 cm"	5–6 cm
3	Sinüs düğümü	Zusammenfassung "60–80"	Folie 22 (görsel): "60–100/dk"	Folie 22 standart değer
4	Çocuk BLS	Folie 131 "çocuk 15:2"	Folie 121: eğitimsizse 30:2 + 5 soluk; 133: 30:2	eğitim durumuna göre
5	Çocuk derinliği	Folie 141 "4 cm"	142 "5 cm"; 133 "⅓ toraks"	⅓ toraks çapı
6	"Leitlinien 2025"	Folie 84/85 başlık "2025"	kaynak/impressum **2021 (2022 sürümü)**	öğretmene sor
7	Asystolie	Folie 122: "> 2 sn"	—	tanımı öğren ama doğrula ⚠
8	Hipotermi	"< 35 °C"	aynı sayfada "hafif 32–36 °C"	iç çelişki
9	Normal ısı	Tab. 4: 36,3–37,4 (rektal)	metin: 36–37,5	tablo rektal
10	Ateşte nabız	S. 22: 8–12/°C	S. 28: 8–10/°C	≈ 8–10 (–12)

#	Konu	Belge A	Belge B	Öneri
11	Tehlikeli ısı	S. 2: > 41 °C	S. 17: 42 °C ölüm; S. 22: 42,6 °C protein pıhtılaşması	farklı eşikler
12	Nosokomial pnömoni	P S. 4: "+24 sa"	genelde ≥ 48 sa ⚠	sor
13	Düşme standardı	PPP: "DNQP 2013"	güncel **2022** (DNQP)	2022'yi belirt
14	Yazar adı	Lernskript "Fiechter"	Arbeitsblatt "Fichter"	doğrusu **Fiechter** ⚠
15	Dermis	Skript S. 9: "Unterhaut (Dermis)"	Dermis = **Lederhaut**	yazım hatası
16	Yazım	"Letingo", "Elatinfasern"	**Lentigo**, **Elastinfasern**	
17	Thromboseprophylaxe dosyası	adı Tromboz	PDF S. 1 başı = **Pneumonie-LISA**	karışık
18	Zusammenfassung	"228 slayt"	deste 254 sayfa	ek/kaynak sayfaları
19	ESBL	T2 S. 16 "Enterokokken"	ESBL = Enterobakterien ⚠	
20	Yeterlilik modeli	Lernskript: 4 alan	I care: 3 boyut + 3 alt yeterlilik	okul modeli

Öğretmene sorun: madde 1, 8, 12, 20 ve sınav formatı.

01 — Mesleki hemşireliğin temelleri (LF 1A)

> **Kaynak:** Lernskript LF1A (S. 1–6), Arbeitsblatt LF1A, Handlungskompetenz (I care S. 47–48). **Sınav dili Almanca olduğu için** önemli terimler **kalın Almanca** yazılmıştır; her bölümün sonunda "Almanca cevap kalıbı" vardır. İşaretler: ⚠ = PDF'de yok/doğrulanmadı · *kendi önerim* = kaynak PDF'de yok.

1. Hemşirelik nedir? (Pflege)

Günlük hayatta da bakım vardır (anne çocuğuna, kızı annesine). **Mesleki bakım** ise üç şeyle farklıdır: **bilimsel/mesleki bilgiye dayanır**, **planlıdır**, **sorumluluk taşır** (ve ilişki kurmayı içerir). Hemşire gözlemler, destek ihtiyacını saptar, kişinin mevcut yeteneklerini hesaba katar, plan yapar, uygular ve etkisini kontrol eder. Kişinin istek ve alışkanlıklarına ve **özerkliğine** (**Selbstbestimmung**) saygı gösterir.

Biçim	Örnek	Özellik
Selbstpflege (kendine bakım)	kişi kendine bakar	bağımsız
Informelle Hilfe (gayriresmî yardım)	kızı annesi için alışveriş yapar	aile/arkadaş
Professionelle Pflege (mesleki bakım)	ameliyat sonrası hemşire destek verir	bilgi, sistematik yöntem, sorumluluk

> **Anahtar cümle:** Hemşirelik, kişi adına mümkün olduğunca çok şey yapmak **değildir**; sağlığı, iyi oluşu ve **bağımsızlığı** korumak/geliştirmektir.

2. Temel kavramlar

Almanca	Türkçe	Tanım
das Bedürfnis	ihtiyaç	kişinin bedensel, ruhsal, sosyal iyi oluşu için gereken şey
das Problem	sorun	hemşirelik desteği gerektirebilecek engel/zorluk
die Ressource	kaynak (güçlü yan)	kişinin sahip olduğu ve kullanabildiği yetenek, güç, olanak ya da destek
die Selbstbestimmung / Autonomie	özerklik	kişinin nasıl yaşayacağına özgürce ve sorumlulukla kendisinin karar vermesi

Hemşire sadece "Ne yapamıyor?" değil, **"Ne yapabiliyor?"** diye de sorar.

Örnek vaka: Frau Berger (78)

Düşme sonrası hastanede; sağ kalçada ağrı; yemeyi/içmeyi kendisi yapıyor; kalkarken destek gerekiyor; gözlüğü evde; "Mümkün olduğunca kendim yapmak istiyorum" diyor; yalnız yaşıyor; kızı yakında oturuyor.

Gözlem	Destek ihtiyacı	Kaynak
ağrı / dikkatli hareket	harekette güvenlik	ihtiyaçlarını söyleyebiliyor
kalkarken yardım	mobilite desteği	iş birliği yapabiliyor
gözlük yok	görme/oryantasyon güçlüğü	ihtiyacını bildirebiliyor
çoğunu kendi yapmak istiyor	özerkliğe saygı	yüksek motivasyon
yalnız yaşıyor	taburculuk sonrası destek	kızı = sosyal kaynak

3. Meslek rolü ve eylem yetkinliği (Handlungskompetenz)

Tanım (KMK 2011): Mesleki, toplumsal ve özel durumlarda **uygun ve sorumlu davranabilmek**. I care'ye göre **3 boyut** vardır, her birinin içinde 3 alt yetkinlik bulunur.

Boyut	Anlamı	Örnek
Fachkompetenz (mesleki yetkinlik)	bilgi ve beceriyle sorunları çözmek, sonucu değerlendirmek	güvenli mobilizasyonu bilmek
Personale Kompetenz / Selbstkompetenz (kişisel yetkinlik)	kendini geliştirme, sorumluluk, kendi eylemini sorgulama	transferden sonra "çok acele ettim mi?" diye düşünmek
Sozialkompetenz (sosyal yetkinlik)	ilişki kurma, empati, takım çalışması, çatışma çözme	anlaşılır anlatmak, özerkliğe saygı

Alt yetkinlikler: **Methodenkompetenz** (planlı çalışma, örn. bakım süreci), **Lernkompetenz** (bilgiyi anlamak/değerlendirmek), **kommunikative Kompetenz** (iletişim durumlarını anlamak/şekillendirmek).

> ⚠ **Terim farkı:** Lernskript "**4 yeterlilik alanı**" (Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbstkompetenz) der; I care "3 boyut + 3 alt yetkinlik". İçerik çelişmez, sadece sıralama farklı. Sınavda **okul modelini (4 alan)** yazın.

Fort-/Weiterbildung (I care S. 47): *Fortbildung* bilgiyi güncellemek; *Weiterbildung* daha kapsamlı (genelde 2 yıl, uzmanlık). **Praxisanleiter**: ≥ 300 saat pedagojik ek eğitim + yılda 24 saat Fortbildung (PflAPrV 2018) — ⚠ güncel mevzuattan doğrulayın.

4. Krohwinkel'in 13 ABEDL'i

(Alltägliche Bedürfnisse und existenzielle Erfahrungen des Lebens = günlük ihtiyaçlar ve varoluşsal deneyimler.)

No	Almanca	Türkçe
1	**Kommunizieren können**	iletişim kurabilmek
2	**Sich bewegen können**	hareket edebilmek
3	**Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können**	yaşamsal fonksiyonları sürdürebilmek
4	**Sich pflegen können**	kişisel bakım
5	**Essen und trinken können**	yeme–içme
6	**Ausscheiden können**	boşaltım
7	**Sich kleiden können**	giyinme
8	**Ruhen, schlafen und sich entspannen können**	dinlenme, uyku
9	**Sich beschäftigen, lernen und sich entwickeln können**	uğraşmak, öğrenmek, gelişmek
10	**Die eigene Sexualität leben können**	cinselliği yaşayabilmek
11	**Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können**	güvenli ve destekleyici ortam
12	**Soziale Bereiche des Lebens sichern und gestalten können**	sosyal alanlar
13	**Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen können**	varoluşsal deneyimlerle başa çıkmak

Hatırlama: 1–7 beden, 8–11 günlük yaşam/ortam, 12–13 sosyal ve varoluşsal. **Bir gözlem birden fazla ABEDL'e girebilir.** ABEDL bir **yapılandırma aracıdır; görüşmenin yerini tutmaz. Alıştırma (Frau Berger):** ağrı → 2 (ve 3, 11) · gözlük yok → 1, 11 · yalnız yaşıyor/kızı → 12 · "kendim yapmak istiyorum" → 4, 9, 13 (gerekçe yazın).

5. Bakım süreci (Pflegeprozess) — Fiechter & Meier'e göre 6 aşama

Aşama	Almanca	Soru	Frau Berger
1	**Informationssammlung**	Hangi bilgiler var?	ağrı, kalkarken yardım ihtiyacı
2	**Probleme und Ressourcen erkennen**	Zorluk? Neyi yapabiliyor?	güvensiz kalkış / iş birliği yapıyor
3	**Pflegeziele festlegen**	Neye ulaşılmalı?	destekle güvenle kalkabilsin
4	**Pflegemaßnahmen planen**	Somut ne yapılacak?	ağrı ve hareketliliği gözlemle, güvenli ortam, destek öner, onu sürece kat
5	**Durchführung**	Uygulama	birlikte uygulanır

Aşama	Almanca	Soru	Frau Berger
6	**Evaluation**	Hedefe ulaşıldı mı, plan değişmeli mi?	kalkış güvenli miydi?

Süreç bir döngüdür — değerlendirme yapılmazsa plan durumdaki değişikliğe uyarlanamaz. *Not:* Arbeitsblatt "Fichter", Lernskript "Fiechter" yazıyor; doğrusu **Fiechter**. **Hedef nasıl yazılır?** (*kendi önerim*) Hasta odaklı, ölçülebilir, tarihli: "Frau Berger 3. güne kadar bir hemşire eşliğinde güvenle kalkar ve en fazla hafif ağrı belirtir." (Ağrı ölçeği kurum standardına göre ⚠.)

6. Yasal dayanak: Pflegeberufegesetz (PflBG)

§	Konu	Özet
§ 1	**Berufsbezeichnung**	"Pflegefachfrau/Pflegefachmann" unvanı korunur; devlet izni gerekir
§ 4	**Vorbehaltene Aufgaben** (saklı görevler)	(1) bakım ihtiyacını saptamak ve bakımı planlamak; (2) bakım sürecini organize etmek/yönetmek; (3) bakım kalitesini analiz etmek, değerlendirmek, güvence altına almak
§ 5	**Ausbildungsziel**	bağımsız, kapsamlı, süreç odaklı bakım; mesleki, metodik, sosyal, iletişimsel yetkinlik; etik anlayış
§ 6	**Dauer und Struktur**	tam zamanlı **3 yıl**; Pflegeschule + uygulamalı eğitim

Dikkat: Planlanmış bir bakım işlemini **uygulamak** otomatik olarak saklı görev değildir. Arbeitsblatt alıştırması: "Bedarf saptar" → **Evet** (Nr. 1); "mevcut plana göre yıkamada destek" → **Hayır**; "süreci yönetir, planı uyarlar" → **Evet**; "etkiyi/kaliteyi kontrol eder" → **Evet**. "Hemşireler yalnızca doktor talimatını uygular" → **yanlış**: bakım sürecinin sorumluluğu hemşirededir (§ 4), doktor talimatları ek olarak ve iş birliğiyle uygulanır.

> ⚠ **Hukuki not:** PflBG metnine bu oturumda erişemedim; bilgiler Lernskript'ten. Doğrulama: gesetze-im-internet.de/pflbg. Eyalet/okul/kurum farklılık gösterebilir; **hukuki tavsiye değildir**. Delegation, hasta hakları (BGB § 630a vd.) PDF'lerinizde yok.

7. Kısa tekrar

Pflege formları · 4 yeterlilik · Bedürfnis/Problem/Ressource/Autonomie · 13 ABEDL **ezber** · 6 aşama **sırayla** · § 4'ün 3 görevi · § 1/4/5/6. **Sık hatalar:** aşamaları karıştırmak (hedef sorundan önce olmaz) · değerlendirmeyi unutmak · "yapılan = saklı görev" demek · Ressource = sorun çözmek sanmak.

8. Almanca cevap kalıpları

- „Eine Ressource ist eine Fähigkeit oder Unterstützung, die ein Mensch besitzt und nutzen kann, zum Beispiel …“
- „Professionelle Pflege unterscheidet sich von Alltagshilfe, weil sie fachlich begründet, geplant und mit Verantwortung verbunden ist.“
- „Nicht die Durchführung einer geplanten Maßnahme, sondern die Planung, Steuerung und Evaluation des Pflegeprozesses sind vorbehalten (§ 4 PflBG).“

Kontrol soruları: 1) Mesleki bakım gündelik yardımdan nasıl ayrılır? 2) Frau Berger'in iki kaynağı? 3) 13 ABEDL'i say. 4) Bakım sürecinin 6 aşaması? 5) Değerlendirme neden önemli? 6) § 4'ün üç görevi? → Cevaplar: Ek 5 Klausur 1

02 — Hemşirelikte iletişim, dokunma, yakınlık–mesafe

> **Kaynaklar:** Einstieg (9.10.2025), Fallbeispiel, Sequenz 2–5, PPP Berührung AI 02/04/05, Arbeitsinput 06b. S. = PDF sayfası. Diyalog örnekleri için 02b.

1. İletişim nedir? (Kommunikation)

Bilgi alışverişi ve anlaşma (Einstieg S. 5). I care: **gönderen (Sender) ile alıcı (Empfänger) arasında bilgi alışverişi süreci.** İletişim temel insan ihtiyacıdır; **konuşmasak da iletişim kurarız** (S. 14).

1.1 Laswell modeli

Her iletişimde **3 öğe**: **Nachricht** (mesaj), **Sender**, **Empfänger**. Roller değişir; her gönderen aynı zamanda alıcıdır. **Cevap vermeyen de bir şey gönderir.**

1.2 Dört yönlü mesaj modeli (Schulz von Thun — Vier-Seiten-Modell)

Yön (gönderenin "gagası")	Anlamı	Kulak (alıcı)	Kulağın sorusu
Sachinhalt	"Bu konuda bilgi veriyorum"	Sachverhaltsohr	"Ne söylemek istiyorsun?"
Selbstoffenbarung	"Kendim hakkında şunu bildiriyorum" (duygu, değer)	Selbstoffenbarungsohr	"Sen kimsin, nasılsın?"
Beziehungshinweis	"Birbirimizle şöyle duruyoruz"	Beziehungsohr	"Benim hakkımda ne düşünüyorsun?"
Appell	"Bunu yapmanı istiyorum"	Appellohr	"Benden ne istiyorsun?"

Sadece **bir** kulak bilgiyi duyar; diğer üçü ilişki/kendini ifade/istek arar (çoğu beden dili ve ses tonuyla). Gönderilen ≠ alınan → çatışma. **Örnek — Johanna:** Hasta: "Wie alt sind Sie überhaupt?" – Johanna: "Alt genug!"

- Sach: yaşı öğrenmek istiyor · Selbstoffenbarung: güvensiz/ağrılı/korkuyor (inliyor) · Beziehung: yetkinliğinden şüphe · Appell: "Bana dikkatli davran". **Daha iyi cevaplar:** „Ich bin im ersten Ausbildungsjahr, meine Praxisanleiterin ist die ganze Zeit dabei. Machen Sie sich Sorgen, dass etwas wehtun könnte?“

1.3 Watzlawick'in 5 aksiyomu (Sequenz 3 S. 10–13)

#	Aksiyom	Anlam	Hemşirelik örneği
1	**Man kann nicht nicht kommunizieren**	her davranış iletişimdir	sessizlik de mesaj verir
2	**Inhalts- und Beziehungsaspekt** (ilişki içeriği belirler)	içerik ile ilişki uyuşmalı	"İyi akşamlar" ama bakmadan
3	**Ursache und Wirkung (Verhaltenskette)**	herkes "başlatan öteki" sanır	"İlaçları verdim" → "yavaşsın mı demek istiyor?"
4	**Digital und analog**	dijital = bilgi; analog = jest, mimik, ton	"İyiyim" + üzgün bakış
5	**Symmetrisch / komplementär**	eşit (göz hizası) / hiyerarşik	meslektaş ↔ yatan hasta

Hatırlama (kendi önerim): **N-B-U-D-S.** ⚠ Kaynak "Interpunktion"ı ayrı adlandırmaz; 3. aksiyom aynıdır.

1.4 Sözlü / sözsüz / paraverbal

Nonverbal: beden dili, **Mimik** (7 temel duygu: sevinç, iğrenme, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, küçümseme), **Blickkontakt**, **Gestik**, **Körperhaltung**, görünüm, **mesafe**, **temas**. **Gözlem temel**

görevdir. Yorumlama hatası riski (kültür, hastalık; demansta göz teması azalır). **Kongruent** = sözlü ve sözsüz aynı; **inkongruent** = çelişkili.

1.5 Geri bildirim kuralları (S. 14)

Karşılıklı saygı · **kişiyi değil davranışı** eleştir · **Ich-Botschaft** (ben-dili) · somut durum, "hep/asla/yine/insan" gibi genellemelerden kaçın · istek formüle et.

kötü	iyi
„Sie sind schlecht erzogen.“	„Sie haben sich mir gegenüber im Ton vergriffen.“
„Du bist immer so langsam.“	„Ich mache mir Sorgen, dass wir den Zeitplan nicht schaffen. Können wir kurz absprechen, wer was übernimmt?“

Yanlış anlaşılırsa **nachfragen** (tekrar sor): „Habe ich Sie richtig verstanden, dass …?“

1.6 Resmî / gayriresmî iletişim (Sequenz 5)

Formell: planlı, kurallara bağlı, resmî, iş dili (devir-teslim, dokümantasyon, doktor görüşmesi). **Informell:** rahat (meslektaşla sohbet, SMS, telefon).

2. Selamlama, sessizlik, konuşmayı başlatma/bitirme (Sequenz 2)

- **„Wer spricht, pflegt bereits.“** Konuşmak zaten bakımdır; her kelime etki eder, geri alınamaz. **Nicelik değil nitelik** önemli. Hemşire görüşmenin sorumluluğunu hastadan **daha çok** taşır.
- **Selamlama** ilişkinin güven/güvensizlik yönünü belirler (Mantz 2014).
- **Fall Simon/Renate:** Hemşire sessizce odaya girip tansiyon/şeker/ayak kontrolü yapıyor, "Die redet nie." diyor → eksik: kendini tanıtma, açıklama, onay, göz teması; sessizliğin nedeni sorgulanmadı. Daha iyisi: kapıyı çal, tanış, açıkla, TV'yi kıs, işitme/depresyon/dil sorununu düşün, gözlemi ilet.
- **Fall Maria/Eva:** "Und jetzt noch den Popo!" → çocuklaştırıcı, mahremiyeti zedeler. Daha iyisi: „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“
- **Sessizlik nedenleri (öneri):** utangaçlık, işitme/konuşma bozukluğu (afazi), depresyon, demans, yas, güvensizlik. **Çözümler:** zaman tanı, açık sorular, sessizliğe katlan, **„Eisbrecher“** (komodin üzerindeki eşyalar), gözlemi ilet.
- **Konuşmayı bitirme:** özetle, teşekkür et, "14'te tekrar geleceğim", nazikçe sözü kes: „Ich merke, wie wichtig Ihnen das ist. Ich muss jetzt zu … Darf ich später wiederkommen?“

3. Duruma uygun dil ve çocuklaştırıcı dil (infantilisierende Sprache)

Dil kişiye ve duruma uygun olmalı (örn. intim bakım). Çocuklaştırıcı dil (bebek dili, "Opi", "wir" yerine "Sie") onuru zedeler.

uygunsuz	uygun
„Na, haben wir schön gegessen?“	„Hat es Ihnen geschmeckt?“
„Opi, jetzt Pillen!“	„Herr Müller, es ist Zeit für Ihre Tabletten.“

Anahtar: Dil ilaç gibidir — doz, ton ve içerik doğru olmalı.

4. Dokunma, yakınlık ve mesafe (LF 3a)

4.1 Kavramlar (AI 02 S. 3)

berühren (temas kurmak) · **anfassen** (elle tutmak) · **tasten** (el yordamıyla yoklamak) · **fühlen** (hissetmek). „Anfassen ist simpel, Berührung ist Kunst.“

4.2 Hemşirelik bir "dokunma mesleğidir"

Dokunma tansiyon ölçerken, EKG'de, bakımda, kan almada sürekli olur. Eller **sözsüz iletişim aracıdır**. Önemi: **güven/güvenlik** (özellikle demans), **iletişim** (sakinlik, acele, empati, stres), **iyi oluş**, **fizyolojik**

etki (oksitosin → bağ, stres azalır). Teselli eder, sakinleştirir, korkuyu azaltır. **Uygulama: Initialberührung** (omuza el koymak → yönelim/güven) · bakım eyleminin **bilinçli başlangıcı ve sonu** · **dikkatli bakım**: dokunuş yumuşak/sağlam, **geniş yüzeyli** (cımbız tutuşu değil) · "düşünceleri ellerde taşımak" · kendi ihtiyaçlarına dikkat. **Güvenlik:** önceden duyur, onay al, tepkiyi gözle (mimik, gerginlik); reddederse dur/uyarla.

4.3 Yakınlık ve mesafe (Nähe und Distanz)

Duygusal, mekânsal, sosyal ilişki. Yakınlık: aidiyet, güven, empati (yardım ilişkisinin koşulu). Mesafe: dengeyi ve **kendini korumayı** sağlar. **Profesyonel ilişki: Akzeptanz** (kabul), **Kongruenz/Echtheit** (içtenlik), **Empathie**, **Annehmen ohne Wertung** (yargısız kabul). **Kuruculuk hemşiredir. Dengeyi bulmak:** güvenli ortam · kendi duygularıyla başa çıkma · empati · konuşmayı zorlamama · sözsüz işaretleri izleme · özenli temas.

4.4 Hall'un mesafe bölgeleri

Kaynak 4 bölgeyi anar: **intime, persönliche, soziale, öffentliche Zone**. ⚠ *Sayısal değerler PDF'de yok (genel bilgi):* intim ≈ 0,5 m'ye kadar, kişisel ≈ 0,5–1,2 m, sosyal ≈ 1,2–3,6 m, kamusal > 3,6 m. Bakım çoğu zaman **intim bölgede** olur → duyur, izin iste, perde kullan, **kültürel farkları** düşün.

4.5 Tabuzonen (Morris)

Arbeitsinput 06b: hangi bölgeler sizin için sorunsuz? İlişkiye (yabancı/arkadaş/aile) ve cinsiyete göre fark var mı? Prezi içeriği PDF'de yok ⚠ — derste tamamlayın.

5. Terimler

Almanca	Türkçe
der Sender / der Empfänger	gönderen / alıcı
der Sachinhalt	konu içeriği
die Selbstoffenbarung	kendini açma
der Beziehungshinweis	ilişki mesajı
der Appell	istek/çağrı
verbal / nonverbal / paraverbal	sözlü / sözsüz / ses tonu
kongruent / inkongruent	uyumlu / uyumsuz
die Ich-Botschaft	ben-dili
nachfragen	tekrar sormak
die Intimsphäre	mahremiyet
die Initialberührung	başlangıç dokunuşu
die Wertschätzung	değer verme

6. Sınav bilgisi

- **Vaka analizi:** önce **Ereignis** (olay: hangi bilgiler, neler etkiliyor), sonra **Beurteilung** (iyi/kötü), sonra **Konsequenz** (nasıl daha iyi olurdu) — Einstieg S. 4.
- Modelleri **ismen** yazın ve vakaya uygulayın.
- **Hatalar:** 4 yön ile 4 kulağı karıştırmak · mimiği kesin gerçek saymak · "sessizlik = ihtiyaç yok" · intim bakımı duyurmadan yapmak. **Almanca kalıplar:** „Nach dem Vier-Seiten-Modell kann die Frage … auf vier Ebenen verstanden werden: …“ · „Die Äußerung ist problematisch, weil sie infantilisierend ist und die Intimsphäre nicht wahrt.“ **Kontrol:** 1) Mesajın 4 yönü? 2) Axiom 3'ü takım çatışmasında açıkla. 3) 3 geri bildirim kuralı. 4) Initialberührung nedir? 5) Çok konuşan hastayı nasıl nazikçe bitirirsin?

02b — Pflegedeutsch: Hasta ve ekip iletişimi (Türkçe açıklamalı)

Kurgusal eğitim örnekleri. Gerçekte kurum standardı ve sorumlu hemşire geçerlidir. **P** = hemşire/stajyer, **Pat.** = hasta. Almanca cümleleri **sesli** tekrar edin. **Genel kurallar:** *Sie* hitabı · isim kullan · nazik rica için **Konjunktiv II** („Könnten Sie …?“) · kısa cümleler · **önce duyur, sonra yap** · anlaşıldı mı diye sor · mümkünse basit dil (Bluthochdruck, Hypertonie yerine).

#	Durum	Almanca (örnek)	Türkçe anlamı	Dil notu
D1	Karşılama	„Guten Morgen, Frau Berger. Mein Name ist …, ich bin Auszubildende zur Pflegefachfrau und heute für Sie da. Darf ich hereinkommen? Wie möchten Sie angesprochen werden?“	Günaydın … Adım …, hemşirelik stajyeriyim ve bugün sizinle ilgileniyorum. İçeri girebilir miyim? Size nasıl hitap edeyim?	*Darf ich + Infinitiv* (Modalverb); *angesprochen werden* = Passiv
D2	Kimlik/ihtiyaç	„Bitte sagen Sie mir Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Haben Sie Allergien? Brauchen Sie eine Brille oder ein Hörgerät? Was möchten Sie gern selbst machen?“	Adınızı ve doğum tarihinizi söyler misiniz? Alerjiniz var mı? Gözlük/işitme cihazı? Neyi kendiniz yapmak istersiniz?	açık soru ile kimlik doğrulama
D3	Ağrı	„Haben Sie Schmerzen? Wo genau? Stechend, dumpf oder brennend? Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie stark?“	Ağrınız var mı? Tam nerede? Saplayıcı, künt, yanıcı? 0–10 arası kaç?	**Schmerzen haben ↔ äußern**: hasta *hisseder* ↔ *bildirir*; dokümantasyonda „Pat. äußert …“. İlaç/doz **sadece doktor talimatıyla**
D4	Yaşamsal bulgular	„Ich möchte jetzt Ihre Temperatur messen. Das geht im Ohr und dauert nur wenige Sekunden. Ist das in Ordnung? Danach messe ich Blutdruck und Puls. Bitte entspannen Sie den Arm.“	Şimdi ateşinizi ölçeceğim … Uygun mu? Sonra tansiyon ve nabız …	önce bilgi ver (Thieme S. 13–14)
D5	Mobilizasyon	„Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Rutschen Sie bitte langsam an die Bettkante. Stellen Sie die Füße fest auf den Boden. Auf drei stehen wir gemeinsam auf. Ist Ihnen schwindelig?“	Kalkmanıza yardım edeceğim … Başınız dönüyor mu?	Imperativ (Sie-Form). **Fren kilitli, kaymaz ayakkabı, yol açık**; baş dönmesinde devam etme → hemşireye bildir
D6	Kişisel hijyen/mahremiyet	„Würden Sie lieber selbst Ihr Gesicht und die Arme waschen? Ich übernehme den Rücken. Ich decke nur die Stelle auf, die ich wasche. Es ist mir unangenehm, sagen Sie? Das verstehe ich.“	Yüzünüzü ve kollarınızı kendiniz yıkamak ister misiniz? … Sadece yıkadığım yeri açarım …	**Konjunktiv II**; „Popo“ yerine „Intimbereich“
D7	Doktora bildirim (**SBAR**)	„**S**ituation: Bei Herrn Schneider, Zimmer 12, ist die Temperatur seit heute Morgen von 37,2 auf 38,6 °C gestiegen. **B**ackground: 78 Jahre, gestern Hüft-OP, wenig getrunken. **A**ssessment: Er schwitzt, ist unruhig, Puls 104.	Durum – Geçmiş – Değerlendirme – Öneri (rakamlar kurgusal)	**Perfekt** (ist gestiegen); sayısal veri, yorum değil

#	Durum	Almanca (örnek)	Türkçe anlamı	Dil notu
		Recommendation: Ich bitte um ärztliche Beurteilung und Anordnung.“		
D8	Vardiya devri	„Zimmer 5, Frau Berger, 78, Z. n. Sturz, Schmerzen rechte Hüfte, NRS 4 nach Schmerzmittel laut Anordnung, Mobilisation mit Rollator und Begleitung, einmal Schwindel, Trinkprotokoll läuft, offen: Brille bringen lassen.“	5 numaralı oda …	Nominalstil/kısa cümle; **yapılmayanı yapılmış gibi söyleme**
D9	İlaç sorusu	„Das darf ich nicht allein beantworten. Ich frage die zuständige Pflegefachkraft und komme gleich zurück.“	Buna tek başıma cevap veremem; sorumlu hemşireye soruyorum.	Stajyer **tıbbi bilgi/doz vermez**
D10	Talimatı netleştirme	„Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Meinen Sie, dass ich Frau Berger erst nach dem Frühstück mobilisieren soll?“	Pardon, doğru anladım mı emin değilim …	*ob*-Nebensatz; nachfragen = profesyonellik
D11	Hata/risk/acil	„Mir ist aufgefallen, dass ich die Bettbremse nicht festgestellt habe. Es ist nichts passiert, aber ich möchte es melden.“ · Sturz: „Frau Berger ist gestürzt! Bitte kommen Sie sofort in Zimmer 5!“ · Acil: „Hilfe! Herr X reagiert nicht und atmet nicht normal! Reanimationsteam und Defibrillator!“	Hata: açık, suçlamasız bildirim; düşme; kardiyak arrest	hata kültürü ⚠ PDF'de yok
D12	Hasta yakını	„Aus Datenschutzgründen darf ich Ihnen ohne Zustimmung Ihrer Mutter keine Auskunft geben. Ich frage sie gern. Zu den Besuchszeiten kann ich Ihnen etwas sagen.“	Veri koruma nedeniyle annenizin onayı olmadan bilgi veremem …	**Schweigepflicht/Datenschutz** ⚠ ayrıntı PDF'de yok

Mündlich (sözlü) simülasyon soruları

1. Hastaya kendini tanıt ve tam vücut yıkamayı duyur. 2) Ateş 38,6 °C: ne yaparsın, kime bildirirsin? 3) Hasta ansprache'a yanıt vermiyor: ilk yardım adımları? 4) Yakınına bilgi veremeyeceğini açıkla. **Değerlendirme:** yapı, nezaket (Konj. II), terim, güvenlik, yetki sınırı.

03 — Hijyen, enfeksiyonlar, enfeksiyondan korunma (LF 3a)

> **Kaynaklar:** Hyg. Grundlagen Teil I (T1) / Teil II (T2), Handout (H), Übung, BGW Take Care (2018). S. = PDF sayfası.

1. Hijyen (Hygiene)

Sağlığı koruma ve geliştirme bilimi; enfeksiyonları önlemeyi/mücadeleyi de kapsar (T1 S. 2). **Alt dallar (T1 S. 3): Persönliche Hygiene** (kişisel temizlik), **Psychohygiene** (ruh sağlığı), **Umwelthygiene** (hava/su/toprak), **Sozialhygiene** (sağlık ve sosyal çevre), **Krankenhaushygiene** (klinikte enfeksiyon önleme). **Amaç:** zararlı mikroorganizmalarla teması önlemek ve sayılarını zarar vermeyecek düzeye indirmek.

2. Enfeksiyon kavramları ve bulaş yolları

Almanca	Türkçe	Açıklama
Kolonisation	kolonizasyon	etkenler cilt/mukoza/yarada yerleşir, **belirti yok**
Infektion	enfeksiyon	etkenler girer, çoğalır, **savunma reaksiyonu**
endogen	endojen	etken **zaten vücutta** (bağırsak/cilt florası), yer değiştirir (örn. E. coli bağırsak → kan)
exogen	eksojen	etken **dışarıdan** (insan, nesne, hayvan)
direkt	doğrudan	temas (eller), damlacık, havadan (aerogen; damlacık çekirdeği ≈ 5 µm, örn. TB)
indirekt	dolaylı	**aracı** ile: toz, su, nesne, yiyecek, yüzey, giysi, dosya, kişi, vektör (böcek)
nosokomial	hastane kaynaklı	hastane/bakım evinde kazanılan; sık: kateter enfeksiyonu, pnömoni, yara enfeksiyonu

Giriş kapıları (T1 S. 7): ürogenital, intrauterin (plasenta), **perkutan** (cilt), **permukös** (mukoza), **inhalativ**. **Etkenler:** virüs, bakteri, mantar, parazit.

> **Bulaşın en büyük riski ve ana yolu: eller** (T1 S. 9; BGW S. 7).

3. Bakım personelinin kişisel hijyeni (T1 S. 9)

Temiz beden/giysi · yalnızca **iş kıyafeti** (dezenfekte yıkanan veya **95 °C**) · **el/ön kol takısı çıkarılır** (BGW: yüzük, alyans, saat, piercing, dostluk bilekliği dahil) · tırnak kısa/yuvarlak, parmak ucunu geçmez, **oje/takma tırnak yok** · iş öncesi ve tuvaletten sonra el yıkama/dezenfeksiyon · el/kol yaraları örtülü · öksürürken/hapşırırken mesafe ve yön değiştirme.

4. El hijyeni (Händehygiene)

3 adım: yıka – dezenfekte et – bakım yap.

- **Yıkama gerekir:** iş başı, gözle görülür kirlilik, tuvaletten sonra, hapşırma/öksürme/burun silme sonrası.
- **Sonuç (H S. 7):** gereksiz yıkamadan kaçın, **el dezenfeksiyonunu tercih et** (cildi korur).
- **İstisna: Clostridioides difficile** (spor yapar) — olağan dezenfektanlar etkisiz → **koruyucu giysi + dezenfeksiyon VE iyice yıkama** (mekanik uzaklaştırma); odaya uyarı levhası.

4.1 WHO'ya göre el dezenfeksiyonunun 5 anı (T1 S. 17)

1. **Hasta temasından önce** · 2) **aseptik işlemlerden önce** (enjeksiyon, infüzyon, yara bakımı) · 3) **enfekte materyalle temastan sonra** (kan, salgı, boşaltım) · 4) **hasta temasından sonra** · 5)

hasta çevresiyle temastan sonra. *Hatırlama (kendi önerim):* **V-A-I-N-U.** BGW ek: iş başı, yiyecekten önce, tuvaletten sonra, **eldiven takılmış olsa bile**.

4.2 Hijyenik el dezenfeksiyonu (BGW S. 8; T1 S. 15)

Takı çıkar · eller **tamamen kuru** (seyrelme olmasın) · avuca **yeterli miktar** · **tüm bölgeler ıslak kalsın** · **etki süresi ≥ 30 sn** (üretici bilgisi) · eldivenden sonra da yap. **6 adım:** ① avuç avuca ② sağ avuç sol el sırtında ve tersi ③ parmaklar kenetli avuç avuca ④ parmak dış yüzleri karşı avuca ⑤ başparmağı dairesel ovma ⑥ parmak uçlarını avuçta dairesel ovma. **Islanmayan bölgeler (H S. 6):** çoğunlukla **başparmak ve parmak uçları**, parmak araları. **Deney (Übung):** boya + eldiven + gözler bağlı → ıslanmayan alanların krokisi (Pflegias S. 533–538).

4.3 Cilt koruma

Sağlam cilt bariyerdir. **Tehlikeler:** sabun yüzeyaktifleri (tenside) kurutur, kokular tahriş eder, **uzun eldiven** teri hapseder (cilt şişer), alkollü dezenfektan hasarlı ciltte yanma yapar. **Önlem:** bezelye büyüklüğünde krem; **görevde hızlı emilen, görev sonrası zengin krem**; dezenfektandaki yağlayıcı bakımın yerini tutmaz; sorun olursa **işyeri hekimi**.

5. Eldiven ve koruyucu giysi

- Eldiven kutusuna uzanmadan önce **hijyenik el dezenfeksiyonu**.
- **Çıkarma:** bilekten aşağı doğru (cilt dış yüze değmesin), tersyüz, iç içe, hemen atık, ardından **dezenfeksiyon**. **Eldiven dezenfeksiyonun yerini tutmaz** (mikro delikler, çıkarırken bulaş).
- **Koruyucu giysi:** hem bakım personelini hem hastayı korur; **hastaya özgü** giyilir, hastalar arasında değiştirilir; kirlenebilecek her yeri örter (**kirlilik görünmeyebilir**); işveren sağlar/temizler; **eve yıkamaya götürülmez**.
- **Arbeitshygiene:** hijyen standartları, alet/eldiven kullanımı (pansumanda), kurum planına göre giysi, atıkların doğru atılması.

6. Mikrop azaltma

Yöntem	Etki
Reinigung (temizlik)	görünür kiri ve **%80'e kadar** mikrobu uzaklaştırır
Desinfektion (dezenfeksiyon)	etkenlerin çoğunu öldürür → **mikrop azaltılmış, steril değil** (el, cilt/mukoza, yüzey, alet)
Sterilisation (sterilizasyon)	**tüm** çoğalabilen mikroorganizmaları yok eder → **steril**

Yüzey dezenfeksiyonu: ne? etki süresi? hangi etken? **Hijyen planı**na uy (madde, konsantrasyon, süre, kim); eldiven, konsantrede gözlük; Gefahrstoffverordnung/Betriebsanweisung. Örnek plan (T1 S. 13): "nachtrocknen yok"; ⚠ OCR'daki rakamlar kesin değil.

7. Enfeksiyon belirtileri: 5 iltihap bulgusu

Rubor (kızarıklık), **Tumor** (şişlik), **Calor** (ısı artışı), **Dolor** (ağrı), **Functio laesa** (fonksiyon kaybı). Nedeni (genel bilgi ⚠): damar genişler (kan↑ → kızarıklık/ısı), sıvı geçer (şişlik → sinirlere baskı = ağrı) → işlev kısıtlanır. Örnek: **Panaritium**. **Infektion ↔ Entzündung:** enfeksiyon = etken girişi; **iltihap = doku tepkisi** (etkensiz de olabilir).

8. Çoklu dirençli etkenler (MRE)

Birkaç antibiyotiğe dirençli; nedeni gereksiz antibiyotik kullanımı. **MRSA** (metisiline dirençli *S. aureus*), **VRE**, **ESBL** (⚠ T2'de "Enterokokken" yazıyor; doğrusu genel olarak **Enterobakterien**), **MRGN** (2/3/4 antibiyotik grubuna direnç). **MRSA taşıyıcılığı:** burun girişi, boğaz, koltuk altı, kasık; çoğu belirtisiz; ana bulaş **eller**; risk: kateter, kronik yara, bağışıklığı zayıf. **Risk faktörleri (T2 S. 17):** ağır hasta, immobil, çok genç/yaşlı, cilt yaraları (dekubitus), invaziv işlemler, sık hastane/bakım evi, MRE'li kişiyle temas, tekrarlayan antibiyotik.

9. İş güvenliği (BGW 2018)

Konu	Özet
Nadelstichverletzung (NSV)	kontamine alet batma/kesme/çizme; **kanasa da kanamasa da**; NSV'lerin %50–75'i hemşirelerde
Bulaş riski	**HBV ≈ %30, HCV ≈ %3, HIV ≈ %0,3**
Nedenler	stres, dar alan, aletin hemen atılmaması, dolu atık kutusu, **Recapping** (kapağa geri takma)
Önlem	sakin çalışma, **güvenli aletler**, kullanan kişi **hemen** uygun kapta atar
Acil önlem (Leitfaden S. 20)	kan akışını sağla, yarayı/mukozayı bol **su/NaCl ile yıka ve dezenfekte et → hemen doktor/Durchgangsarzt**, HBV/HCV/HIV riskini saptat, **HIV-PEP ≤ 2 saat**, HBV bağışıklaması, BGW/kaza sigortasına bildir, işyeri hekimi takibi, **dokümante et**
Hepatit B aşısı	arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV) kapsamında işverence teklif edilir
Tüberküloz	aerojen; temasta **FFP2**
Skabies	akar; belirti 2–5 hafta sonra (gece kaşıntı); belirtisizken bulaştırır; eldiven+önlük; el dezenfeksiyonu/yıkama **tek başına koruma değil**; ≥ 2 bağlantılı vakada sağlık müdürlüğüne bildirim (§ 36 IfSG)
Yasal çerçeve	ArbSchG, MuSchG, JArbSchG, IfSG, DGUV Vorschrift 1, ArbMedVV, BioStoffV, TRBA 250/400/460–466

Fall Johanna (BGW S. 18, 23): A–D tepkilerinin **hiçbiri tam doğru değil**; doğru: kanı akıt/yıka/dezenfekte et **ve** doktor, bildirim, dokümantasyon. ⚠ Hukuki tavsiye değildir; güncel bilgi RKI/KRINKO/BGW/IfSG/kurum standartları.

10. Terimler

Almanca	Türkçe
die Händedesinfektion (HD)	el dezenfeksiyonu
die Einwirkzeit	etki süresi
die Benetzungslücke	ıslanmayan alan
die Schutzkleidung	koruyucu giysi
der Hygieneplan	hijyen planı
die Hygienefachkraft	hijyen uzmanı
die Nadelstichverletzung	iğne batması yaralanması
die Postexpositionsprophylaxe (PEP)	maruziyet sonrası profilaksi
nosokomial	hastane kaynaklı
multiresistent	çoklu dirençli

Karıştırılanlar: Infektion ↔ Entzündung · Kolonisation ↔ Infektion · Reinigung ↔ Desinfektion ↔ Sterilisation · Händewaschen ↔ Händedesinfektion · endogen ↔ exogen.

11. Sınav bilgisi

Sık sorular: 5 an · HD adımları + 3 ıslanmayan bölge · neden eldivenden sonra HD · C. diff'te neden ek yıkama · NSV sonrası ilk adımlar · temizlik/dezenfeksiyon/sterilizasyon. **Hatalar:** eldiven ile HD'yi eşitlemek · ıslak elle dezenfeksiyon · takı/saat · yıkamayı HD'den **önce** yapmak · aynı önlükle birkaç hasta. **Almanca kalıplar:** „Bei Clostridioides difficile reicht die Händedesinfektion nicht aus, weil das Bakterium Sporen bildet; daher müssen die Hände zusätzlich gründlich gewaschen werden.“ · „Handschuhe ersetzen die hygienische Händedesinfektion nicht.“ **Kontrol:** 1) Nosokomial enfeksiyon nedir? 2) 5 an? 3) Etki süresi? 4) Neden takı çıkarılır? 5) NSV sonrası ne yaparsın?

04 — Hücre, doku, cilt ve cilt değişiklikleri (LF 3a)

> **Kaynaklar:** Haut Teil 1 (T1, 4 S.), Haut Teil 2 (T2, 10 S.). S. = PDF sayfası.

1. Hücre (Zelle) — T1

Yaşamın en küçük birimi (metabolizma, büyüme, hareket, sinyal iletimi, çoğalma, kalıtım). **Zellmembran** (zar), **Zytoplasma**, **Zellkern** (çekirdek). **Çekirdeksiz:** alyuvar (**Erythrozyten**) ve trombosit (**Thrombozyten**).

Organel	Görev
Zellmembran	sınır, koruma, seçici madde alışverişi, iletişim
Zellkern	yönetim merkezi, DNS
Mitochondrien	enerji (ATP): glukoz + O_2 → ATP + su + ısı + CO_2 = **innere Atmung** (iç solunum)
Ribosomen	protein üretimi
Lysosomen	atık sindirimi
ER (kaba/düz)	madde taşıma; kaba = protein, düz = yağ
Golgi-Apparat	protein işleme/sıralama/taşıma
Zentrosomen	hücre iskeleti, bölünme

Hücre döngüsü: büyüme → bölünme → farklılaşma (**Differenzierung**) → **Apoptose** (programlı hücre ölümü). **Mitose:** vücut hücreleri; 1 ana hücre → **2 aynı** yavru hücre; büyüme, onarım, **yara iyileşmesi**. **Meiose:** üreme hücreleri; **4 farklı** hücre; sadece yumurtalık/testis. *Hatırlama (kendi önerim):* Mitoz = 2 aynı · Mayoz = 4 farklı.

2. Doku (Gewebe)

Uzmanlaşmış hücreler + hücre dışı matriks. **Hücre → doku → organ → organ sistemi → organizma. 4 temel doku: Epithel**, **Bindegewebe** (bağ; yağ ve destek dokusu: kıkırdak, kemik), **Muskel**, **Nerven**. Cilt = epitel + bağ + yağ dokusu.

- **Epitel:** sınır yüzeyleri/organ örtüsü, **damarsız** (difüzyonla beslenir), bariyer, salgı, emilim, duyu işlevi.
- **Bağ dokusu:** biçim/destek, doku bağlama, boşluk doldurma, su ve yağ depolama, savunma, **yara iyileşmesi**.

3. Cilt (Haut) — T2

En büyük organ (≈ 1,5–2 m²). **İşlevleri:** koruma, ısı düzenleme, duyu organı, bağışıklık, enerji/su deposu, **D vitamini yapımı**; ayrıca iletişim/dokunma, duygu ifadesi, kimlik/özdeğer, %1–2 gaz alışverişi. **İki cilt türü: Leistenhaut** (≈ %4; avuç içi/ayak tabanı, parmak izi, ter bezi, tüysüz) · **Felderhaut** (≈ %96; ince, tüylü, yağ ve ter bezli).

Katman	Yapı	İşlev
Oberhaut (Epidermis)	boynuzlaşan yassı epitel, **damarsız**; Keratinozyten (boynuz), **Melanozyten** (pigment/UV), **Langerhans-Zellen** (bağışıklık), **Merkelzellen** (dokunma)	su bariyeri, UV koruması, **Säureschutzmantel pH 5,5**, mekanik koruma
Lederhaut (Dermis)	bağ dokusu (kollajen, elastin); damar, sinir/reseptör, yağ-ter bezi, kıl kökü	sağlamlık, elastikiyet, epidermisi besler, su deposu
Unterhaut (Subkutis)	yağ dokusu (yapı/depo yağı); **Vater-Pacini-Körperchen** (titreşim)	yalıtım, yastık, enerji deposu

Isı düzenleme: hedef çekirdek 37 °C; **Hypothalamus**. Soğukta titreme, tüylerin dikleşmesi, **Vasokonstriktion**, yağ yalıtımı; sıcakta **Vasodilatation**, terleme. **Mukoza (Schleimhaut):** epitel + bağ; **boynuz tabakası yok** (daha hassas), kanlanması iyi; bariyer, bağışıklık, emilim. **Bakım:** kuruluk,

kızarıklık, pas için kontrol; intim bakım sadece su/özel ürünle. **Hautanhangsgebilde:** saç/kıl, tırnak (keratin; parmak ucu koruması), yağ bezi, ter bezi (ısı), koku bezi (hormonal, ergenlikten itibaren). Tırnak değişiklikleri (**Tüpfelnägel** = psoriasis, **Uhrglasnägel** = kronik O_2 eksikliği) → gözlemle, bildir.

4. Hemşirelikte cilt gözlemi (sınav için kritik)

Parametre	Bulgu	Anlamı
Turgor (el sırtında cildi kaldır)	normal: hemen geri döner · **azalmış**: birkaç sn ayakta kalır · **artmış**: gergin, şiş	sıvı eksikliği (**Exsikkose**) / iltihap, ödem
Blässe	solukluk	düşük tansiyon, **anemi**, dolaşım sorunu
Rötung	kızarıklık	efor, heyecan, **iltihap**
Zyanose	morarma; önce **dudak ve tırnak**	**oksijen eksikliği**
Ikterus	sarılık (cilt, göz)	bilirubin ↑
Koyu ciltte zyanose	melanin maskeler → **gri**, kestane tırnak, ağız çevresi soluk; **dil, diş eti, ağız mukozası, konjonktiva** kontrol	gözden kaçabilir!
Recap-Test	tırnağa 5–10 sn bas; renk **< 2–3 sn**'de döner	**> 2–3 sn** = dolaşım sorunu, şok, susuzluk

Yenidoğan sarılığı: 3.–6. gün, ~10 günde geçer; 1. günde ya da uzun sürerse doktor.

5. Dekubitus (bası yarası)

Uzun süreli **basınç + dolaşım bozukluğu**. **Erken belirti: bası ile geçmeyen kızarıklık**; ilerleyince kabarcık → açık yara → derin doku. **Sık yerler: Kreuzbein** (sakrum), **topuk**, kalça. **Fingertest: negatif** = kızarıklık basıda solar, bırakınca döner → dolaşım sağlam ama risk var; **pozitif** = basıda kalır → hasar var (**Kategorie I**). Bağlantı: immobilite → dekubitus. ⚠ Önleme ayrıntıları (pozisyon vb.) PDF'lerde yok → DNQP Dekubitusprophylaxe.

6. İyi/kötü huylu değişiklikler; ABCDE kuralı

İyi huylu: **Nävus**, **Lentigo** (yaşlılık lekesi; Skript'te "Letingo"), **seborrhoische Keratose**, **Fibrom**, **Hämangiom**. Kötü huylu (**doktora**): **Basaliom** (en sık, yavaş), **Spinaliom** (güneş hasarı, metastaz mümkün), **malignes Melanom** (agresif, erken metastaz). **ABCDE: A**symmetrie · **B**egrenzung unscharf · **C**olor (çok renk) · **D**urchmesser > 5 mm · **E**ntwicklung (değişim). Hemşire gözlemler, bildirir.

7. Yaşa bağlı özellikler

Bebek cildi: ince, ter/yağ bezleri olgunlaşmamış (⚠ ter 6–8. aydan sonra), asit koruyucu tabaka yetersiz, UV koruması az, **ısı düzenleme olgunsuz → kahverengi yağ**. **Yaşlı cildi:** kollajen, hyaluron, elastin ↓ → kuru, esnek değil, **turgor ↓**; ilaçlar (kortizon, betablokerler, kolesterol/idrar söktürücü, iltihap önleyiciler) **Xerosis cutis** yapabilir. ⚠ T2 S. 9'da "Unterhaut (Dermis)" yazılmış; doğrusu **Lederhaut**.

8. Terimler

Almanca	Türkçe
die Oberhaut / Lederhaut / Unterhaut	epidermis / dermis / deri altı
die Schleimhaut	mukoza
der Turgor	cilt gerginliği
die Exsikkose	dehidratasyon
die Zyanose	morarma
der Ikterus	sarılık
der Dekubitus	bası yarası
der Säureschutzmantel	asit koruyucu tabaka

Dokümantasyon örneği: „Kreuzbein: Rötung ca. 3 × 2 cm, auf Fingerdruck nicht wegdrückbar.“ (nesnel, ölçülebilir)

9. Sınav bilgisi

Hatalar: Dermis = Unterhaut sanmak · koyu ciltte zyanoz kaçırmak · Fingertest yönünü ters yorumlamak · Epitelin damarlı olduğunu söylemek (yanlış) · Mitoz/Mayoz karıştırmak. **Almanca kalıp:** „Ein verminderter Hautturgor weist auf einen Flüssigkeitsmangel hin.“ **Kontrol:** 1) 3 katman + işlev. 2) Turgor nasıl test edilir? 3) Fingertest ne zaman pozitif? 4) ABCDE? 5) Koyu ciltte zyanoz neden gözden kaçar?

05 — Vücut ısısı, ateş, hipotermi/hipertermi

> **Kaynak:** Thieme CNE.online "Veränderung der Körpertemperatur" (K. Genz), 36 S.; ek: Haut Teil 2 S. 3. S. = kaynak sayfası.

1. Fizyoloji (S. 2–4)

Körperkerntemperatur (çekirdek: kafa, göğüs, karın içi) ≈ **37 °C**, yaşam için şart; **< 35 °C veya > 41 °C yaşamı tehdit eder**. **Körperschalentemperatur** (kabuk: ekstremite, cilt, deri altı) **28–37 °C** arasında oynar. **Hypothalamus** (ısı merkezi) **Istwert** (mevcut) ile **Sollwert** (hedef) karşılaştırır.

Çok soğuk (Ist < Soll)	Çok sıcak (Ist > Soll)
organ metabolizması ↑, **titreme**, ısı kaybı ↓ (**Vasokonstriktion**)	ısı kaybı ↑ (**Vasodilatation**), **terleme**

Denge: ısı üretimi + alımı = ısı kaybı → sabit. **Özel gruplar:** *yenidoğan*: terleme/titreme yok, **kahverengi yağ** ile ısınır → sıvı eksikse **Durstfieber**; *yaşlılar*: yetersiz beslenme/hareket, damar elastikiyeti → düzenleme bozulur, genelde **daha düşük** ısı. **Termometresiz ipuçları:** kızarıklık/solukluk, tüyler diken diken, titreme, **Schüttelfrost**, terleme, idrar ↓, genel durum kötü, iştahsızlık, susuzluk. **Alna el koymak ölçümün yerini tutmaz.** Çocuklar ateşliyken oynayabilir.

2. Ne zaman / nereden ölçülür? (S. 5–14)

Endikasyon: şüphe; rutin 1–2×/gün (kurum standardı, yeni kabul); **sık** ölçüm: enfeksiyon/zayıf savunma, tedavi etkisi, ameliyat/damar yolu sonrası, komplikasyon, ısı değişikliği belirtisi, ısı düzenleme/bilinç bozukluğu. **En doğru: rektal.** Diğer yerler **daha düşük** çıkabilir → **hep aynı yer**.

Ölçüm yeri	Avantaj	Dezavantaj/risk
Kulak (aurikulär)	hızlı, kolay, her pozisyon, çekirdek ısı	kulak kiri, orta kulak iltihabı, yanlış prob, pahalı
Rektal	çekirdek ısı, çok doğru	**mahremiyet**, düşük kabul, **yaralanma/perforasyon** (bebek!), dışkı, geç tepki
Axillar	kolay, kabul yüksek	yalnızca **kabuk** ısısı, ter, kol kayması
Inguinal	kolay	yalnızca kabuk
Sublingual	çekirdeğe yakın	tükürük/içecek/sigara, **ısırma**, yalnızca uyanık/oryante
Vaginal	bazal ısı	mahremiyet
Alın	kolay	doğruluğu düşük

Teknik: *Kulak:* kanalı düzleştir — **çocukta kulak düz geriye, yetişkinde çapraz yukarı**; koruyucu kapağı her ölçümde at. *Rektal:* yetişkinde **≈ 4 cm**, çocukta **2–3 cm**; yan yatış (bebekte sırt), yalnız bırakma, kayganlaştırıcı. *Koltuk/kasık:* temiz, kuru, uç derin ve çevrili, kol/bacak bastırılı. *Dil altı:* frenulum yanına, ağız kapalı, **15 dk önce sıcak/soğuk içecek yok**. **Uygulama (S. 13–14):** üretici bilgisi · koruyucu kılıf/eldiven · **her kullanımdan sonra dezenfeksiyon** · **mahremiyet** · önce bilgilendir · efordan hemen sonra ölçme · ölçüm yeri merhem/fitil kalıntısından **arınmış** · **dokümante et: saat, yer, sonuç, eşlik eden tedavi**. **Termometre türleri:** analog (cıva artık yok), dijital, kızılötesi kulak/alın, **Thermistor** (kateter, yoğun bakım), termografi. **Normal aralık:** çekirdek hedef **36–37,5 °C**; sirkadiyen ≈ 0,6 °C; yumurtlama sonrası ≈ +0,5 °C; gebelikte ↑; menopozda ↓; küçük çocuk ↑; yaşlı ↓; efor/duygusal stres ↑. **Ateş değerlendirme 6 kuralı (S. 15):** kabulde sabah ısısı · bireysel temel ısı · etkileyen faktörler · **aynı yer + teknik** · doğru teknik · saat/yer/sonuç/tedavi dokümantasyonu.

3. Hipotermi (S. 15–17)

Tanım: çekirdek ısı **< 35 °C**. Derece (Herzog): hafif 32–36, orta 28–32, ağır 18–28, derin < 18 (⚠ "hafif 32–36" tanımla çakışıyor). **Nedenler:** soğuk/ıslak giysi, alkol, düşme sonrası yardımsız yaşlı, hipotiroidi, kan/sıvı kaybı, yetersiz beslenme, kollaps, **şok**, hipotalamus/omurilik hasarı, ölmekte olanlar. *Terapötik hipotermi* 32–34 °C (büyük ameliyat, yenidoğan hipoksisi). **3 evre: I Erregung/Abwehr** (35–32 °C): titreme, taşikardi, hipertansiyon, uyanık-huzursuz · **II Erschöpfung** (32–28): kas sertliği, bradikardi,

solunum depresyonu, uykuya meyil, hipoglisemi · **III Lähmung** (< 28): bilinçsiz/koma, pupil geniş-ışıksız, ventrikül fibrilasyonu/asistoli. **Isıtma: Evre I pasif dıştan** (sıcak oda, battaniye, kurtarma folyosu); **< 32 °C aktif dıştan** (ısıtılmış infüzyon, ısıtma matı) ± merkezi; **sürekli bilinç ve vital kontrol**. **Evre II/III'te çok hızlı ısıtma kontrendike** (dolaşım yetmezliği, asidoz); II/III → **yoğun bakım izlemi**. **Donma (Erfrierung):** 1° solukluk/his kaybı → ısınınca şişlik-ağrı; 2° 12–24 saatte kabarcık; 3° nekroz.

4. Hipertermi (S. 17–21)

Isı düzenleme yetersiz kalır (ısı üretimi/alımı ≫ kaybı), **hedef değer değişmez**; sürekli 42 °C ölüm. Nedenler: hastalık/yaralanma, susuzluk, terleyememe, efor, sıcak ortam, ↑ metabolizma, ilaç/anestezik, uygunsuz giysi. Belirti: cilt kırmızı-sıcak-başta kuru; taşipne, taşikardi; bilinç değişimi.

Biçim	Özet	İlk müdahale
Hitzekollaps	damar genişlemesi, kanın bacaklara çökmesi, baş dönmesi, hipotansiyon, senkop	**yatırma (düz)**, sıvı
Hitzekrämpfe	NaCl kaybı	oral elektrolit
Hitzeerschöpfung	sıvı+elektrolit kaybı, > 39 °C	serin ortam, fiziksel soğutma
Hitzschlag	**yaşamı tehdit**, > 40,5 °C, kuru-sıcak cilt, bilinç bozukluğu	serin ortam, soğuk paketler, vital kontrol, **acil tıp**
Maligne Hyperthermie	Ca^{2+} kusuru, anestezide	anesteziyi bitir, %100 O_2, soğut, **Dantrolen (doktor)**
Sonnenstich	baş/ense güneş ışınımı	gölge, baş-gövde yüksek, baş soğutma
Durstfieber	bebek, sıvı eksikliği, **gerçek ateş değil**	sıvı

Yaşlı/kalp-damar hastaları hipertermi sonrası kısa süre izlenmeli.

5. Ateş (Fieber) (S. 21–29)

Tanım: hipotalamusun **hedef değeri yükseltmesi > 38,0 °C. Ateş bir belirtidir, hastalık değildir.**

Derece (rektal, Tab. 4)	°C
afebril	36,3–37,4
subfebril	37,5–38,0
hafif ateş	38,1–38,5
orta	38,6–39,0
yüksek	39,1–39,9
çok yüksek (hiperpiretik)	> 40

Mekanizma: pirojenler (ekzojen: bakteri/virüs toksinleri, yabancı protein, ilaç; endojen: iltihap mediatörleri) → **Prostaglandin E** → hedef ↑ → metabolizma ↑ (savunma; etken çoğalması engellenir). **Ateş bağışıklığı destekler.** > 42,6 °C protein pıhtılaşır. **Eşlik edenler:** nabız **≈ +8–10 (–12)/dk her 1 °C'de** (⚠ S. 22: 8–12; S. 28: 8–10), O_2 ihtiyacı **≈ +%10/°C**, solunum ↑, susuzluk, iştahsızlık, **kabızlık**, konsantre idrar, huzursuzluk, kuru kaplı dil, **Fieberdelir**. **Ateş türleri:** infektiöz · **Resorptionsfieber** (aseptik; ameliyat/travma sonrası ≈ 24 saat, ≤ 38,5) · zentral (hipotalamus hasarı) · toxisch · rheumatisch · Dreitagefieber (çocuk 39–40) · **FUO** (≥ 3 hafta > 38,3, neden bulunamaz). **Ateş seyirleri:** kontinuierlich · remittierend · **intermittierend** (≥ 1,5 °C oynama, ateşsiz aralık, üşüme) · rekurrierend · undulierend · biphasisch (deve hörgücü: kızamık, çocuk felci, hepatit A).

5.1 Üç evre

Evre	Beden	Cilt/belirti	Bakım
1 Fieberanstieg	cilt kan akışı ↓, tonus ↑	**soluk, soğuk, mermerimsi**, üşüme, tüy diken, titreme	**ısıt** (battaniye); **soğutma yok**
2 Fieberhöhe	plato	**sıcak, kuru, kızarık**, parlak göz, susuzluk, yorgunluk, huzursuzluk	sıvı; soğutma talimatla/hasta isteğiyle

Evre	Beden	Cilt/belirti	Bakım
3 Fieberabfall	hedef ↓ → vazodilatasyon + terleme	**Lysis** (yavaş, günler, sıcak iri damlalı ter) · **Krisis** (saatler içinde; soğuk-yapışkan ince ter, solgun, nabız tekrar ↑ = kollaps tehlikesi → **ACİL**)	çamaşır değiştir, sıvı, geç mobilize etme; **ilk mobilizasyonda hemşire yanında**

Hatırlama: *Anstieg = üşür (ısıt) · Höhe = yanar (serinlet) · Abfall = terler (kurula, içir).*

5.2 Ateş düşürme (S. 29–33)

Zamanlama/yöntem kararı doktorundur. Yavaş düşür; temel: hastanın hali. **Fieberanstieg'de soğutma kontrendike.**

- **Wadenwickel (baldır kompresi):** altına su geçirmez; 2 bez **ılık su** (**vücut ısısından en fazla 10 °C düşük**), sıkılmış, baldıra **gevşek, kırışıksız**; **5–10 dk'da değiştir**; 2–3 tekrar; etki: ısı iletimi + buharlaşma; **kontrendike: soğuk el/ayak, dolaşım bozukluğu**.
- **Soğutucu yıkama:** ılık su, hasta çok sıcak hissediyorsa; **ekstremiteden gövdeye**; sadece yıkanan bölge açık (mahremiyet); havada kurusun; nane/limon katkı; uçucu yağlar dikkatle.
- **Soğutma matı/yerel soğutucu:** çok hızlı düşüş/titreme; yerel **donma** riski; sargılı, dakikalar.
- **Antipiretikler (doktor):** hipotalamusa etkir, çoğu ağrı kesici; yan etki örnekleri: Aspirin (kanama, çocukta **Reye sendromu**), Metamizol (aşırı duyarlılık, agranülositoz), Paracetamol (alerji, kan sayımı, analjezik astımı). **Doz yazmıyorum — yalnızca talimatla.**

5.3 Komplikasyonlar

- **Schüttelfrost** 4 evre: ısı artışı (titreme, diş sıkma, soluk/morarmış) → ateş zirvesi (susuzluk, sıcak-kuru) → **ateş düşüşü** (terleme; lysis/krisis) → **uyku/halsizlik.** Önlem: battaniye, oda sıcaklığı, sakinleştir, keskin eşyayı kaldır, **yalnız bırakma**; ağır titreme/kriz → doktor; Pethidin (doktor) → **solunum sayısı kontrolü**.
- **Fieberkrampf** (çocukların %3–5'i): çoğu kendiliğinden geçer; ateş **yavaş** düşür; aileyi sakinleştir.
- **Fieberdelir:** yüksek ateşte ani oryantasyon kaybı/huzursuzluk (susuzluk, elektrolit) → **doktoru bilgilendir**; susuzluk bulguları (kuru mukoza, ayakta kalan deri kıvrımı); **düşme riski!**

6. Vaka: Herr Schneider ateşli (örnek)

Gözlem: axillar 38,6 °C, nabız 104, bol terleme, az içmiş. **Sorunlar:** ateş/sıvı açığı, huzursuzluk, düşme riski. **Hedef:** sıvı alımı sağlanır, hal iyileşir, dolaşım stabil. **Önlem:** evreyi değerlendir, içecek/protokol, wickel/yıkama **talimat/anlaşma ile**, ter çamaşırı değişimi, eşlikli mobilizasyon, aynı yerden ölçüm, **delir/titreme/kötüleşmede doktor**. **Değerlendirme:** ısı, nabız, hal, içilen miktar. *(Kurgusal değerler; tedavi planı değildir.)*

7. Terimler

Almanca	Türkçe
die Körperkerntemperatur / -schalentemperatur	çekirdek / kabuk ısısı
der Sollwert / Istwert	hedef / mevcut değer
der Hypothalamus	hipotalamus
die Hypothermie / Hyperthermie	hipotermi / hipertermi
das Fieber (febril, subfebril)	ateş
der Schüttelfrost	titremeli üşüme
die Lysis / die Krisis	yavaş / ani ateş düşüşü
der Wadenwickel	baldır kompresi
das Antipyretikum	ateş düşürücü
das Durstfieber	susuzluk ateşi
axillar / rektal / aurikulär / sublingual	koltuk altı / makat / kulak / dil altı

8. Sınav bilgisi

Hatalar: ateş artışında soğutmak · rektal = axillar sanmak · ateşi "her zaman düşür" · dozu kendin seçmek · dokümantasyonda ölçüm yeri yazmamak. **Almanca kalıplar:** „Während Fieber auf einer Sollwerterhöhung im Hypothalamus beruht, ist die Hyperthermie ein Versagen der Wärmeabgabe.“ · „Im Fieberanstieg sind kühlende Maßnahmen kontraindiziert, weil der Körper mit erneutem Schüttelfrost reagiert.“ **Kontrol:** 1) Fieber artışında hasta neden üşür? 2) Fieber ↔ Hyperthermie? 3) Wadenwickel: sıcaklık, değişim süresi, kontrendikasyon? 4) Hipotermi evreleri? 5) Doktora ne zaman haber verirsin?

06 — LF 2: Hareketlilik, yaşlılıkta hareket ve düşme profilaksisi

> **Kaynaklar:** Erwartungshorizont "Bewegung im Alter" (EH, 4 S.), Sturzprophylaxe PPP (F, 15 Folie), Frau Berger/Herr Schneider vakaları.

1. Kavramlar (EH S. 1–2, 4)

Almanca	Tanım
Mobilität	kişinin bağımsız/özerk hareket edebilmesi, yer veya vücut pozisyonunu değiştirmesi (kalkma, oturma, yürüme, dönme, transfer, merdiven, yardımcı araçla ilerleme)
eingeschränkte Mobilität	hareket **var ama azalmış** (yavaş yürüme, kalkmada güçlük, güvensiz yürüyüş, destek ihtiyacı)
Immobilität	bağımsız hareket **ileri derecede kısıtlı/yok**; destekten büyük ölçüde bağımlı

Mobilite nasıl görülür? kalkma/oturma, kol-bacak hareketi, mesafe, eğilme-doğrulma, merdiven, araçla ilerleme.

2. Yaşlılıkta ne değişir? (EH S. 1–2)

Kas kütlesi/gücü ↓ · kemik-eklem: dayanıklılık ↓, aşınma, ağrı/sertlik · **denge ↓ → düşme riski** · görme/işitme ↓ → yönelim zorlaşır · dayanıklılık ↓.

> **Önemli:** Değişiklikleri "yaşa bağlı normal" diye **geçiştirme**. Yeni/artan hareket kısıtlılığı **gözlenmeli ve hemşirelik/tıbbi olarak araştırılmalı** (etkilenebilir nedenler: ağrı, hastalık, halsizlik, güvensizlik, **ilaç yan etkileri**). **Frau Berger (81):** daha yavaş, kalkarken birkaç deneme, mobilyaya tutunuyor, koltukta daha çok kalıyor, odadan az çıkıyor. **Gözlenecekler (EH S. 3):** yürüyüş/hız, denge, kalkma-oturma, transfer, yardımcı araç kullanımı, kısıtlılıklar, **ağrı**, düşme olayları/korkusu, destek ihtiyacı, görme/işitme/oryantasyon.

3. Hareketsizliğin sonuçları (EH S. 3)

Düzey	Sonuç
Beden	kas kaybı, güç ↓, dayanıklılık ↓, **düşme, tromboz, dekubitus, kontraktür** riski, kabızlık, ağrı, dolaşım sorunları
Duygu/Psikoloji	güvensizlik/korku, bağımsızlık kaybı, hayal kırıklığı, çekilme/izolasyon, yaşam kalitesi ↓
Günlük yaşam/Sosyal	etkinlik ve katılım ↓, yoksunluk (Deprivation) riski, bağımlılık

Önlenebilir mi? Evet: erken, kişiye uygun **hareket desteği**, güvenli mobilizasyon, yardımcı araçlar, transfer desteği, risk azaltma.

4. Prophylaxe ↔ Prävention (EH S. 4)

Prophylaxe: belirli sağlık sorunlarının/komplikasyonların ortaya çıkışını **azaltan** önlemler. **Prävention:** sağlık sorunlarını **önleme/azaltma** + sağlığı **koruma/geliştirme** ("Vorsorge"). Hemşire riskleri erken gözler, planlar, uygular, kaynakları destekler; **bakım sürecinde planlanır, uygulanır, değerlendirilir**; **bilgilendirme/danışmanlık/eğitim görüşmeleri kanıtlanabilir (dokümante) olmalı** (mikro eğitim dahil).

5. Düşme profilaksisi (Sturzprophylaxe) — F

Tanım (F3; RKI): kişinin **istemeden** yere ya da daha alçak bir seviyeye gelmesi (çömelip/oturur kalsa da). **Yüksek konumdan = Absturz. Sayılar (F4):** Almanya'da yılda > **5 milyon** yaşlı düşmesi; > **400 000**'inde kırık. Sonuç: ezik, burkulma, **kalça kırığı**, **tekrar düşme korkusu → az hareket → beceri kaybı**. **Hızlı tarama (F5):** son yılda düştü mü? yürürken güvensiz mi? düşme korkusu var mı? **Nedenler (F6):** denge bozukluğu · kas zayıflığı (örn. yetersiz beslenme) · hareket özgürlüğü kısıtı · görme sorunları · baş dönmesi yapan hastalıklar · korku · **uygunsuz giysi/ayakkabı** · **ilaçlar** (baş dönmesi) · **inkontinans** (tuvalete koşma). **Expertenstandard (F7–F8):** Slayt **DNQP 2013** der; ⚠ güncel sürüm **2022 (2. Aktualisierung)** — DNQP. Slayta göre: **belirli bir tarama aracı önerilmez**; hemşire **risk faktörlerini** belirler, **anamnez** özellikle önemli, **düzenli yeniden değerlendirme** (düşmeden sonra risk ↑, yardımcı araçla ↓). Örnek: **Timed-Up-and-Go-Test**, **Wohnraumassessment**. **Temel fikir (F9):** *Korku vermeden, hareketli kalmak için ne yapabilirim?*

Önlemler (F9, F11–12):

Kategori	Örnek
Bilgi/danışmanlık/eğitim	yardımcı araç kullanımı eğitimi
Kişiye yönelik	denge egzersizi, güç/dayanıklılık, yürüme eğitimi
İlaç (doktor kontrol eder)	yatıştırıcı, tansiyon düşürücüler gözden geçirilir
Ortam	yeterli ışık (geceleri hareket sensörlü lamba), **takılma tehlikeleri** (kablo) kaldır, eşik/basamak işaretle, **rolatör/tekerlekli sandalye: yer + frenler daima kilitli**, tutunma kolları/korkuluk, **kaymaz paspas** sabit
Giysi/ayakkabı, gözlük, tuvalet	⚠ F6 nedenlerinden türetildi

Düşme sonrası acil (F13; I care S. 438 vd.):

1. Hastayı **sakinleştir**, **2. bakım personelini çağır**. 2. **Görünür yaralanmalara** bak. 3. Harekete teşvik: **iki elini tutturup bacaklarını kaldırtmak**. 4. **Kırık yoksa** dikkatle kaldır; **Vierfüßlerstand** (emekleme pozisyonu, Kinästhetik) ile. 5. **Nabız ve tansiyon** (sakinleştikten sonra; sonraki ölçümlere kıyas). 6. **Sturzprotokoll** (PFK). 7. **Yakın/bakıcı ve aile hekimine bildir**. 8. **Beyin sarsıntısı** belirtileri: baş dönmesi, baş ağrısı, olay hakkında bellek boşluğu, bulantı/kusma. 9. **24 saat (geceleri de) kafa içi basınç belirtileri:** pupil ışık tepkisizliği, **Druckpuls** (tansiyon yüksek, nabız düşük). 10. Gerekirse **Notarzt/röntgen**.

> ⚠ Gerçek acilde kurum standardı/doktor belirler; **kalça/omurga kırığı şüphesinde ayağa kaldırma, acil çağır.** Bilinçsiz/solunum bozukluğunda İlk Yardım şeması (08). **Sturzprotokoll içeriği (F14):** kişi bilgisi · tarih/saat/yer · ortam · düşme sonrası durum · düşmeden önceki etkinlik · alınan önlemler · ruhsal/bedensel sonuçlar. *Her kurumun kendi formu vardır.*

6. Vaka: Herr Schneider (Operatoren-Übung) — cevaplarınıza geri bildirim

Durum: 78 yaşında, yalnız yaşıyor, düşme sonrası cerrahi servis; sağ kalça ağrısı, zor kalkıyor; güvensiz/korkak ("artık tek başıma başa çıkamam diye korkuyorum"); çok terliyor, giysi kirli, sabahtan beri az içmiş; ilk başta yıkanmayı reddediyor (rahatsız edici).

Görev	Cevabınız	Değerlendirme	Geliştirme
1 NENNEN (AFB I)	güvensiz/korkmuş; çok terliyor; giysi kirli	✔ doğru ve kısa	"wirkt ängstlich" izlenimdir → ayrıca **sözlü ifade** ("äußert Angst"), az içme
2 BESCHREIBEN (AFB I)	78 yaşındaki … kalça ağrısı … korkmuş görünüyor … yıkamayı reddediyor	✔ tam cümleler, çoğunlukla nesnel	**Fachsprache:** „Schmerzen im rechten Hüftbereich“; „geringe Flüssigkeitsaufnahme seit dem Morgen“; değerlendirme yok; **eksikler:** yalnız yaşıyor, düşme sonrası kabul, kalkmada zorluk, cerrahi servis
3 ERMITTELN (AFB II)	ağrı/mobilite kısıtı · sıvı eksikliği riski · yıkamada destek	✔ iyi	eklenebilir: **düşme riski/profilaksisi**, **korku/psikososyal destek**, hijyen/cilt, **taburculuk planı**

Görev	Cevabınız	Değerlendirme	Geliştirme
4 ERKLÄREN (AFB II)	"Er hat Angst, weil er bisher alleine lebte und durch den Sturz plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen ist, was ihm unangenehm ist."	✔ doğru, *weil* ile	daha derin: **kontrol/özerklik kaybı**, ağrı + kısıtlı hareket, bakımda **utanç (mahremiyet)**, eve dönüş belirsizliği; alıntı kullan

Gramer: *weil*-cümlesi → fiil sonda ✔ („weil er … angewiesen ist“); „Kleidung“ büyük harf; „**trägt** verschmutzte Kleidung“ ✔.

7. Terimler

Almanca	Türkçe
die Mobilität / Immobilität	hareketlilik / hareketsizlik
der Transfer	transfer (yataktan sandalyeye)
das Gangbild	yürüyüş şekli
das Gleichgewicht	denge
der Rollator	rolatör
die Bremse	fren
der Sturz / das Sturzrisiko / das Sturzprotokoll	düşme / düşme riski / protokolü
die Stolperfalle	takılma tehlikesi
die Kontraktur	eklem sertleşmesi
die Gehirnerschütterung	beyin sarsıntısı
die Hirndruckzeichen	kafa içi basınç belirtileri
der Vierfüßlerstand	emekleme pozisyonu

8. Sınav bilgisi

Sık: immobilite sonuçları (3 düzey) · düşme nedenleri · düşme sonrası ilk adımlar · protokol içeriği · Mobilität/Immobilität/Prophylaxe/Prävention tanımları · Frau Berger için bakım süreci. **Hatalar:** "yaş = hareketsizlik" · olası kırıkta ayağa kaldırmak · tansiyonu sakinleştirmeden ölçmek · yalnızca ilaç değiştirmek (**doktor**) · protokolü doldurmamak. **Almanca kalıp:** „Nach einem Sturz werden die Betroffene beruhigt, eine zweite Pflegeperson hinzugezogen, Verletzungen beachtet und Vitalzeichen kontrolliert; anschließend wird das Sturzprotokoll ausgefüllt und die Pflegefachkraft informiert.“ **Kontrol:** 1) Eingeschränkte Mobilität ↔ Immobilität? 2) 5 düşme nedeni? 3) Düşme sonrası ne yaparsın? 4) Protokolde ne yazar? 5) Düşme korkusu neden riskli?

07 — LF 2: Tromboz profilaksisi, pnömoni profilaksisi, kontraktür

> **Kaynaklar:** Thromboseprophylaxe PPP (T, 4 S.), Auszug I care (IC; basılı S. 417–422 = PDF S. 1–6), Pneumonieprophylaxe PPP (P, 22 S.). ⚠ "Auszug … Thromboseprophylaxe" PDF'sinin **S. 1'inin ilk yarısı Pneumonie-LISA** metnidir.

A. TROMBOZ PROFİLAKSİSİ (Thromboseprophylaxe)

1. Temeller

Prophylaxe = hastalık/komplikasyonları önleyici önlemler; **bakımın çekirdek görevlerindendir** (T S. 2). **Thrombose:** damar içi boşluğunun **pıhtı (Thrombus)** ile daralması/tıkanması; **arter ve ven** etkilenebilir (T S. 3). Bu bölüm **venöz, özellikle derin bacak ven trombozu (TVT)**. **Virchow-Trias (IC S. 1–2):**

Faktör	Almanca	Örnek
Dolaşım	**verlangsamter Blutfluss**	immobilite, kalp yetmezliği, susuzluk
Duvar	**Gefäßwandschäden**	ameliyat/yaralanma, iltihap, sigara, hipertansiyon
Kan	**erhöhte Gerinnungsneigung**	trombofili, tümör, gebelik, hormonlu doğum kontrol

Hatırlama: **K-W-B** = Kreislauf–Wand–Blut. Faktör arttıkça risk artar. **Risk faktörleri:**

- **Expositionell** (geçici/akut): ameliyat, travma/akut hastalık, **Immobilisation**.
- **Dispositionell** (doğuştan/edinsel, temel risk): önceki TVT/akciğer embolisi, yaş > 60, aile öyküsü, kronik kalp yetmezliği/enfarkt sonrası, obezite (BMI > 30), enfeksiyonlar, hormonlu doğum kontrol, sigara, hipertansiyon, gebelik/lohusalık, nefrotik sendrom, varis.
- **Çok yüksek risk:** önceden tromboz, kan pıhtılaşma kusuru, **kanser**. Kombinasyonlar riski artırır (hap + sigara). Riskler **basitçe toplanmaz.**
- **Expositionelles Risiko (Tab. 17.4):** *düşük:* küçük ameliyat, hafif yaralanma · *orta:* uzun ameliyat, alt ekstremite eklem cerrahisi, alçı ile immobilizasyon; dahiliye: yatak istirahatsiz enfeksiyon, port/ZVK, akut kalp yetmezliği NYHA III/IV · *yüksek:* omurga/pelvis/kalça/diz büyük ameliyat, vücut boşluğu büyük ameliyat, politravma, **bacak parezili inme**, sepsis, yoğun bakım.
- **Sayılar:** TVT 90–130/100 000/yıl; diz-kalça protezi/kalça yakını kırıkta **%40–60**; omurilik yaralanmasında %60–80; TVT'nin %20–50'sinde **postthrombotisches Syndrom (PTS)** (bacak ağırlığı, şişlik, ağrı, cilt ülseri).
- **Bakım değerlendirme soruları (IC S. 3):** önceki tromboz? felç/ekstremite sabit? enfeksiyon/sigara? yatak istirahati talimatı? hareket kısıtı? kilo (kaşeksi/obezite)? risk grubu? uzun (≥ 30 dk) veya büyük ameliyat? **DİKKAT (IC S. 2):** Tromboz **erken evrede çoğu zaman fark edilmez**; pıhtı en olası bu dönemde kopar → **Lungenembolie** (hayatı tehdit eder) → 08 §7.4. **TVT belirtileri:** tek taraflı bacak şişliği, ağrı, sıcaklık, ağırlık hissi.

2. Önlemler (IC S. 3–6)

Risk	Önlem
düşük	**Basismaßnahmen** (+ MTPS "isteğe bağlı")
orta/yüksek	Basismaßnahmen + **Antikoagulanzien** (doktor) + fiziksel: **IPK** (aralıklı pnömatik kompresyon) veya AV-impuls; MTPS isteğe bağlı

Basismaßnahmen: Frühmobilisation · aktif **Eigenübungen** · pasif hareket egzersizi · **yeterli sıvı**.

- Hareket **kas-ven pompasını** çalıştırır → venöz dönüş. Araçlar: yatak bisikleti, ayak stepper, yatak ucunda iki hava dolu torbaya tekmeleme. **Kendi egzersizleri:** ayak daire/sallama, bacak kaldırıp indirme, parmakları "pençe"leme, omuz daireleri, **En-bloc-Mobilisation**.

- **Pasif** (bilinçsiz/çok kısıtlı): bakım/pozisyon değişiminde eklemleri hareket ettir; **kırık, eklem protezi, hemiplej**ide **subluxation** riski nedeniyle dikkat, ama **uzak eklemler** (ayak, diz, dirsek, el) yine hareket ettirilir.
- **Merke: Bacakları sıvazlama/masaj yapma; bacağı yukarı kaldırmak profilaksi değildir** (sadece rahatlık); sıvazlama mevcut pıhtıyı koparabilir.
- **İçme:** hastayla konuş, neden önemli açıkla; bellek sorununda "Bir şey içmeliyim!" notu. **MTPS (tıbbi tromboz profilaksi çorapları):**
- Almanya'da AWMF 2015: tek başına **"Nichtempfehlung"**; yüksek kanama eğilimi varsa **IPK** önerilir; ABD/İngiltere kılavuzları ilaca **ek olarak** MTPS önerir. Etkisizliğin kanıtı yok.
- **Uyum: iki bacakta da** ölç; **sabah/sargı çıkarılınca**; ayak **90°**, baldır kası gevşek; mezuro **aşağıdan yukarıya**: önce çevre, sonra boy; **katlama/batma yok**; çok kalın/deforme bacakta kompresyon sargısı.
- **Giydirme (Abb. 17.14):** ölçüler (bilek, baldır, boy) → beden seç → çorabı genişlet → topuğa kadar geçir → topuk kısmını tut, dışa çevir → bacağa çek, **kırışıksız**.
- **Yalnızca yatan hastada etkilidir**; mobil hastaya **MKS** (medizinische Kompressionsstrümpfe) gerekir.

	MKS	MTPS	Stützstrumpf (destek çorabı)
Kimler	ven/lenf hastalığı	klinik/bakım evi, **yatan** hasta	**damar sağlıklı** (ayakta durma/uçuş/ameliyat personeli)
Reçete	yazılır	–	serbest
Basınç	tanımlı, 4 sınıf (Kl. 4 ≥ 49 mmHg)	MKS'den az	düşük
Beden	seri/ölçüye göre	seri, **yalnız beyaz**, ayak ucunda **delik (muayene)**	numaraya göre

Hastanın **kendi** iyi oturan kompresyon çorapları gündüz kullanılabilir; çamaşırhaneye karışmasın (dokümante et). **Kompresyon sargısı: çok katmanlı + elastik bez**; MKS güçlü basınçla kısa-çekmeli sargıya tercih (DNQP 2015); basınç 20–30 mmHg; yaşlılarda daha basit (18–21 mmHg), cırtlı bandajlar; kısa-çekmeli sargı 2 saatte basıncın %25'ini kaybeder. **MTPS/kompresyon kontrendikasyonları (IC S. 6): kritik periferik arter dolaşım bozukluğu (pAVK), ağır nöropati, belirgin periferik ödem, lokal defekt/nekroz/yaralanma. IPK kontrendike:** dekompanse kalp yetmezliği, yaygın iltihap (flebit, erizipel), travma, nöropati, ayarlanamayan hipertansiyon. **Gözle:** tek taraflı şişlik, ağrı, ısınma, kızarıklık, gerginlik → **hemen PFK/doktor**, **masaj/mobilizasyon yapma** ⚠ (genel güvenlik).

3. Kontraktür (IC S. 6)

Gelenksteifigkeit (eklem sertliği), işlev bozukluğu, eklem deformasyonu, pasif gerilmeye direnç ↑; aktif ve pasif hareket kısıtlı. Önleme: hareket/mobilizasyon, pasif egzersiz, pozisyon verme (ayrıntı PDF'de yok ⚠).

B. PNÖMONİ PROFİLAKSİSİ (Pneumonieprophylaxe)

4. Pneumonie (P S. 2–19)

Akciğerin **enfeksiyöz iltihabı**; dünyada en sık enfeksiyonlardan, batı ülkelerinde **enfeksiyondan ölümün en sık nedeni** (P S. 2). **Sınıflama:** enfeksiyon yeri, etken, belirti, iltihap yeri.

- **ambulant** (toplum kökenli) ↔ **nosokomial** (hastane + çıkıştan 24 saat sonrasına kadar ⚠ P S. 4; kaynaklarda genelde ≥ 48 sa — okulda sor). *Neden önemli?* farklı etken/direnç (MRSA), farklı antibiyotik.
- **Etkenler:** ambulant çoğu **Pneumokokken**, Chlamydien, Legionellen, Mykoplasmen, virüsler; yaşlılarda Staphylokokken, **E. coli**, Klebsiellen; nosokomial: **MRSA**; bağışıklığı zayıf: **opportunistische** mikroplar. **Typisch ↔ atypisch (P S. 8):**

	typisch	atypisch
Başlangıç	ani	sinsi

	typisch	atypisch
Ateş	**40 °C'ye kadar, titreme**	hafif
Öksürük	produktif (sarı-kahverengi)	kuru
Nefes darlığı	baştan belirgin	yavaş artar
Eşlik	plörezi	grip belirtileri
Genel durum	çok kötü	orta

İltihap yeri (S. 9–10): *lobär*, *bronko*, *interstitiell*, alveolär. **Komplikasyonlar:** plevral efüzyon, solunum yetmezliği, akut akciğer yetmezliği, akciğer apsesi. **Tanı:** oskültasyon (**ince ral**), akciğer grafisi, laboratuvar (**BSG, CRP, PCT**), **balgam kültürü**, ateşte **kan kültürü**. **CRB-65 (S. 14): C**onfusion · **R**espiratory rate **≥ 30/dk** · **B**lood pressure düşük (< 90 / ≤ 60 mmHg) · **A**lter ≥ 65 → her biri 1 puan; **≥ 1 puan → yatış** (⚠ slaytta "> 65" yazıyor). **Tedavi (doktor):** istirahat, **antibiyotik** (önce geniş spektrum), sıvı, sekretolitik inhalasyon, ateş düşürme, O_2. **Aspirasyon pnömonisi (S. 16–19):** özel biçim, **enfeksiyöz değil**. Risk: bilinç bozukluğu, narkozda hasta aç değilse (acil ameliyat), **yutma bozukluğu**, **nazogastrik sonda**, gebelik. Belirtiler **gecikmeli (2–12 sa):** öksürük, bronkospazm/balgam, **dispne, siyanoz**, sonra ateş. Tedavi: bronkoskopi, antibiyotik, O_2, bronkospazmolitik. **Risk grupları (Soru S. 12 — önerim):** yaşlı, yatağa bağımlı, yutma bozukluğu, bilinç bozukluğu, bağışıklık zayıf, KOAH/kalp yetmezliği, sigara, ventilasyon, ağrıyla yüzeysel solunum, kas gevşeticiler/sedatifler, yetersiz beslenme.

5. LISA prensibi (IC S. 1)

Harf	Anlam	Önlemler
L	**L**ungenbelüftung verbessern	mobilizasyon, solunumu destekleyen pozisyon (**Oberkörperhochlage**), derin solunum
I	**I**nfektionen vermeiden	**ağız bakımı**, hijyenik çalışma, **standart hijyen**
S	**S**ekret verflüssigen/mobilisieren/entleeren	sıvı ↑ (**filtrelenmiş/sade su**, bağışıklığı baskılı → **kaynatılmış**), **Drainagelagerung**, **Huffing**, **inhalasyon**, solunum fizyoterapisi, **perküsyon/vibrasyon** (duruma göre), **aspirasyon** (kapalı sistem; kateter at; steril aqua dest., Legionella riskinde musluk suyu yok)
A	**A**spiration vermeiden	mümkün olduğunca **oral beslenme**, **yemekte dik pozisyon**, **yutma bozukluğunda** değerlendir, **zaman tanı**

Ek (P S. 21): Pneumokokken aşısı (yaşlı, bağışıklık baskılı, kronik hasta çocuk > 5 yaş, uzun süreli bakım) · **solunum rahatlatıcı**: **Lippenbremse**, **Kutschersitz**, sırt ovma · **ağrı yönetimi** (yüzeysel solunumu önlemek) · **VATI-Lagerung**. **Merke (IC):** Kas gevşeticiler (benzodiazepinler) **disiplinlerarası** konuşulmalı: yarar, ↑ pnömoni riskini haklı çıkarır mı? **Gözlem ölçütleri (önerim):** solunum sayısı/derinliği, solunum sesleri, öksürük/balgam (renk, miktar), cilt rengi (siyanoz), ateş, nabız, bilinç/huzursuzluk, SpO_2, hareketlilik, yutma, ağız durumu. **Pratik:** *İmmobilite → yüzeysel solunum → sekret birikimi → pnömoni.* Erken mobilizasyon tromboz **ve** pnömoniye yarar. **Güvenlik:** O_2, inhalasyon, aspirasyon, pozisyonlar **talimat/standart/eğitim** ile.

6. Terimler

Almanca	Türkçe
die Thrombose / der Thrombus	tromboz / pıhtı
die Lungenembolie	akciğer embolisi
expositionell / dispositionell	maruziyete / yatkınlığa bağlı
die Antikoagulanzien	kan sulandırıcılar
die Frühmobilisation	erken mobilizasyon
der Kompressionsstrumpf (MKS) / MTPS	kompresyon çorabı / profilaksi çorabı
die Pneumonie	zatürre
nosokomial / ambulant	hastane kaynaklı / toplum kökenli
die Aspiration	aspirasyon
die Dysphagie	yutma güçlüğü
das Sekret / der Auswurf	salgı / balgam

Almanca	Türkçe
die Lippenbremse	dudak freni
der Kutschersitz	arabacı oturuşu

7. Sınav bilgisi

Sık: Virchow-Trias + örnek · Basismaßnahmen · MTPS giydirme/kontrendikasyon · **bacağı sıvazlama yok** · LISA'dan 2'şer önlem · typisch/atypisch pnömoni · aspirasyon profilaksisi · neden immobilite iki komplikasyona yol açar. **Hatalar:** MTPS'yi yürüyen hastada tam etkili saymak · tek bacağı ölçmek · "bacak yukarı = profilaksi" · LISA harflerini karıştırmak · aspirasyonu enfeksiyöz saymak. **Almanca kalıp:** „Die Frühmobilisation dient dazu, die Muskel-Venen-Pumpe zu aktivieren und einer Thrombose vorzubeugen.“ · „LISA steht für Lungenbelüftung verbessern, Infektionen vermeiden, Sekret mobilisieren und Aspiration vermeiden.“ **Kontrol:** 1) Virchow-Trias? 2) Expositionell ↔ dispositionell? 3) MTPS kontrendikasyonları? 4) LISA? 5) Bacak yukarı koymak neden yetmez? 6) Typisch/atypisch pnömoni farkı?

08 — İlk yardım, temel yaşam desteği (BLS), AED, şok ve akut acil durumlar

> **Kaynaklar: ZF** = Zusammenfassung Erste Hilfe B2 (27 S.); **F** = Erste Hilfe Folien (254 S., H. Becker, 28.9.2026; Folie no = PDF sayfası). ⚠ **Güvenlik:** Bu bölüm **öğrenme metnidir.** Resüsitasyon **uygulamalı kursta** öğrenilir; gerçekte kurs, kurum standardı ve Leitstelle geçerlidir. Çelişkiler: 00 §4.

1. Neden anatomi? (ZF S. 1)

Acili tanımak için normali bilmek gerekir: **kalp–dolaşım–solunum.** Akciğer O_2 alır, kan taşır, kalp pompalar; **beyin** O_2 eksikliğine çok duyarlıdır. **Merke:** Önce tanı koymak zorunda değilsiniz — **yaşamı tehdit eden durumu tanıyıp hızlı harekete geçmek** esastır.

1.1 Kalp (ZF S. 1–3; F 5–25)

Mediastinum'da; ⅔ solda, ⅓ sağda; yumruk büyüklüğünde; arkasında yemek borusu/omurga, altında **Zwerchfell**. **4 oda:** 2 kulakçık (**Vorhof/Atrium**), 2 karıncık (**Kammer/Ventrikel**), ara duvar **Septum**; **Herzklappen**. Sağ kalp: **oksijenden fakir** kan → akciğer; sol kalp: **oksijenden zengin** kan → vücut (sol karıncık en kuvvetli). **Duvar:** Endokard, Myokard, Epi-/Perikard. **Koroner damarlar:** sağ/sol koroner arter aortadan çıkar; ani tıkanma = **Herzinfarkt**. **İleti sistemi: Sinusknoten → AV-Knoten → His-Bündel → Tawara (Kammerschenkel) → Purkinje.** Frekanslar (F 22 görseli): **Sinus 60–100/dk**, AV 40–45, His 40–45, Kammerschenkel 40–45, Purkinje 35–40. ⚠ ZF "60–80" yazıyor (çelişki). Dolaşım durmasında ritimler: **Kammerflimmern (VF)**, **Asystolie**.

1.2 Dolaşım (ZF S. 4–5)

Büyük dolaşım: sol karıncık → aort → arterler → **kapillerler** (O_2/besin verilir, CO_2 alınır) → venler → sağ kalp. **Küçük dolaşım:** sağ karıncık → akciğer arteri → alveol kapillerleri → akciğer venleri → sol kalp. **Merke:** *Arter kalpten uzağa, ven kalbe* (O_2 içeriğinden bağımsız). **Tansiyon:** örn. 120/80 mmHg; **systolisch** = atım, **diastolisch** = dolum; aortun **Windkessel** işlevi. **Nabız terimleri (F 122):** Taşikardi > 100/dk (yenidoğan > 170, küçük çocuk > 130); Bradikardi < 60/dk; **Asystolie** = elektriksel+mekanik kalp aktivitesinin tam durması (F: "> 2 sn" ⚠).

1.3 Akciğer ve solunum (ZF S. 5–7)

Sağda **3**, solda **2** lob (kalp yüzünden). Yol: ağız/burun → yutak → gırtlak → **Trachea** → 2 ana bronş → bronş ağacı → **Alveolen** (gaz alışverişi). Görev: O_2 alma, CO_2 verme, asit-baz dengesi.

Kavram	Anlam
Ventilation	akciğerin havalandırılması
Diffusion	alveol ↔ kan gaz alışverişi
Perfusion	akciğer kanlanması

Etkili gaz alışverişi için **üçü birlikte** çalışmalı. **Inspiration** (nefes alma) / **Exspiration** (verme).

2. Acil ve ilk yardım — tanım ve hukuk

Notfall (ZF S. 7; F 59–61): bilinç, solunum, kalp-dolaşımın **akut yaşamı tehdit eden** bozukluğu (travma, hastalık, zehirlenme); acil tedavi olmazsa kalıcı hasar/ölüm. *Özellikler (F 80):* beklenmedik, değişken, vital tehdit, yardıma muhtaç, olağanüstü, hızlı yardım. **Behandlungspflicht** = doktorun tedaviyi reddetme özgürlüğüne istisna (F 62–63). **Erste Hilfe (ZF S. 7–8; F 65):** profesyonel yardım gelene kadar **laik/ilk yardımcı** önlemleri: tehlikeyi tanı, olay yerini güvene al, **112**, yaşam kurtaran ilk önlemler, hastaya bakma, izleme. *Amaç:* tam tedavi değil; **tehlikeyi tanımak, yaşamsal işlevleri sürdürmek, profesyonel yardımı organize etmek. Hukuk (ZF S. 8; F 66–79, 231–233):**

- **§ 323c StGB — Unterlassene Hilfeleistung:** kaza/ortak tehlike/acil durumda yardım **gerekli ve makul** olduğu hâlde (özellikle **önemli kendi tehlikesi yok** ve başka önemli yükümlülük ihlali yok) yardım etmeyen **1 yıla kadar hapis veya para cezası**; yardım edeni **engelleyen** de cezalanır. Örnek (F 71): yüzme bilmeyen derin suya atlamak zorunda değil; çocuğuyla uçurum kenarındaki kişi çocuğu bırakmak zorunda değil.
- Yardım **bilgi ve becerinize** göre; **sağlık mesleklerinde** daha yüksek beklenti olabilir.
- **Garantenstellung (§ 13 StGB, ihmal):** hemşirenin emanet edilen hastaya karşı **özel yükümlülüğü** (F 78, 232).
- **Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB):** şimdiki, başka türlü önlenemez tehlike; **en hafif araç**; korunan menfaat **belirgin şekilde ağır basmalı.** Örnekler (F 76–77): akut nefes darlığında **doktor talimatı olmadan** acil ilaç (tek çare ise) · kilitli kapıyı kırmak. ⚠ **İstisnadır, serbest geçiş değil.**
- **Sorumluluk (F 67, 79): gerekli özenle** yapıldığında genelde cezai/tazminat sonucu yok (kötüleşme/ek hasar olsa bile); varsayılan rıza/GoA §§ 677 vd. BGB.
- ⚠ Hukuki tavsiye değildir. Metin: dejure.org/gesetze/StGB/323c.html (F 69'daki link).

3. Güvenlik, acil çağrı, kurtarma zinciri

Eigensicherung hat Vorrang! (ZF S. 9; F 104) Tehlikeler: trafik, yangın/duman, elektrik, kimyasal, **enfeksiyöz madde**, tehlikeli nesneler. Gerekirse önce itfaiye/polis/RD çağır. **Sıra (F 106):** güvene al → genel bakış → tehlikeden kurtar → acil çağrı → hastaya bak. Trafik (F 107): dörtlü, reflektif yelek, **uyarı üçgeni: şehir içi ≈ 50 m, şehir dışı ≈ 100 m, otoyol 200–300 m**; güvenlik mesafesi ≈ 15–20 m. **Notruf 112 — W-Soruları (ZF S. 9–10; F 88): Wo?** (olay yeri) **Wer ruft an? Was ist geschehen? Wie viele Betroffene? Rückfragen bekle!** Leitstelle talimat verir (**Telefonreanimation**). **Zehirlenme:** Wer (yaş/kilo)? Womit? Wie viel? Wann? Hangi belirti? Ne yapıldı? (F 89'daki numara ⚠ doğrula). **Rettungskette (F 99–102):** ilk müdahale + acil çağrı → ileri ilk yardım → Rettungsdienst → hastane; "zincir en zayıf halkada kopar". **Gerçekler (F 81–82):** Avrupa'da yılda ≈ 700 000 ani kalp ölümü; ≈ %40 başlangıçta VF; erken CPR+defibrilasyonla yaşam şansı %70'e kadar; müdahalesiz **dakikada −%10**.

4. İlk değerlendirme

Bilinç (ZF S. 11; F 110–112): yüksek sesle seslen → **omuzdan sarsala** → gerekirse **ağrı uyaranı**. Bilinçsizlik: koruyucu refleks yok → **solunum yolu tıkanması (dil), aspirasyon.** Beyin basıncı belirtileri (F 112): bulantı/kusma, baş ağrısı, anizokori, huzursuzluk, anormal solunum. **Hava yolu (ZF S. 11–12; F 113–116):** alna el, **kafayı geriye (Überstrecken), çeneyi kaldır**; **Esmarch-Handgriff** (F 114, profesyoneller). Solunum: **Sehen–Hören–Fühlen, en fazla 10 saniye. Schnappatmung ≠ normal solunum** (F 119). Ağız-yutak muayenesi yalnızca yabancı cisim şüphesinde. **Nabız (F 123):** laiklerde zorunlu değil; **sağlık personeli olarak** ≤ 10 sn; şüphede **hemen kalp masajı. Präkardialer Faustschlag** yalnızca monitörde kesin VF'de ve 10 sn içinde (F 124). **Stabile Seitenlage (ZF S. 12; F 117–118):** bilinçsiz ama **normal soluyor** → hava yolunu açık tut → acil çağrı → **solunumu düzenli kontrol** → yalnız bırakma; kötüleşirse yeniden değerlendir → gerekirse CPR. **Merke: Tepki yok + normal solunum yok = dolaşım durması şüphesi. "Phone first / phone fast" (F 126):** erişkin: önce acil çağrı sonra CPR; çocuk: önce hava yolu, 1 dk CPR, sonra çağrı (⚠ şematik; GRC 2025: laik solunumu çağrıdan **sonra** kontrol eder, F 86).

5. Temel yaşam desteği (BLS) ve AED

5.1 Erişkin şeması (F 121, 163; ZF S. 12–15)

Prüfen (bilinçsiz) → Rufen (yardım/112, hoparlör) → Atemweg öffnen, solunum ≤ 10 sn → Drücken (CPR başla) → AED getirt/tak, talimatlara uy → CPR'ye RD/ekip gelene kadar devam. Yalnızsanız hastayı bırakmayın.

Parametre	Erişkin (ZF S. 13; F 137, 163)
Zemin	**sert zemin**, üst gövde açık; yardımcı yanında diz çöker
Basınç noktası	**göğsün ortası / alt sternum üçte biri** (meme uçları arası)
Eller	bir elin topuğu, diğeri üstüne, parmaklar kenetli; **kollar dik, omuzlar dik**

Parametre	Erişkin (ZF S. 13; F 137, 163)
Frekans	**100–120/dk** (⚠ F 137: "100", F 140/172: "80–100")
Derinlik	**5–6 cm** (≥ 5, ≤ 6; F 140: "½ toraks")
Bırakma	**tam**, el teması kaybolmadan
Oran	**30 : 2** (yardımcı sayısından bağımsız)
Ara	**mümkün olduğunca kısa**
Yardımcı değişimi	**2 dakikada bir** (5 dk'da doğru kompresyon > %90'dan %18'e düşer, F 138)

Pathofizyoloji (F 128): toraks kompresyonu → intratorasik basınç ↑ + doğrudan kalp sıkışması; sistolik ≈ 80 mmHg; akım ancak **kesintisiz** sürer. **Solunum (ZF S. 13–14; F 143–147):** 30 kompresyondan sonra **2 soluk**, **eğitimliyse ve güveniyorsa**: ağızdan ağıza/buruna veya **Beatmungsbeutel (C-Griff, rezervuarla > %90 O_2)**. **Soluk verilmezse kesintisiz kompresyon**, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir ("Irgendeine Reanimation ist besser als keine!").

5.2 AED (ZF S. 14–15; F 152–161)

Ritmi **kendisi analiz eder**, gerekirse şok verir; **laikler için** tasarlı, sesli/görsel talimat. **3–5 dk içinde defibrilasyon → yaşam %50–70**; VT/VF ≈ %83 şoklanabilir. **Adımlar:** ① aç ② **elektrotları** şemaya göre yapıştır (birden çok yardımcı varsa CPR **devam**) ③ sesli talimat ④ **analiz sırasında kimse dokunmaz** ⑤ şok önerildi: **geri çekil, kimse dokunmasın, şok** ⑥ **hemen CPR** ⑦ şok önerilmezse de **hemen CPR 30:2**. **Çocuk: 8 yaştan** erişkin AED; **1–8 yaş** tercihen çocuk elektrotu/modu. **Merke:** *AED kalp masajının yerini tutmaz. · Kötü resüsitasyon hiç yapmamaktan iyidir.*

5.3 Çocuklarda BLS (F 121, 131–135, 141–142, 146)

Bebek < 12 ay; çocuk ≥ 1 yaş. Akış: tepki (**asla sallama**) → yardım/112 → hava yolu (bebek nötr, çocuk hafif geriye) → solunum yoksa **5 başlangıç solunumu** (bebek ağız **ve** burun) → **15 : 2** (**PBLS eğitimliyse**; **eğitimsizse** erişkin algoritması **30:2** + 5 soluk, F 121) → yalnızsanız **1 dk** CPR sonra çağrı. **Derinlik: toraks çapının ⅓'ü**; frekans 100–120/dk (⚠ F 141 "4 cm", F 142 "5 cm"). **Yabancı cisim (F 146):** etkili öksürük → cesaretlendir; etkisiz+bilinçli: bebek **5 sırt vuruşu/5 kompresyon**, çocuk **5 sırt vuruşu/5 karın kompresyonu**; bilinçsiz: hava yolu, **5 soluk denemesi**, sonra PBLS. ⚠ Çocuk değerleri okula göre değişir → uygulamalı kurs/güncel GRC–ERC.

5.4 ALS ve hastane içi (ZF S. 15–16; F 171–193)

ALS = profesyonel gelişmiş önlemler: hava yolu güvenliği (entübasyon, larenks maskesi/i-gel), ventilasyon, EKG, **defibrilasyon** (bifazik **120–360 J**; 2 dk sonra ritim kontrolü; kendini koru: **"Ich defibrilliere – yataktan uzak, O_2 kaldır"**), damar yolu (i.v./i.o.), ilaçlar (⚠ yalnız bilgi: **adrenalin 1 mg, amiodaron 300 mg** 3. şoktan sonra — **sadece doktor**), **geri döndürülebilir nedenler** (4H/4T). **Ritimler:** *şoklanabilir* **VF/nabızsız VT** · *şoklanamaz* **PEA/Asistoli**. **ROSC** sonrası ABCDE (F 190). **Hastane içi (F 164, 189):** yardım çağır & değerlendir · yaşam belirtisi yok → **Rufen, Drücken, Equipment**; Reanimationsteam, defi; ritim kontrolünde değişim; **SBAR devri**. Aksi hâlde **tıbbi acil** → ekip, ABCDE. **Sınırlar/etik (F 173, 191–192):** BLS'nin sınırı var; ilkeler: fayda, zarar vermeme, **hasta özerkliği**, adalet; **durdurma kriterleri** tek kural yok; hasta talimatı ⚠. **GRC 2025 yenilikleri (F 86 — doğrulanmadı):** hızlı kompresyon, laik solunumu çağrıdan sonra kontrol, profesyonelde 3 şok sonrası pad yön değişimi vb.; ⚠ **metin/kaynak 2021** — grc-org.de. **Stajyer:** yalnızca **kendi yetki alanında**, **kurum standardına** ve **sorumlu PFK** ile (F 167).

5.5 ABCDE

	Anlam	Kontrol
Airway	hava yolu	açık mı? yabancı cisim, kusmuk, kan, horlama, **stridor**
Breathing	solunum	normal mi? sayı, efor, cilt rengi, SpO_2
Circulation	dolaşım	nabız, cilt, tansiyon, **şiddetli kanamayı durdur**
Disability	nörolojik	bilinç (**AVPU**: uyanık – sese – ağrıya – tepkisiz), pupil, **kan şekeri**, zehirlenme

	Anlam	Kontrol
Exposure/Environment	muayene/ çevre	mümkün olduğunca tam ama **onurlu**, ısı koru, anamnez

Sorun bulununca **hemen müdahale**, sonra devam, sonra **tekrar kontrol. İstisna:** tepkisiz + normal solunum yok → **önce alarm + CPR.**

6. Şok (ZF S. 16–17; F 195–204)

Tanım: hayati organların **yetersiz kanlanması** → doku hipoksisi, O_2 arz/ihtiyaç uyumsuzluğu → hücre ölümü, **çoklu organ yetmezliği**; kısır döngü (asidoz). **Belirtiler: hipotansiyon, taşikardi, taşipne, oligüri, bilinç bozukluğu, mermerimsi soğuk cilt, laktat ↑.**

Biçim	Neden	Örnek
hypovolämisch	kan/sıvı kaybı	kanama, susuzluk, yanık
kardiogen	kalp yetersiz pompalar	**enfarktüs**, dekompanse yetmezlik, aritmi
obstruktiv	mekanik engel	**akciğer embolisi**, gerilim pnömotoraksı, tamponad
distributiv	damar dağılım bozukluğu	**anafilaksi, sepsis**, SSS travması

Schockindex (Allgöwer/Burri): SI = kalp hızı ÷ sistolik tansiyon. Normal **0,5–0,7**; **≥ 1,0** şok olası (hipovolemide kan kaybı > %30); **> 1,5** ağır şok. Örnek: nabız 120, RR 80 → **1,5**. Yalnızca **anlık yönlendirme**. **Tedavi (F 203):** O_2, gerekirse entübasyon, nedeni gider, semptomatik acil tedavi, akım/tansiyon/O_2 arzını düzelt. **İlk yardım:** acil çağrı, kanamayı durdur, sıcak tut, konuş, vital takip; şok pozisyonu yalnızca uygun durumda ⚠ (kursta öğrenin). Bağlantı: **Recap > 2–3 sn**, **ateş krizi** (04, 05).

7. Önemli acil durumlar

7.1 Astım (ZF S. 17–18; F 205–207): kronik hava yolu hastalığı; **ataklar halinde nefes darlığı, öksürük. Allerjik** (polen, hayvan tüyü, ev tozu akarı, küf, besin) ↔ **allerjik olmayan** (efor, soğuk, sigara dumanı, stres, ilaç, parfüm). **Ağır atak:** sakin kal, **acil çağrı**, **verilmiş/talimatlı acil ilacı destekle**, inhalasyon. (Doz yok; talimatla.) **7.2 Kalp krizi (ZF S. 18–19; F 208–216): koroner tıkanma** → kas iskemisi; zaman = kas. **Belirtiler:** şiddetli göğüs ağrısı, **baskı/daralma**, **yanma**, yayılma (kol, sırt, üst karın, boyun, çene, omuz), nefes darlığı, bulantı/kusma, **soğuk ter, solgun cilt, ölüm korkusu. Kadın/yaşlılarda atipik:** nefes darlığı, terleme, **sırt ağrısı, üst karın, bulantı, olağandışı yorgunluk** (F 212). **Risk:** göbek obezitesi, stres, hareketsizlik, yağlı beslenme, kolesterol, **hipertansiyon, sigara, diyabet.** → **112**, yalnız bırakma. **7.3 İnme/Apoplex (ZF S. 19–20; F 217–226):** iskemi **veya** beyin kanaması. **Belirtiler: tek taraflı yüz felci**, **ani kol/bacak felci**, **konuşma/anlama bozukluğu**, görme bozukluğu/çift görme/körlük, şiddetli baş dönmesi/dengesizlik, **yutma bozukluğu**, bilinç bozukluğu, **ani şiddetli baş ağrısı. Zaman = beyin** → hemen 112. Risk: yaş > 70, hipertansiyon, sigara, yağ metabolizması, obezite, alkol, "hap", diyabet, kalp, pıhtılaşma. **7.4 Akciğer embolisi (ZF S. 20–21; F 219–223):** pıhtı (çoğunlukla **derin bacak veni**) akciğere gider; ölüm ≈ %10, çoğu ilk saatlerde. **Risk: immobilizasyon, ameliyat**, yaş, tümör, hormonal (doğum kontrol, gebelik, HRT), pıhtılaşma bozukluğu. **Belirtiler: ani nefes darlığı**, plöritik/retrosternal ağrı, öksürük, ateş, **kanlı balgam**, **senkop**, dolaşım sorunu; **tek taraflı bacak ağrısı/şişlik/sıcaklık/ağırlık**. Bağ: **tromboz profilaksisi** (07). **7.5 Kanama ve yaralar (ZF S. 21–22; F 227–229):** damar sisteminden kan çıkışı → hipovolemik şok. **Yara türleri:** mekanik (kesik, yırtık), termal (yanık, donma), kimyasal (asit), ışın. **Kanamayı durdurmak öncelik**; ciddi yaralanmada erken yardım. **Eldiven** (enfeksiyon). Pansuman teknikleri PDF'de yok ⚠.

8. Serviste akış (ZF S. 22–25) — "hasta yerde yatıyor"

1. **Güvenlik** 2) **Genel bakış** 3) **Tepki** (seslen/sars) → tepkisiz → **hemen yardım çağır** 4) **Hava yolu aç, solunum ≤ 10 sn** 5a) **normal soluyor** → stabil yan yatış (mümkünse), yardım, solunum izle ✧ 5b) **normal solumuyor** → **dolaşım durması**: **acil çağrı/hastane acil sistemi**, **CPR 100–120/dk, 5–6 cm**, **AED mümkün olan en erken**, ekip devralana kadar 6) **İzle** 7) **Yapılandırılmış devir (SBAR). Merksätze (ZF S. 23–24):** 1 Kendini koru · 2 Acil her an olabilir — sakin, yapılandırılmış · 3 Bilinç + solunum merkezi · 4 112'yi erken ara, soruları bekle · 5 Her dakika önemli · 6 100–120/dk, 5–6 cm, kesintisiz · 7 30:2 · 8 AED erken · 9 Bilinçsiz + normal solunum →

yan yatış · 10 Tanı şart değil — tehlikeyi tanı ve harekete geç. **Kapanış: ERKENNEN – HILFE RUFEN – HANDELN – ÜBERWACHEN.**

9. Terimler

Almanca	Türkçe
der Notfall / der Notruf	acil durum / acil çağrı
der Rettungsdienst / die Leitstelle	kurtarma hizmeti / kontrol merkezi
die Eigensicherung	kendini koruma
bewusstlos	bilinçsiz
die Schnappatmung	agonal solunum
die stabile Seitenlage	koma pozisyonu
die Herzdruckmassage	kalp masajı
die Beatmung	suni solunum
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması
das Kammerflimmern / die Asystolie	ventriküler fibrilasyon / asistoli
der Defibrillator (AED)	defibrilatör
der Schock / der Schockindex	şok / şok indeksi
die Garantenstellung	garantör konumu
die unterlassene Hilfeleistung	yardım etmeme suçu

Karıştırılanlar: BLS ↔ ALS · Ventilation ↔ Diffusion ↔ Perfusion · **Herzinfarkt ↔ Herzstillstand** (enfarktüs = kanlanma sorunu, hasta bilinçli olabilir; durma = pompa yok) · Apoplex ↔ Synkope.

10. Sınav bilgisi

Sık: BLS rakamları · solunum kontrolü (SHF ≤ 10 sn) · W-soruları · AED adımları · §323c/Garantenstellung/§34 · şok biçimleri · inme belirtileri · kadında atipik enfarktüs · SBAR. **Hatalar:** Schnappatmung'u normal saymak · nabız aramakla dakikalar kaybetmek · yüzeysel/yavaş/kesintili kompresyon · analiz sırasında dokunmak · şoktan sonra CPR'yi bırakmak · "önce ABCDE" (CPR hastasında). **Almanca kalıp:** „Bei fehlender Reaktion und fehlender normaler Atmung wird ein Kreislaufstillstand angenommen; es werden der Notruf abgesetzt und die Herzdruckmassage mit 30:2 begonnen.“ **Kontrol (ZF S. 26, 20 soru) → cevaplar:** Ek 5 Klausur 3.

09 — Bakım süreci ve klinik düşünme (Bölüm E) — şablon + işlenmiş örnek

> Temel: Lernskript S. 4 (6 aşama), Arbeitsblatt S. 6–8, Frau Berger/Herr Schneider vakaları, bölüm 03–08. **Uyarı:** Eğitim örnekleridir. Gerçek bakım planı: anamnez, değerlendirme, **doktor talimatı**, kurum standardı, **PFK** (§ 4 PflBG: planlama ve yönetim hemşireye saklıdır). Stajyer **eşlikle** çalışır.

1. 6 aşama — soru ve kontrol listesi

Aşama	Ana soru	Kontrol listesi
1 **Informationssammlung**	Ne biliyorum? Ne eksik?	anamnez (tanı, öykü), **gözlem** (cilt, solunum, hareket, ısı, ağrı), **görüşme**, ABEDL, biyografi, yakınlar, yardımcı araçlar, ilaçlar (bilgi; değiştirme!)
2 **Probleme & Ressourcen**	Neyi kısıtlıyor? Kişi neyi yapabilir?	sorun **+ neden + belirti**; kaynaklar (yetenek, motivasyon, sosyal ağ); **riskler** (düşme, dekubitus, tromboz, pnömoni, susuzluk, enfeksiyon)
3 **Pflegeziele**	Neye ulaşılmalı?	hasta odaklı, gerçekçi, **ölçülebilir (zaman)**; yakın/uzak hedef
4 **Maßnahmen planen**	Ne, ne sıklıkta, kim, neyle?	**somut**, etkili, kaynak destekleyici, özerklik; yetki devri netleştir
5 **Durchführung**	Nasıl uygulanır?	duyur, katılım, mahremiyet, güvenlik, **hijyen**; sapmaları bildir
6 **Evaluation**	Etki?	hedef: ulaşıldı/kısmen/ulaşılmadı; neden; planı uyarla; **dokümante et**

Klinik düşünme 10 sorusu: 01 §5: 1 temel sorun · 2 eksik bilgi · 3 önemli belirti · 4 riskler · 5 kaynaklar · 6 hedefler · 7 önlemler · 8 değerlendirme · 9 kime/ne zaman haber · 10 dokümantasyon. **Birden fazla doğru cevap olduğunda öncelik:** 1) hayati tehlike (ABCDE/acil) → 2) akut riskler (düşme, aspirasyon) → 3) konfor/özerklik/psikososyal. Daima **özerklik ve mahremiyet**; red durumunda neden sor, alternatif sun, sonra tekrar öner, dokümante et, PFK'ye bildir.

2. İşlenmiş örnek: Herr Schneider (alıştırma kitapçığınızdaki vaka)

Özet: 78 yaş, yalnız, düşme, cerrahi servis; sağ kalça ağrısı, zor kalkıyor; güvensiz/korkak; **çok terliyor**, giysi kirli, **az içmiş**; yıkanmayı reddediyor (rahatsız edici).

Aşama 1 — Bilgiler

Mevcut	Eksik (sor/bak)
düşme, kalça ağrısı, mobilite ↓, yalnız yaşıyor, korku, terleme, az içme, hijyen açığı, yıkamayı reddetme	düşme nedeni (baş dönmesi? ilaç? görme?), **vital bulgular (ısı!)**, ağrı şiddeti/analjezi (doktor), oryantasyon/biliş, gözlük, cilt, boşaltım, beslenme, yakınlar, evdeki bakım, istekleri

Önemli belirtiler: terleme + az içme → **susuzluk/ateş?**; immobilite → **tromboz, pnömoni, dekubitus riski**; yaş + düşme → **kırık, kafa içi basınç**.

Aşama 2 — Sorun/Kaynak

Sorun (+neden)	Risk	Kaynak
düşme sonrası ağrı + kısıtlı hareket	düşme, tromboz, dekubitus, pnömoni	korkusunu açıkça söylüyor, **bağımsızlık istiyor**
sıvı açığı (az içme, terleme)	susuzluk, delir, dolaşım	kendi içebiliyor mu?
bakımda öz bakım açığı (utanç)	cilt sorunu, enfeksiyon, onur	rahatsızlığını ifade edebiliyor
özerklik kaybı korkusu	çekilme, depresyon	önceden bağımsızdı

Aşama 3 — Hedefler (ölçülebilir örnek)

1. **24 saat içinde** ağrının dinlenirken katlanılabilir olduğunu belirtir (ölçek kurum standardına). 2) Akşama kadar **[doktor/PFK ile belirlenen miktarı]** içer ⚠ (miktar PDF'de yok). 3) Hangi bölgeleri kendisinin yıkayacağına **kendi karar verir**; mahremiyet korunur. 4) Önümüzdeki günlerde destekle güvenle kalkar, **yeni düşme olmaz**. 5) Taburculuk sonrası destek olanaklarını söyler.

Aşama 4 — Önlemler (eşliklə/anlaşmayla)

- **Gözlem:** vital bulgular **ısı dahil (aynı yer)**, cilt/turgor, ağrı, içilen/idrar, oryantasyon (04, 05).
- **Mobilizasyon** eşlikle; araç, fren, ayakkabı, yol açık (06); düşme riski; risk varsa **tromboz** (erken mobilizasyon, egzersiz, içme) ve **pnömoni (LISA)** profilaksisi (07).
- **İçecek teklifi**, tercihler, hatırlatma; **içme protokolü** (talimat/standart).
- **Bakım:** duyur, **seçenek sun** („Möchten Sie … selbst waschen?“), perde, çamaşır değişimi; cilt gözlemi (kıvrımlar, topuk, sakrum).
- **Görüşme:** korkuyu ciddiye al, bilgi ver, sürece kat, yakınlar; gerekirse sosyal hizmet.
- **PFK/doktora haber:** ateş, delir/huzursuzluk, yeni ağrı, nefes darlığı, bilinç değişimi, tek taraflı bacak şişliği, kötüleşme.

Aşama 5 — Uygulama

Zaman, kim, nasıl, tepki; sapma („yıkamayı reddetti“) → bildir/dokümante.

Aşama 6 — Değerlendirme

Hedef	Ölçüt	Karar
Ağrı	ifade/skala, mobilizasyon	uyarlama? doktor?
İçme	miktar	artır? engel?
Bakım/özerklik	katılım, memnuniyet	teklifi uyarla
Hareket/düşme	güvenli kalkış? olay?	planı değiştir

Dokümantasyon örneği (nesnel): *„08:15: Pat. äußert Schmerzen im rechten Hüftbereich (Skalawert 6); Schmerzmittel laut Anordnung durch PFK [yalnızca gerçekten verildiyse]. 09:00: Pat. lehnt Unterstützung beim Waschen ab, gibt an, die Situation sei ihm unangenehm; Angebot, Gesicht/Arme selbst zu waschen, wird angenommen. PFK informiert.“*

3. Frau Berger — plan taslağı

01 §2 + Lernskript S. 4. **Ek:** gözlüğü getirt (kızından iste; **görme = düşme riski**), mobilizasyondan önce ağrıyı değerlendir, "her şeyi benim yerime yapmayın" → **aktive edici bakım**, taburculuk planı (yalnız, kızı).

4. Sınavda 6 satırlık bakım planı kalıbı

„**Information:** … **Problem/Ressource:** … **Ziel:** … (Zeitpunkt) **Maßnahmen:** … **Durchführung:** … **Evaluation:** … **Bei Verschlechterung muss die Pflegefachkraft/der Arzt informiert werden.**“

Alıştırma: Frau Berger (81; rolatörle gidiyordu, kalkarken birkaç deneme, koltukta kalıyor) için 6 satırlık süreç yaz → örnek: Ek 5 Klausur 4.

10 — Bakım dokümantasyonu, operatörler ve sınavda yazma (Bölüm J)

> **Kaynaklar:** Operatoren-Training (Übungsheft S. 3 — Türkçe notlarınızın bulunduğu fotoğraf) · Fall Herr Schneider (S. 4) · Thieme S. 13–15 · Sturzprotokoll (F 14). Dokümantasyonun hukuki ayrıntıları (saklama süresi, düzeltme kuralı) PDF'lerde yok → kurum/okul standardı ⚠.

1. Operatörler (Handlungsanweisungen)

Operatör = görevde **ne** ve **ne derinlikte** yazacağınızı belirler. **AFB** = **Anforderungsbereich**: **I Reproduktion** (bilgiyi aktarma), **II Reorganisation und Transfer** (bilgiyi yeniden düzenleme/uygulama), **III Reflexion und Problemlösung** (değerlendirme, çözüm üretme).

Operatör	AFB	Ne isteniyor (Übungsheft)	Türkçe	Cevap ipucu
NENNEN	I	kavram/veri/olguyu **kısa ve kesin** belirt; anahtar kelime olur	saymak	liste, açıklama yok
BESCHREIBEN	I	olguyu **yapılandırılmış, kendi kelimelerinizle, tam cümlelerle, meslek diliyle, değerlendirmeden** anlat	betimlemek	nesnel, sıralı
ZUORDNEN	I	ilişkileri/kavramları/süreçleri **birbirine bağla**	eşleştirmek	tablo/ok
ZUSAMMENFASSEN	I	en önemli ifadeleri **kısa ve kendi sözlerinizle**	özetlemek	3–5 cümle
DEFINIEREN	I	kavramın anlamını ve **karakteristik özelliklerini** ver	tanımlamak	„X ist …, Merkmale: …“
ERMITTELN	II	**analitik çalışarak** saptamak/ çıkarmak/türetmek	tespit etmek/belirlemek	metinden türet
ERKLÄREN	II	**nedenleri, koşulları, sonuçları anlaşılır kılmak**; yardımcı: **„weil“**	açıklamak	neden → sonuç
VERGLEICHEN	II	**benzerlik ve farkları** ortaya koy	karşılaştırmak	tablo + sonuç
ANWENDEN	II	edinilen bilgiyi **yeni/değişmiş durumda** kullan	uygulamak	vakaya bağla
BEGRÜNDEN	III	**neden** öyle olduğunu, **mesleki argümanları** göster	gerekçelendirmek	iddia + argüman + örnek
DISKUTIEREN	III	görüşü destekleyen/çürüten **argümanları karşılaştır ve tart**	tartışmak	Pro/Contra/Sonuç
STELLUNG BEZIEHEN	III	eleştirel incele, **gerekçeli yargı** ver	görüş bildirmek	karar + gerekçe
ENTWICKELN	III	**kendi fikirlerini** ortaya koy ve gerekçelendir	geliştirmek	çözüm + gerekçe
DEUTEN	III	**başka bir kişinin bakış açısını** al, davranışını anlamaya çalış	yorumlamak	„Aus Sicht von … könnte …“

Hatırlama (kendi önerim): I = *bilgiyi söyle* · II = *bilgiyi dönüştür* · III = *bilgiyi değerlendir/üret.* **Sık hatalar:** "Erklären"da sadece sıralamak · "Beschreiben"da yorum ("kötü") · "Begründen"da *weil/da/denn* yok · "Nennen"da gereksiz uzun yazmak · operatörü okumamak.

Herr Schneider — geliştirilmiş cevap Aufgabe 2 (BESCHREIBEN):

> *„Herr Schneider, 78 Jahre alt, lebt allein und wird nach einem Sturz zu Hause auf die chirurgische Station aufgenommen. Er gibt Schmerzen im rechten Hüftbereich an und steht nur mit Mühe auf. Bei der Aufnahme wirkt er unsicher; er äußert: ‚Ich habe Angst, dass ich jetzt nicht mehr alleine zurechtkomme.‘ Er schwitzt stark, seine Kleidung ist verschmutzt, und er hat seit dem Morgen nur wenig getrunken. Hilfe beim Waschen lehnt er zunächst ab, da ihm die Situation unangenehm ist.“*

(*wirkt* = izlenim, *äußert* = ifade; değerlendirme yok.) **Aufgabe 4 (ERKLÄREN):** *„Herr Schneider hat möglicherweise Angst, seine Selbstständigkeit zu verlieren, weil er bisher allein lebte und seinen Alltag selbst organisierte. Durch den Sturz hat er Schmerzen und kann sich nur eingeschränkt bewegen, sodass er nun auf fremde Hilfe angewiesen ist. Zusätzlich ist ihm die Körperpflege durch andere unangenehm. Er fürchtet daher, nach der Entlassung nicht mehr allein zurechtzukommen.“*

2. Dokümantasyonun temel ilkeleri

İlke	Açıklama
Gözlem ≠ yorum	gözlem: gördüğüm/ölçtüğüm/duyduğum; yorum: benim yorumum
Nesnel ve somut	sayı, yer, saat, sıklık, boyut
Zaman – bulgu – önlem	*Ne zaman? Ne saptandı? Ne yapıldı? Etki? Kime haber verildi?*
Belirsiz sözcük yok	"biraz", "oldukça", "normal", "kötü", "huzursuz" (açıklamasız)
Hasta sözleri	tırnak içinde / „Pat. gibt an …“
Yalnızca yapılanı yaz	**yapılmayan işlemi asla yapılmış gibi yazma**
Hata/eksik	kurum kurallarına göre düzelt (silme/okunmaz yapma yok) ⚠
Veri koruma	yalnızca gerekli bilgi, gizlilik

Fiiller: *beobachten* (yargısız algılamak) ↔ *beurteilen* (gözlemden bilgiyle sonuç çıkarmak); *dokumentieren, melden, äußern, angeben, klagen über.* **Pflegeplanung** (hedef/önlem planı) ↔ **Pflegedokumentation** (gözlem ve uygulamanın kanıtı).

3. Yanlış ↔ doğru

#	Kötü	İyi	Neden
1	„Pat. war heute schlecht drauf.“	„Pat. wirkt traurig, spricht kaum, lehnt Frühstück ab (isst 2 Bissen).“	somut, betimleyici
2	„Pat. hat Fieber.“	„12:30: Körpertemperatur 38,6 °C axillar, Haut heiß und gerötet, Pat. schwitzt. Arzt informiert.“	değer, yer, saat, tepki
3	„Pat. trinkt zu wenig.“	„Trinkmenge bis 14 Uhr ca. 300 ml laut Trinkprotokoll; Pat. gibt an, keinen Durst zu haben.“	ölçülebilir + ifade
4	„Pat. wurde mobilisiert.“ (olmadı)	„Mobilisation wegen Schwindels abgebrochen; Pat. sitzt an der Bettkante; RR gemessen: …“	**sadece gerçek**
5	„Pat. stürzte, ist aber okay.“	„14:05 Sturz im Bad, Pat. sitzt auf dem Boden, gibt Schmerzen am rechten Handgelenk an; keine sichtbare Kopfverletzung; Puls 88, RR 130/80 nach Beruhigung; PFK/Arzt informiert; Sturzprotokoll ausgefüllt.“	protokol içeriği
6	„Pat. ist aggressiv.“	„Pat. ruft laut: ‚Lassen Sie mich in Ruhe!‘ und schiebt die Hand der Pflegekraft weg.“	davranış + söz
7	„Haut gerötet am Po.“	„Kreuzbein: Rötung ca. 3 × 2 cm, auf Fingerdruck nicht wegdrückbar.“	Fingertest/yer
8	„RR ok.“	„RR 128/76 mmHg, Puls 78/min, regelmäßig.“	ölçü, yargı değil
9	„Pat. verweigert Pflege.“	„Pat. lehnt Hilfe beim Waschen ab mit der Begründung, es sei ihm unangenehm; PFK informiert; erneutes Angebot um 11 Uhr.“	gerekçe + özerklik

4. Şablonlar

Isı (Thieme S. 15): *saat, yer, sonuç, eşlik eden tedavi.* **Sturzprotokoll (F 14):** kişi · tarih/saat/yer · ortam · durum · önceki etkinlik · önlemler · sonuçlar. **Cilt:** yer · boyut · renk · sıcaklık · turgor · ağrı · Fingertest.

5. Sınavda yazma kalıpları (Bölüm J) — örneklerle

İşlev	Kalıp	Örnek
Giriş	„Zunächst ist zu beachten, dass …“	*… dass Fieber ein Symptom und keine eigenständige Erkrankung ist.*
Belirti	„Ein wichtiges Anzeichen dafür ist …“	*… für eine Exsikkose ist ein verminderter Hautturgor.*
Amaç	„Die Pflegemaßnahme dient dazu, …“	*Die Frühmobilisation dient dazu, die Muskel-Venen-Pumpe zu aktivieren.*
Değerlendirme	„Anschließend wird überprüft, ob …“	*… ob Herr Schneider die vereinbarte Trinkmenge erreicht hat.*
Eskalasyon	„Bei einer Verschlechterung des Zustands muss …“	*… muss die zuständige Pflegefachkraft bzw. der Arzt informiert werden.*
Gerekçe	„Das liegt daran, dass …“, „Aus diesem Grund …“	
Karşılaştırma	„Im Gegensatz zu … / Während …, …“	*Während die Hyperthermie …, beruht Fieber auf …*
Özet	„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass …“	
Tanım	„Unter X versteht man …“	
Görüş	„Meiner Einschätzung nach …, weil …“	

Daha fazlası: Ek 2.

6. Sınav bilgisi / hatırlatmalar

Anahtar: *Gör – ölç – yaz – yorumlama.* · "Dokümante edilmemiş = yapılmamış (uyuşmazlıkta), ama yalnızca yapılanı yaz" ⚠ (kural niteliğinde; hukuki ayrıntı PDF'de yok). **Alıştırma:** „Herr M. war den ganzen Tag unruhig und hat kaum was gegessen.“ → *„Herr M. läuft zwischen 10 und 12 Uhr wiederholt im Flur auf und ab, äußert ‚Ich weiß nicht, wo ich bin‘; Mittagessen: etwa ein Viertel gegessen.“* (kurgusal) **Kontrol:** 1) Beobachten ↔ Beurteilen? 2) Hasta sözleri neden alıntı? 3) Yapılmayan işlem ne olur? 4) „Anschließend wird überprüft, ob …“ ile cümle kur. 5) AFB II ve III operatörleri?

11 — Mesleki Almanca için gramer ve yazma becerisi (Bölüm I)

> Örnek cümleler PDF'lerdeki gerçek kalıplardan türetildi (*weil*-cümleleri, Passiv, Imperativ). Dilbilgisi açıklamaları genel bilgidir (⚠ PDF dışı). Seviyenizi bilmediğim için bir seviye varsaymadım; kısa tutuldu.

1. Artikel ve hâller (Fälle)

Fall	Soru	Örnek	der/die/das/die
Nominativ (özne)	Wer/Was?	**Der Patient** schläft.	der/die/das/die
Akkusativ (belirtili nesne)	Wen/Was?	Ich messe **den Blutdruck**.	**den**/die/das/die
Dativ (yönelme/dolaylı)	Wem?	Ich helfe **dem Patienten**. Ich erkläre **der Patientin** den Ablauf.	**dem/der/dem/den (+n)**
Genitiv (tamlama)	Wessen?	der Zustand **des Patienten**	des(-s)/der/des/der

Dativ fiilleri (ezber): *helfen, danken, gehören, gefallen, zuhören, antworten* → „Ich helfe **ihr**.“ **Wechselpräpositionen** (*in, auf, an, über, unter, neben, zwischen, vor, hinter*): **wohin?** → Akk. (*ins Bett legen*), **wo?** → Dat. (*im Bett liegen*). **Hata → neden:** „Ich helfe den Patienten“ ✘ → *helfen* Dativ ister: „**dem** Patienten“. „Ich messe dem Blutdruck“ ✘ → *messen* + Akk.: „**den** Blutdruck“. **Alıştırma:** (1) Ich gebe ___ Patient___ (m) ___ Tablette. (2) Ich dokumentiere ___ Temperatur. (3) Er liegt ___ Bett. (4) Ich lege ihn ___ Bett. → (1) dem, die (2) die (3) im (4) ins.

2. Zamanlar

Zaman	Biçim	Hemşirelikte ne zaman	Örnek
Präsens	messe	talimat, genel ifade, sözlü	„Ich messe jetzt Ihre Temperatur.“
Perfekt	habe gemessen / bin gestürzt	sözlü rapor, devir	„Frau B. **ist** gestürzt.“
Präteritum	maß, stürzte, war	**yazılı rapor**, vaka anlatımı	„Herr S. **lebte** allein.“

sein ile Perfekt: hareket/durum değişimi (*gestürzt, aufgestanden, eingeschlafen, gegangen*); diğerleri çoğunlukla **haben**. **Dokümantasyon** çoğu zaman Präsens/Präteritum veya **isim üslubu**: „Temperatur 38,6 °C axillar.“ Karıştırma.

3. Modalverben

Fiil	Anlam	Örnek
können	yapabilmek/mümkün	Frau Berger **kann** mitwirken.
müssen	zorunluluk	Der Arzt **muss** informiert werden.
dürfen	izin/yasak	Ich **darf** keine Auskünfte geben.
sollen	görev/talimat	Ich **soll** sie nach dem Frühstück mobilisieren.
wollen/möchten	istek	Er **möchte** selbst waschen.

Cümle yapısı: modal fiil **2. sırada**, mastar **sonda.** *nicht dürfen* = yasak ↔ *nicht müssen* = gerekmez.

4. Passiv

Vorgangspassiv = *werden + Partizip II*; yapan değil **eylem** önemli → rapor ve önlemlerde. *Die Temperatur **wird** gemessen.* Modalle: *Der Arzt **muss** informiert **werden**.* Geçmiş: *wurde gemessen.* Kaynaktan: „Die Strümpfe **dürfen** weder umgeschlagen **werden** noch einschneiden.“ **Zustandspassiv** = *sein + Partizip II* (sonuç): *Die Tür **ist** geschlossen.* **Hata:** „Der Arzt wird informiert“ (eylem) ↔ „ist informiert“ (sonuç).

5. Yan cümleler ve bağlaçlar (fiil sonda)

Bağlaç	İşlev	Örnek
weil / da	neden	Er hat Angst, **weil** er allein lebt.
dass	içerik	Ich beobachte, **dass** die Haut gerötet ist.
wenn	koşul/zaman	**Wenn** die Temperatur steigt, informiere ich den Arzt.
ob	dolaylı evet/hayır sorusu	Ich prüfe, **ob** das Ziel erreicht wurde.
damit / um … zu	amaç	**Um** Stürze **zu** vermeiden, räume ich Stolperfallen weg.
obwohl	karşıt neden	**Obwohl** er Schmerzen hat, will er aufstehen.
sodass	sonuç	…, **sodass** er auf Hilfe angewiesen ist.
nachdem / bevor / während	zaman	**Bevor** ich beginne, desinfiziere ich die Hände.
deshalb/daher	ana cümle (fiil 2.)	Er ist verlegen, **deshalb** lehnt er Hilfe ab.

Kural: Yan cümle önce gelirse ana cümlede **fiil hemen başta**: *Weil er Angst hat, **braucht** er Gespräche.* **ERKLÄREN operatörü → *weil*.**

6. Konjunktiv II — nazik rica ve teklif

Rica: **Könnten/Würden Sie …?** · Teklif: **Möchten Sie …? / Würden Sie lieber …?** · Tavsiye: **Ich würde …** · İstek: **Ich hätte gern …** Formlar: *könnte, würde, hätte, wäre, dürfte.* Nezaket = **Sie + Konj. II + bitte/gern.**

7. Imperativ — talimat

Sie: *Setzen Sie sich bitte. Atmen Sie tief ein.* · **du** (çocuk/yakın): *Setz dich.* · **Mastar talimat** (yazılı): *Hände desinfizieren.* **Hata:** „Sie setzen sich!“ (emir tonu) → „**Könnten Sie sich bitte hinsetzen?**“

8. Nesnel dil (rapor/dokümantasyon)

Öznel	Nesnel
„sieht schlimm aus“	„Wunde ca. 3 cm lang, gerötet, nässend“
„Pat. ist faul“	„Pat. lehnt Mobilisation ab (‚Mir tut alles weh‘)“
„Pat. übertreibt“	„Pat. gibt Schmerzen (NRS 8) an; Mimik angespannt“

Algı fiilleri: *wirken* (izlenim) · *äußern/angeben/klagen* (ifade) · *beobachten* · *feststellen* (ölçüm) · *vermuten* (varsayım — belirt!). **Çekinceler:** „möglicherweise“, „vermutlich“, „Hinweise auf …“, „spricht für …“.

9. Kelime türetme

Bileşik (Komposita): son sözcük artikeli belirler (*der Druck → der Blutdruck*). **Ekler:** -ung (f.): *Beobachtung, Messung*; -heit/-keit (f.): *Krankheit*; -er (m.): *Pfleger*; -ion/-tät (f.): *Infektion, Mobilität*; -mus (m.). **Çoğul:** -e, -en, ¨-e (*Hand → Hände*), -s; *-er* sonu kelimelerde genelde aynı (*Thermometer*). **İsimleştirme:** messen → die Messung; beobachten → die Beobachtung; mobilisieren → die Mobilisation.

10. Hata analizi yöntemi

Hata → **neden** → doğru kalıp → **kendi yeni cümleniz.**

Hata	Neden	Doğrusu
Er hat Angst, weil er **lebte** alleine.	yan cümlede fiil sonda	…, weil er **allein lebt / gelebt hat**.
Ich messe **dem** Blutdruck.	Akkusativ	…**den** Blutdruck.
Der Patient **ist** gelegen.	*liegen* yazı dilinde genelde **haben** (güney: sein)	Der Patient **hat** gelegen.

Hata	Neden	Doğrusu
Die Pflegekraft hat **informieren** den Arzt.	Perfekt = haben + Partizip II	…hat den Arzt **informiert**.
Pat. hat starke Schmerzen (sadece gözlendi)	gözlem ↔ ifade	Pat. **äußert** starke Schmerzen.

11. Alıştırmalar (cevap altta)

1. Passiv: *Die Pflegekraft desinfiziert das Thermometer.* 2) *weil*: *Er trinkt kaum. Er hat keinen Durst.* 3) Nazik: *Setz dich!* 4) Akk./Dat.: *Ich zeige ___ (die Patientin) ___ (der Ablauf).* 5) Nesnel: *Sie sieht blass und krank aus.* 6) Perfekt: *Frau B. (stürzen) im Bad.* 7) *nachdem*: *Ich dokumentiere die Maßnahme. Ich habe sie durchgeführt.* **Cevaplar:** 1) Das Thermometer wird desinfiziert. 2) Er trinkt kaum, weil er keinen Durst hat. 3) Könnten Sie sich bitte hinsetzen? 4) der Patientin den Ablauf. 5) Haut blass; Pat. wirkt erschöpft, äußert Müdigkeit. 6) ist gestürzt. 7) Nachdem ich die Maßnahme durchgeführt habe, dokumentiere ich sie.

12 — Almanya'daki mesleki bağlam (Bölüm K) ve çalışma planı (Bölüm L)

Bölüm K — Eğitim ve meslek bağlamı

> **Kaynak ayrımı:** Önce PDF'ler. PDF'de olmayanlar ⚠. **Hukuki tavsiye değildir**; eyalet/okul/kurum farklılık gösterebilir. gesetze-im-internet.de bu oturumda açılamadı.

Konu	Bilinen (kaynak)	Not
Pflegefachfrau / Pflegefachmann	unvan korunur, devlet izni (PflBG § 1; Lernskript S. 5)	gesetze-im-internet.de/pflbg
Ausbildung	tam zamanlı **3 yıl**; Pflegeschule (teori+pratik ders) + **praktische Ausbildung** (§ 6)	müfredat/saat: okul/eyalet ⚠
Ausbildungsziel	bağımsız, kapsamlı, süreç odaklı bakım (§ 5)	
Vorbehaltene Tätigkeiten	ihtiyaç saptama/planlama, süreç yönetimi, kalite (§ 4)	
Kompetenzbereiche	PDF'de **yalnız Handlungskompetenz (KMK)**: Fach-, Personale-, Sozialkompetenz + Methoden-, Lern-, kommunikative Kompetenz (I care S. 47–48)	PflAPrV'nin 5 yeterlilik alanı PDF'de **yok** ⚠
Praxisanleitung / Refleksiyon	≥ 300 saat + 24 saat/yıl (I care); vakalarda Praxisanleiterinnen	güncel PflAPrV ⚠
Pflegeprozess	Fiechter/Meier 6 aşama	09
Hijyen/enfeksiyon önleme	Hygieneplan, RKI/KRINKO/IfSG, Hygienefachkraft	03
Datenschutz/Schweigepflicht	PDF'de kavramsal (mahremiyet)	ayrı öğrenin ⚠
Patientenrechte/Selbstbestimmung	Özerklik (Lernskript S. 2)	BGB § 630a vd. PDF'de yok ⚠
Delegation/sorumluluk	Garantenstellung; stajyer yalnız yetki alanında (F 167)	delegation kuralları PDF'de yok ⚠
Arbeitsschutz	BGW: ArbSchG, BioStoffV, TRBA 250, ArbMedVV, DGUV V1, MuSchG, JArbSchG	03 §9
Interprofessionelle Zusammenarbeit	SBAR, doktor/PFK'ye bildirim, fizyoterapi	02b

Sınavda güvenli ifade: „Nach meinem Kenntnisstand … (Quelle: Lernskript/Pflegeberufegesetz). Landes- und Einrichtungsstandards können abweichen."

Bölüm L — Esnek çalışma planı

Bilinmeyenler: sınav tarihi, günlük çalışma süreniz, Almanca seviyeniz, sınav formatı. **Varsaymadım**; plan modülerdir.

Konu önceliği

Öncelik	Konu	Neden
A	Bakım süreci/ABEDL/PflBG · **Operatörler** · Hijyen (HD, 5 an) · İlk yardım BLS	her sınavda, pratik güvenlik
B	Cilt/dekubitus · Isı/ateş · Düşme · Tromboz/Pnömoni	profilaksi vakaları
C	İletişim modelleri · Dokunma/yakınlık–mesafe	vaka analizi
D	Hücre/doku · BGW ayrıntıları · Anatomi ayrıntıları	arka plan

Günlük süre seçenekleri

Süre	Dağılım
30 dk	5 dk kelime (flashcard) · 10 dk aktif hatırlama (kitabı kapat, yaz) · 10 dk soru · 5 dk eski konu
60 dk	10 kelime · 20 konu (Almanca+Türkçe) · 15 soru · 10 tekrar · 5 zayıf liste
90 dk	60 dk + 20 dk yazma (Operatör, dokümantasyon) + 10 dk konuşma (diyaloğu sesli)

Günlük hedef: 1 ana konu + 10–15 kelime + 5–10 soru + 1 tekrar.

Aralıklı tekrar (1–3–7–14)

Gün 0 yeni konu → **Gün 1 → Gün 3 → Gün 7 → Gün 14** tekrar. Her tekrarda: **kitap kapalı özet yaz** → boşlukları işaretle → flashcard → 3 soru. Yanlışlar → Ek 7.

4 haftalık iskelet (sınav tarihi yoksa genel)

Hafta	Odak	Haftalık değerlendirme
1	Bakım temelleri (01) · Operatörler (10) · Hijyen (03)	Klausur 1 + Hijyen quiz
2	Cilt (04) · Isı (05) · Dokümantasyon (10)	Klausur 2
3	Hareket/Düşme (06) · Profilaksiler (07) · Bakım süreci (09)	Klausur 4 + vakalar
4	İlk yardım (08) · İletişim (02) · karma tekrar	Klausur 3 + sözlü simülasyon

Sınavdan önceki son 7 gün: 7–5 zayıf konular · 4–3 zamanlı deneme sınavı · 2 flashcard + Operatörler · 1 hafif tekrar, uyku.

Haftalık kontrol listesi

☐ 5 yeni terim ☐ 1 diyalog sesli ☐ 1 yazılı Operatör görevi ☐ 20 flashcard ☐ zayıf liste güncel ☐ öğretmene 1 çelişki sorusu (00).

Ek 1 — Hemşirelik sözlüğü (Almanca–Türkçe)

Sütunlar: Almanca · Türkçe · Almanca açıklama · örnek cümle · bölüm. **Not:** Açıklama/örnek sütunları bilerek **Almanca** bırakıldı (sınav dili); anlamı Türkçe sütundan okuyun. ⚠ **İlaç/Yara bakımı** kategorilerinde PDF'lerde az içerik var; yalnızca belgede geçen terimler yazıldı. Çoğullar genel bilgidir (⚠ kontrol edin).

1. Anatomi ve fizyoloji

Almanca	Türkçe	Açıklama (DE)	Beispiel	Kap.
das Herz, -en	kalp	muskuläres Hohlorgan, pumpt das Blut	Das Herz pumpt Blut in den Körper.	08
der Vorhof, ¨-e (Atrium)	kulakçık	obere Herzhöhle	Der rechte Vorhof erhält venöses Blut.	08
die Herzkammer, -n (Ventrikel)	karıncık	untere Herzhöhle	Die linke Kammer ist besonders kräftig.	08
die Herzklappe, -n	kalp kapağı	Ventil im Herzen	Herzklappen steuern die Blutrichtung.	08
das Endokard / Myokard / Perikard	endokart / miyokart / perikart	Herzinnenhaut / Muskel / Herzbeutel	Das Myokard leistet die Pumparbeit.	08
der Sinusknoten, ¨	sinüs düğümü	Taktgeber des Herzens	Der Impuls beginnt im Sinusknoten.	08
die Koronararterie, -n	koroner arter	Herzkranzgefäß	Ein Verschluss führt zum Infarkt.	08
die Aorta	aort	Hauptschlagader	Die linke Kammer pumpt Blut in die Aorta.	08
die Arterie, -n / die Vene, -n	atardamar / toplardamar	führt vom / zum Herzen	Arterien führen Blut vom Herzen weg.	08
die Kapillare, -n	kılcal damar	kleinstes Gefäß, Stoffaustausch	In den Kapillaren erfolgt der Austausch.	08
der Körperkreislauf / Lungenkreislauf	büyük / küçük dolaşım			08
der Blutdruck (RR)	kan basıncı	Druck des Blutes in den Gefäßen	Ich messe den Blutdruck.	08
systolisch / diastolisch	sistolik / diyastolik	Auswurf- / Füllungsphase	Der systolische Wert beträgt 120.	08
die Lunge, -n	akciğer	Atmungsorgan	Die rechte Lunge hat drei Lappen.	08
die Luftröhre (Trachea)	soluk borusu			08
die Alveole, -n / das Lungenbläschen	akciğer alveolü	Ort des Gasaustauschs	In den Alveolen wird O_2 aufgenommen.	08
die Ventilation / Diffusion / Perfusion	havalandırma / difüzyon / perfüzyon			08
die Inspiration / Exspiration	soluk alma / verme	Ein- / Ausatmung		08
das Zwerchfell	diyafram	Atemmuskel		08
die Zelle, -n	hücre	kleinste Einheit des Lebens	Die Zelle hat einen Zellkern.	04
der Zellkern	hücre çekirdeği	enthält DNS		04
das Mitochondrium (Pl. -ien)	mitokondri	Kraftwerk der Zelle (ATP)		04
das Gewebe, -	doku	Zellen mit gemeinsamer Funktion	Epithelgewebe bedeckt Organe.	04
das Epithel / das Bindegewebe	epitel / bağ dokusu			04

Almanca	Türkçe	Açıklama (DE)	Beispiel	Kap.
die Haut (¨-e)	cilt	größtes Organ	Die Haut schützt vor Erregern.	04
die Oberhaut (Epidermis)	epidermis	äußerste Hautschicht		04
die Lederhaut (Dermis)	dermis	mittlere Schicht		04
die Unterhaut (Subkutis)	deri altı	Fettgewebe		04
die Schleimhaut, ¨-e	mukoza	feuchte Auskleidung		04
der Hypothalamus	hipotalamus	Temperaturzentrum	Der Hypothalamus regelt die Temperatur.	05
das Gelenk, -e / der Muskel, -n / der Knochen, -	eklem / kas / kemik			06
das Gleichgewicht	denge			06

2. Hastalıklar ve belirtiler

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Thrombose, -n / der Thrombus	tromboz / pıhtı	Blutgerinnsel im Gefäß	Ein Thrombus verschließt die Vene.	07
die Lungenembolie, -n	akciğer embolisi	Gefäßverschluss in der Lunge	Plötzliche Atemnot kann auf eine Embolie hinweisen.	07/08
die Pneumonie, -n	zatürre	Lungenentzündung	Die Pneumonie wurde im Krankenhaus erworben.	07
die Aspiration	aspirasyon	Eindringen in die Atemwege		07
die Dysphagie	yutma güçlüğü	Schluckstörung		07
die Infektion, -en	enfeksiyon	Erreger dringen ein		03
die Entzündung, -en	iltihap	Gewebereaktion (5 Zeichen)		03
die Rötung / Schwellung / Überwärmung / Schmerz / Funktionseinschränkung	kızarıklık/şişlik/sıcaklık artışı/ağrı/fonksiyon kaybı	Rubor, Tumor, Calor, Dolor, Functio laesa		03
das Fieber	ateş	Sollwerterhöhung > 38 °C	Er hat 38,6 °C Fieber.	05
der Schüttelfrost	titreme	unwillkürliches Zittern		05
die Hypothermie / Hyperthermie	hipotermi / hipertermi			05
die Exsikkose	dehidratasyon	Austrocknung	Verminderter Turgor weist auf Exsikkose hin.	04/05
der Dekubitus	bası yarası	Druckgeschwür	Der Dekubitus entsteht am Kreuzbein.	04
die Zyanose	morarma	Blaufärbung (O_2-Mangel)		04
der Ikterus	sarılık	Gelbfärbung		04
die Kontraktur, -en	kontraktür	Gelenksteifigkeit		07
der Schock	şok	Minderdurchblutung der Organe		08
der Herzinfarkt, -e	kalp krizi	Koronararterienverschluss		08
der Schlaganfall / der Apoplex	inme	Durchblutungsstörung/Blutung im Gehirn		08
das Asthma bronchiale	astım	anfallsartige Atemnot		08
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması			08

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
das Kammerflimmern / die Asystolie	ventriküler fibrilasyon / asistoli			08
die Gehirnerschütterung	beyin sarsıntısı			06
die Fraktur, -en	kırık			06
der Schwindel	baş dönmesi			06
die Übelkeit / das Erbrechen	bulantı / kusma			08
die Atemnot (Dyspnoe)	nefes darlığı			07/08
der Husten / der Auswurf	öksürük / balgam			07
die Inkontinenz	idrar/dışkı tutamama			06
die Obstipation	kabızlık			05/06
das Delir	deliryum	akute Verwirrtheit	Fieberdelir	05

3. İlaçlar ve uygulama (belgelerde sınırlı)

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
das Medikament, -e	ilaç		Bestimmte Medikamente verursachen Schwindel.	06
die Nebenwirkung, -en	yan etki	unerwünschte Wirkung		05
die Anordnung, -en	(doktor) talimatı	ärztliche Vorgabe	Nach Anordnung geben wir Medikamente.	02b
das Antipyretikum (Pl. -ka)	ateş düşürücü	fiebersenkendes Mittel		05
das Antibiotikum (Pl. -ka)	antibiyotik			07
die Antikoagulanzien (Pl.)	kan sulandırıcılar	hemmen die Blutgerinnung		07
das Analgetikum / das Schmerzmittel	ağrı kesici			02b
die Inhalation	inhalasyon			07
der Spacer / der Vernebler	spacer / nebülizatör			07
die Dosierung	dozaj	**nur ärztlich**		–
die Verabreichung	uygulama			–

4. Bakım ve hijyen

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Pflege / die Pflegefachperson	bakım / hemşire			01
der Pflegeempfänger	bakım alan			01
die Körperpflege	kişisel bakım			02b
die Intimpflege / die Intimsphäre	mahrem bölge bakımı / mahremiyet			02
die Mundpflege	ağız bakımı			07
die Waschung / der Wickel	yıkama / kompres			05
die Händedesinfektion (HD)	el dezenfeksiyonu			03
das Händewaschen	el yıkama			03
die Einwirkzeit	etki süresi			03
die Standardhygiene	standart hijyen			03
die Schutzkleidung	koruyucu giysi			03
der Handschuh, -e	eldiven			03
die Reinigung / Desinfektion / Sterilisation	temizlik / dezenfeksiyon / sterilizasyon			03
der Keim, -e / der Erreger, -	mikrop / etken			03
nosokomial	hastane kaynaklı			03
die Kolonisation	kolonizasyon			03

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
multiresistent (MRE, MRSA)	çoklu dirençli			03
der Hygieneplan	hijyen planı			03
die Nadelstichverletzung	iğne batması			03
der Kompressionsstrumpf	kompresyon çorabı			07
die Lagerung	pozisyon verme			07
die Mobilisation / die Frühmobilisation	mobilizasyon / erken mob.			06/07
die Prophylaxe, -n	profilaksi			06

5. Yaşamsal bulgular

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Vitalzeichen (Pl.)	yaşamsal bulgular	Puls, RR, Temperatur, Atmung	Ich kontrolliere die Vitalzeichen.	08
der Blutdruck	kan basıncı			08
der Puls / die Herzfrequenz	nabız / kalp hızı		Der Puls ist regelmäßig.	08
die Atemfrequenz	solunum sayısı	Atemzüge pro Minute	Ich kontrolliere die Atemfrequenz.	07
die Körpertemperatur	vücut ısısı			05
die Sauerstoffsättigung (SpO_2)	oksijen satürasyonu			08
die Tachykardie / Bradykardie	taşikardi / bradikardi			08
die Tachypnoe	hızlı solunum			08
die Hypotonie / Hypertonie	hipotansiyon / hipertansiyon			08
der Blutzucker (BZ)	kan şekeri			08
das Bewusstsein	bilinç			08
die Pupillenreaktion	pupil reaksiyonu			08
der Schockindex	şok indeksi	HF/RR sys		08

6. Yara bakımı / cilt (belgelerde sınırlı)

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
die Wunde, -n	yara		08
die Schnitt- / Platzwunde	kesik / yırtık yara	mechanische Wunde	08
die Verbrennung / Erfrierung	yanık / soğuk ısırığı	thermische Wunde	05/08
die Blutung / die Blutstillung	kanama / kanama durdurma		08
der Verbandwechsel	pansuman değişimi		03
die Wundinfektion	yara enfeksiyonu		03
nicht wegdrückbare Rötung	geçmeyen kızarıklık	Dekubitus Kat. I	04
das Panaritium	tırnak yatağı iltihabı		03

7. Beslenme ve sıvı dengesi

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
die Flüssigkeitszufuhr	sıvı alımı		Die Flüssigkeitszufuhr erhöhen.	07
die Trinkmenge / das Trinkprotokoll	içilen miktar / protokolü			07
die Ein- und Ausfuhr / die Bilanzierung	alınan-çıkan / bilanço			07
der Durst / das Durstgefühl	susuzluk			05

Almanca	Türkçe	Açıklama	Beispiel	Kap.
der Turgor	cilt gerginliği			04
die Mangelernährung	yetersiz beslenme			06
die orale / enterale / parenterale Ernährung	oral / enteral / parenteral			07
die Ernährungssonde	beslenme sondası			07
die Inappetenz	iştahsızlık			05
der Urin (konzentriert)	idrar (konsantre)			05

8. Hareket ve mobilizasyon

Almanca	Türkçe	Beispiel	Kap.
die Mobilität / die Immobilität	hareketlilik / hareketsizlik		06
aufstehen / hinsetzen / sich hinlegen	kalkmak / oturmak / yatmak	Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.	06
der Transfer	transfer		06
das Gangbild	yürüyüş		06
der Rollator, der Rollstuhl	rolatör, tekerlekli sandalye		06
die Gehhilfe	yürüme yardımcısı		06
der Sturz / das Sturzrisiko	düşme / düşme riski		06
die Bettkante	yatak kenarı		02b
die Bremse (feststellen)	fren (kilitlemek)		06
rutschfest	kaymaz		06
der Vierfüßlerstand	emekleme pozisyonu		06

9. Acil durumlar

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
der Notruf (112)	acil çağrı		08
die Wiederbelebung / Reanimation (CPR)	resüsitasyon		08
die Herzdruckmassage	kalp masajı	100–120/min, 5–6 cm	08
die Beatmung	suni solunum		08
der Defibrillator / AED	defibrilatör		08
die stabile Seitenlage	koma pozisyonu		08
die Schnappatmung	agonal solunum		08
die Rettungskette	kurtarma zinciri		08
die Eigensicherung	kendini koruma		08
bewusstlos	bilinçsiz		08
der Rettungsdienst, die Leitstelle	kurtarma servisi, kontrol merkezi		08
der Kreislaufstillstand	dolaşım durması		08
das Reanimationsteam	resüsitasyon ekibi		08

10. Gözlem ve dokümantasyon

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
beobachten	gözlemek	aufmerksam wahrnehmen	10
beurteilen	değerlendirmek	Schlüsse ziehen	10
dokumentieren	belgelemek		10
die Pflegedokumentation	bakım dokümantasyonu		10
die Pflegeplanung	bakım planlaması		09
der Befund	bulgu		10
auffällig / unauffällig	dikkat çekici / normal		10

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
angeben / äußern / klagen über	belirtmek / ifade etmek / şikâyet etmek		10
das Sturzprotokoll	düşme protokolü		06
die Übergabe	devir-teslim		02b
SBAR	durum-geçmiş-değerlendirme-öneri		02b
die Evaluation	değerlendirme		01

11. İletişim ve hasta yakınları

Almanca	Türkçe	Kap.
sich vorstellen	kendini tanıtmak	02b
begrüßen / verabschieden	karşılamak / vedalaşmak	02
zuhören / nachfragen	dinlemek / tekrar sormak	02
die Ich-Botschaft	ben-dili	02
verständlich erklären	anlaşılır açıklamak	02b
der Angehörige / die Angehörigen	hasta yakını / yakınlar	02b
die Wertschätzung	değer verme	02
die Empathie / einfühlsam	empati / duyarlı	02
die Angst / die Sorge	korku / endişe	02
das Schweigen	sessizlik	02

12. Etik, mahremiyet, hasta hakları

Almanca	Türkçe	Kap.
die Selbstbestimmung / Autonomie	özerklik	01
die Würde	onur	02
die Intimsphäre	mahremiyet	02
die Schweigepflicht	sır saklama yükümlülüğü	02b
der Datenschutz	veri koruma	02b
die Einwilligung	onay	08
ablehnen	reddetmek	02b
die Patientenverfügung ⚠	hasta talimatı	08
die Wertschätzung / die Respekt	saygı	02

13. Hukuki sorumluluklar

Almanca	Türkçe	Açıklama	Kap.
die unterlassene Hilfeleistung	yardım etmeme	§ 323c StGB	08
die Garantenstellung	garantör konumu	besondere Einstandspflicht	08
der rechtfertigende Notstand	meşru zorunluluk hali	§ 34 StGB	08
die Behandlungspflicht	tedavi yükümlülüğü		08
die vorbehaltenen Aufgaben	saklı görevler	§ 4 PflBG	01
das Pflegeberufegesetz (PflBG)	Hemşirelik Meslekleri Yasası		01
das Infektionsschutzgesetz (IfSG)	Enfeksiyondan Korunma Yasası		03
die Arbeitsschutz / Berufsgenossenschaft	iş güvenliği / meslek sigortası kurumu		03
die Sorgfaltspflicht	özen yükümlülüğü		08
die Haftung	sorumluluk		08

14. Ekip ve doktorla iletişim

Almanca	Türkçe	Kap.
der Arzt / die Ärztin	doktor	02b
die Praxisanleiterin / die Praxisanleitung	uygulama eğitmeni	02b
die zuständige Pflegefachkraft	sorumlu hemşire	02b
die Hygienefachkraft	hijyen uzmanı	03
der Betriebsarzt	işyeri hekimi	03
die Physiotherapie	fizyoterapi	07
der Sozialdienst	sosyal hizmetler	09
das Team / die Zusammenarbeit	ekip / iş birliği	02
informieren / melden / benachrichtigen	bilgilendirmek / bildirmek	02b
die Rücksprache halten	danışmak	02b

15. Karıştırılan kelime çiftleri (Bölüm C)

(Fark sütunu Almanca; kısa Türkçe: Symptom = belirti, Diagnose = tanı (doktor); Infektion = etken girişi, Entzündung = doku tepkisi; Schmerzen haben = hisseder, äußern = bildirir; Prophylaxe = belirli komplikasyonu önleme, Prävention = genel önleme/koruma.)

Çift	Fark	Örnek
Symptom ↔ Diagnose	Symptom = Beschwerde/Zeichen (Fieber, Husten); Diagnose = Name der Krankheit, **ärztlich** (Pneumonie)	„Fieber ist ein Symptom, keine Diagnose.“
Pflegeplanung ↔ Pflegedokumentation	Planung = Ziele/Maßnahmen vorab; Dokumentation = Nachweis von Beobachtung/Durchführung	
Beobachten ↔ Beurteilen	Wahrnehmen ↔ Schlussfolgern	
Infektion ↔ Entzündung	Erreger eindringen ↔ Gewebereaktion (kann ohne Erreger)	
Schmerzen haben ↔ Schmerzen äußern	empfinden ↔ mitteilen/zeigen	
Prophylaxe ↔ Prävention	konkrete Komplikation verhindern ↔ allgemein Gesundheit erhalten/fördern	
Kolonisation ↔ Infektion	ohne ↔ mit Symptomen	
Fieber ↔ Hyperthermie	Sollwert hoch ↔ Regulation überfordert	
Desinfektion ↔ Sterilisation	keimarm ↔ keimfrei	
Thrombose ↔ Embolie	Gerinnsel am Ort ↔ verschleppt	
Ventilation ↔ Perfusion	Belüftung ↔ Durchblutung	
Mobilität ↔ Mobilisation	Fähigkeit ↔ Maßnahme	
Ressource ↔ Problem	Fähigkeit ↔ Beeinträchtigung	
Sturz ↔ Absturz	Boden/tiefere Ebene ↔ aus erhöhter Position	
BLS ↔ ALS	Basis ↔ erweitert	
Lysis ↔ Krisis	langsam ↔ abrupt (Notfall)	
Hautarten Leisten- ↔ Felderhaut	Hände/Füße ↔ Rest	
Mitose ↔ Meiose	2 gleiche ↔ 4 verschiedene	
Arterie ↔ Vene	weg vom ↔ zum Herzen	

Ek 2 — Sınavda kullanılacak Almanca cümle kalıpları (Türkçe açıklamalı)

Kalıbı seçin → boşluğu konuyla doldurun. **Operatör ile kalıbı eşleştirin** (10).

İşlev	Almanca kalıp	Türkçe anlamı	Örnek
Tanımlama (DEFINIEREN)	„X ist …“ / „Unter X versteht man …“ / „X bezeichnet …“	X, … dır / X'ten … anlaşılır	*Unter Prophylaxe versteht man Maßnahmen, die Komplikationen vorbeugen.*
Özellik	„Charakteristisch für X ist …“	X için karakteristik olan …	*Charakteristisch für Fieber ist die Sollwerterhöhung im Hypothalamus.*
Yapı	„X besteht aus …“	X … den oluşur	*Die Haut besteht aus Ober-, Leder- und Unterhaut.*
Betimleme	„Es zeigt sich …“ / „Auffällig ist …“	… görülüyor / dikkat çeken …	*Auffällig ist eine nicht wegdrückbare Rötung am Kreuzbein.*
Neden (ERKLÄREN/BEGRÜNDEN)	„… weil …“ / „da …“	çünkü	*Er hat Angst, weil er bisher allein gelebt hat.*
	„Das liegt daran, dass …“	bunun nedeni …	*… dass die Muskel-Venen-Pumpe bei Immobilität nicht aktiviert wird.*
	„Aus diesem Grund / Deshalb / Daher …“	bu nedenle	*Aus diesem Grund ist Frühmobilisation wichtig.*
	„Dies führt dazu, dass …“	bu … sonucunu doğurur	
	„… sodass …“	öyle ki	*…, sodass er auf Hilfe angewiesen ist.*
Karşılaştırma (VERGLEICHEN)	„Im Gegensatz zu … / Während …, …“	…'in aksine / iken	*Während Fieber auf einer Sollwerterhöhung beruht, ist Hyperthermie ein Versagen der Wärmeabgabe.*
	„Gemeinsam ist beiden, dass …“ / „Der Unterschied besteht darin, dass …“	ortak yön / fark …	
Belirti	„Ein wichtiges Anzeichen dafür ist …“	bunun önemli bir belirtisi …	*… für eine Exsikkose ist eine stehende Hautfalte.*
	„Typische Symptome sind …“ / „… weist auf … hin“ / „… spricht für …“	tipik belirtiler / işaret eder / lehine	*Rötung, Schwellung, Überwärmung sprechen für eine Entzündung.*
Önlem	„Die Pflegemaßnahme dient dazu, … (zu …)“	bakım önleminin amacı …	*Die Frühmobilisation dient dazu, einer Thrombose vorzubeugen.*
	„Um … zu …, wird/werden …“	…mak için … yapılır	*Um Stürze zu vermeiden, werden Stolperfallen entfernt.*
	„Zunächst ist zu beachten, dass …“	önce şuna dikkat edilmeli	
	„Dabei ist darauf zu achten, dass …“	bunu yaparken dikkat …	*… dass die Intimsphäre gewahrt bleibt.*
Değerlendirme	„Anschließend wird überprüft, ob …“	ardından … olup olmadığı kontrol edilir	
	„Falls das Ziel nicht erreicht wird, wird die Planung angepasst.“	hedefe ulaşılmazsa plan uyarlanır	

İşlev	Almanca kalıp	Türkçe anlamı	Örnek
Eskalasyon/güvenlik	„Bei einer Verschlechterung des Zustands muss … informiert werden.“	durum kötüleşirse … haberdar edilmeli	*… die Pflegefachkraft bzw. der Arzt …*
	„Bei … ist sofort der Notruf 112 abzusetzen.“	… durumunda hemen 112 aranır	
	„… nur nach ärztlicher Anordnung / nach Rücksprache mit der PFK“	sadece doktor talimatıyla / PFK ile görüşerek	
AFB III	„Daraus ergibt sich …“ / „Folglich …“	bundan şu çıkar	
	„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass …“	özetle	
	„Meiner Einschätzung nach …, weil …“ / „Ich komme zu dem Schluss, dass …“	kanaatimce … çünkü	
	„Einerseits …, andererseits …“	bir yandan … öte yandan	
	„Aus Sicht des Patienten könnte … bedeuten, dass …“ (DEUTEN)	hastanın bakışıyla … anlamına gelebilir	

Hasta ile iletişim kalıpları

Amaç	Cümle
Tanışma	Guten Tag, ich bin … und für Sie zuständig.
İzin	Darf ich hereinkommen? / Ist es in Ordnung, wenn …?
Açıklama	Ich werde jetzt … Das dauert etwa …
Seçenek	Möchten Sie das lieber selbst machen?
Anlama kontrolü	Haben Sie das verstanden? Möchten Sie noch etwas fragen?
Empati	Das verstehe ich. / Das muss unangenehm sein.
Ağrı	Wo genau haben Sie Schmerzen? Wie stark auf einer Skala von 0 bis 10?
Sınır	Das darf ich nicht entscheiden; ich frage die zuständige Pflegefachkraft.
Hata/Risk	Mir ist aufgefallen, dass … Ich möchte das melden.
Acil	Hilfe! Der Patient reagiert nicht und atmet nicht normal!

SBAR (doktor/ekip): S: *Ich rufe an wegen Herrn …, Zimmer … Seine Temperatur ist auf … gestiegen.* · **B:** *Er ist … Jahre alt, Z. n. …* · **A:** *Ich schätze die Situation so ein, dass …* · **R:** *Ich bitte um … / Soll ich …?*
Geçiş sözcükleri: zunächst (önce) · außerdem (ayrıca) · darüber hinaus (bunun ötesinde) · allerdings (ancak) · dennoch (yine de) · jedoch (fakat) · deshalb (bu yüzden) · folglich (dolayısıyla) · schließlich (sonunda) · abschließend (son olarak) · beispielsweise (örneğin) · insbesondere (özellikle) · gegebenenfalls (ggf.) (gerekirse) · in der Regel (kural olarak) · vor allem (her şeyden önce).

Ek 3 — En önemli konuların kısa tekrar notları (tek sayfa kartları)

> Her konuyu **kitap kapalı** hatırlayabilmelisiniz.

1. Bakım temelleri → 01

- Mesleki bakım = bilgiye dayalı, **planlı**, sorumluluk, ilişki · Selbstpflege/informelle Hilfe/professionelle Pflege.
- **Bedürfnis · Problem · Ressource · Autonomie.**
- Yeterlilikler: Fach, Methoden (+iletişim, öğrenme), Sozial, Selbst/Personal.
- **13 ABEDL:** İletişim, Hareket, Yaşamsal fonksiyonlar, Kişisel bakım, Yeme-içme, Boşaltım, Giyinme, Dinlenme/uyku, Uğraş/öğrenme, Cinsellik, Güvenli ortam, Sosyal alanlar, Varoluşsal deneyimler.
- **Bakım süreci 6:** Bilgi – Sorun/Kaynak – Hedef – Önlem planı – Uygulama – Değerlendirme (**döngü**).
- **PflBG:** § 1 unvan · § 4 saklı görevler (ihtiyaç/planlama; süreç yönetimi; kalite) · § 5 hedef · § 6 3 yıl.

2. İletişim → 02

- Laswell: mesaj–gönderen–alıcı. **Schulz von Thun:** Sach, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell (4 kulak). **Watzlawick 5 aksiyom.** sözlü/sözsüz/paraverbal; kongruent/inkongruent.
- Geri bildirim: saygı, davranış (kişi değil), **Ich-Botschaft**, somut, istek.
- Selamlama = güven; çocuklaştırıcı dilden kaçın; **Initialberührung**; Hall bölgeleri; yakınlık–mesafe; ilişki: kabul, içtenlik, empati, yargısız kabul.

3. Hijyen → 03

- Eller = ana bulaş yolu · yıka–dezenfekte et–bakım · **WHO 5 an** · **≥ 30 sn**, eller kuru, takı yok · eldiven HD'nin yerini tutmaz · C. diff: ayrıca yıka.
- endogen/exogen · direkt/indirekt · nosokomial · Kolonisation/Infektion · MRSA/VRE/ESBL/MRGN.
- Temizlik (≤ %80) · Dezenfeksiyon (mikrop azaltma) · Sterilizasyon (steril).
- NSV: kan akışı/yıka/dezenfekte → doktor → PEP ≤ 2 sa → bildirim → dokümante. Risk HBV %30, HCV %3, HIV %0,3.

4. Cilt → 04

- 3 katman · işlevler · asit tabaka pH 5,5 · **Turgor** · Zyanose (dudak/tırnak; koyu ciltte gri + mukozalar) · Recap < 2–3 sn · **5 iltihap bulgusu** · Dekubitus (**Fingertest**) · ABCDE.
- Mitoz 2 aynı / Mayoz 4 farklı · 4 temel doku · Epitel damarsız.

5. Isı → 05

- Çekirdek 37 °C; hipotalamus hedef değer · rektal en doğru; axillar yalnız kabuk · aynı yer.
- Ateş = hedef > 38,0; belirti. **3 evre:** artış (ısıt) / zirve / düşüş (Lysis/**Krisis**). Wadenwickel: ılık, ≤ 10 °C farklı, 5–10 dk, kontrendike soğuk ekstremite. **Artışta asla soğutma.**
- Hipotermi < 35 °C (3 evre) · Hipertermi ≠ ateş · Hitzschlag acil.

6. Hareket & Düşme → 06

- Mobilität/eingeschränkt/Immobilität · yaşlılıkta değişiklik "normal" değil · sonuç: düşme, tromboz, dekubitus, kontraktür, kabızlık, izolasyon.
- Düşme nedenleri: denge, kas zayıflığı, görme, baş dönmesi, korku, ayakkabı, ilaç, inkontinans.
- Düşme sonrası: sakinleştir–yardım–yaralar–(kırık?)–vital–**protokol**–bildir; 24 sa kafa içi basınç gözlemi.

7. Profilaksiler → 07

- **Virchow:** dolaşım, duvar, kan. Temel: erken mobilizasyon, egzersiz, içme. **Bacağı sıvazlama yok.** MTPS yatanda etkili; uyum; kontrendike pAVK, nöropati, ödem, defekt.
- **LISA** (Lunge, Infektion, Sekret, Aspiration) · typisch/atypisch pnömoni · CRB-65 · aspirasyon pnömonisi enfeksiyöz değil.

8. İlk yardım → 08

- Kendini koru → tepki → hava yolu → solunum ≤ 10 sn (SHF) → yardım/112 → **30:2, 100–120/dk, 5–6 cm** → AED → RD gelene kadar.
- Bilinçsiz + normal solunum = yan yatış. Acil çağrı W-soruları. §323c, Garantenstellung, §34.
- Şok 4 biçim; Schockindex HF/RR (≥ 1). Enfarktüs, inme, akciğer embolisi, astım, kanama. ABCDE. SBAR.

9. Operatörler & dokümantasyon → 10

- AFB I: nennen, beschreiben, zuordnen, zusammenfassen, definieren · II: ermitteln, erklären (weil), vergleichen, anwenden · III: begründen, diskutieren, Stellung beziehen, entwickeln, deuten.
- Doku: gözlem ≠ yorum; zaman/bulgu/önlem; hasta sözü alıntı; yalnız yapılanı yaz.

Ek 4 — Flashcard seti (119 kart, Türkçe)

Anki/Quizlet: `Ek4_Flashcards_TR.csv` (UTF-8; sütunlar: Konu;Soru;Cevap;Almanca terim;Bölüm).

Kullanım: Soruyu okuyun, **sesli** cevaplayın, **Almanca terimi** de söyleyin. Yanlışlar → Ek 7. Aralıklı tekrar: 1–3–7–14 gün.

Bakım

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Mesleki bakım gündelik yardımdan nasıl ayrılır?	Bilgiye dayalı, sistematik/planlı, sorumluluk ve ilişki kurma (fachlich begründet, geplant, Verantwortung).	**professionelle Pflege**	01
2	Ressource nedir?	Kişinin sahip olduğu ve kullanabildiği yetenek, güç, olanak veya destek.	**die Ressource**	01
3	Bedürfnis nedir?	Kişinin bedensel, ruhsal, sosyal iyi oluşu için gereken şey.	**das Bedürfnis**	01
4	Autonomie / Selbstbestimmung nedir?	Kişinin nasıl yaşayacağına özgürce ve sorumlulukla kendisinin karar vermesi.	**die Selbstbestimmung**	01
5	Lernskript'e göre 4 yeterlilik alanı?	Fach-, Methoden-, Sozial-, Selbstkompetenz.	**4 Kompetenzbereiche**	01
6	Bakım sürecinin 6 aşaması?	Bilgi toplama – Sorun/Kaynak – Hedef – Önlem planı – Uygulama – Değerlendirme.	**Pflegeprozess**	01
7	Değerlendirme neden önemli?	Etkiyi kontrol edip planı uyarlamak için; süreç bir döngüdür.	**Evaluation**	01
8	§ 4 PflBG'nin 3 saklı görevi?	İhtiyaç saptama + planlama; süreci organize/yönetme; kalite analizi-güvence.	**vorbehaltene Aufgaben**	01
9	Eğitim süresi (§ 6)?	Tam zamanlı 3 yıl (Pflegeschule + uygulamalı eğitim).	**3 Jahre**	01
10	ABEDL 1–4?	İletişim; hareket; yaşamsal fonksiyonlar; kişisel bakım.	**ABEDL 1–4**	01
11	ABEDL 5–8?	Yeme-içme; boşaltım; giyinme; dinlenme/uyku.	**ABEDL 5–8**	01
12	ABEDL 9–13?	Uğraş/öğrenme; cinsellik; güvenli ortam; sosyal alanlar; varoluşsal deneyimler.	**ABEDL 9–13**	01
13	13 ABEDL'i kim geliştirdi?	Monika Krohwinkel.	**Krohwinkel**	01

İletişim

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Mesajın 4 yönü?	Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungshinweis, Appell.	**Vier-Seiten-Modell**	02
2	4 kulak?	Sachverhalts-, Selbstoffenbarungs-, Beziehungs-, Appellohr.	**vier Ohren**	02
3	Watzlawick 1. aksiyom?	İletişimsiz olunamaz (sessizlik de mesajdır).	**Man kann nicht nicht kommunizieren**	02
4	Dijital ↔ analog iletişim?	Dijital = bilgi içeriği; analog = jest, mimik, ton (ilişki).	**digital/analog**	02
5	Simetrik ↔ tamamlayıcı?	Eşit (göz hizası) ↔ hiyerarşik.	**symmetrisch/komplementär**	02
6	Kongruent mesaj?	Sözlü ve sözsüz mesaj aynı şeyi ifade eder.	**kongruent**	02
7	3 geri bildirim kuralı?	Saygı; kişi değil davranış; ben-dili; somut durum; istek.	**Feedbackregeln**	02

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
8	Çocuklaştırıcı dil nedir?	Yetişkine bebek/aşağılayıcı dille hitap (örn. "Popo").	**infantilisierende Sprache**	02
9	Initialberührung nedir?	Bakım eyleminin dokunuşla bilinçli başlangıcı (omuza el) – yönelim/güven.	**Initialberührung**	02
10	Profesyonel ilişkinin unsurları?	Kabul, içtenlik (Echtheit), empati, yargısız kabul.	**Akzeptanz, Empathie**	02
11	Resmî ↔ gayriresmî iletişim?	Resmî: planlı, kurallı; gayriresmî: rahat.	**formell/informell**	02

Hijyen

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Bulaşın ana yolu?	Eller.	**Hände**	03
2	El hijyeninin 3 adımı?	Yıka – dezenfekte et – bakım yap.	**Händehygiene**	03
3	WHO'nun 5 anı?	Hasta temasından önce; aseptik işlem öncesi; enfekte materyal sonrası; hasta teması sonrası; hasta çevresi sonrası.	**5 Momente**	03
4	El dezenfeksiyonu en az kaç sn?	En az 30 sn (üretici bilgisi).	**Einwirkzeit**	03
5	Sık ıslanmayan bölgeler?	Başparmak, parmak uçları, parmak araları.	**Benetzungslücken**	03
6	Eldivenden sonra neden HD?	Mikro delikler + çıkarırken bulaş; eldiven HD'nin yerini tutmaz.	**Handschuhe**	03
7	Ne zaman yıkama?	Gözle görülür kir, tuvalet, hapşırma/öksürme; C. difficile'de ek olarak.	**Händewaschen**	03
8	Temizlik/Dezenfeksiyon/Sterilizasyon farkı?	Kir + ≤ %80 mikrop / çoğu etken (mikrop azaltma) / hepsi (steril).	**Reinigung/Desinfektion/Sterilisation**	03
9	Nosokomial enfeksiyon?	Hastane/bakım evinde kazanılan enfeksiyon.	**nosokomial**	03
10	Endojen ↔ eksojen?	Vücut içi etken ↔ dışarıdan etken.	**endogen/exogen**	03
11	Kolonizasyon ↔ enfeksiyon?	Belirtisiz yerleşme ↔ girme, çoğalma, savunma reaksiyonu.	**Kolonisation**	03
12	MRSA nedir?	Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (çoklu dirençli etken).	**MRSA**	03
13	NSV sonrası bulaş riski HBV/HCV/HIV?	≈ %30 / %3 / %0,3.	**NSV**	03
14	NSV sonrası acil önlemler?	Kan akışı/yıka-dezenfekte → doktor; HIV-PEP ≤ 2 sa; bildirim; dokümantasyon.	**Nadelstichverletzung**	03
15	Takı neden çıkarılır?	Ancak takısız etkili temizlik/dezenfeksiyon mümkün.	**Schmuck**	03
16	Hygieneplan nedir?	Madde, etki süresi, kim/ne zaman bilgisi içeren kurum planı.	**Hygieneplan**	03

Cilt

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	3 cilt katmanı?	Epidermis, Dermis (Lederhaut), Subkutis.	**Haut**	04
2	Epidermisin işlevi?	Bariyer, su/UV koruması, asit tabaka.	**Oberhaut**	04
3	Asit koruyucu tabaka pH?	5,5.	**Säureschutzmantel**	04
4	Turgor nedir?	Cildin gerginlik durumu (sıvı içeriği).	**Turgor**	04
5	Azalmış turgor ne gösterir?	Ayakta kalan deri kıvrımı → sıvı eksikliği (Exsikkose).	**Exsikkose**	04
6	Siyanoz önce nerede?	Dudak ve tırnaklarda.	**Zyanose**	04
7	Koyu ciltte siyanoz?	Gri/kestane tonu; dil, diş eti, ağız mukozası, konjonktiva, tırnak yatağı bakılır.	**Zyanose**	04
8	Recap normal değer?	Renk 2–3 sn'den kısa sürede döner.	**Rekapillarisierungszeit**	04
9	5 iltihap bulgusu (Latince)?	Rubor, Tumor, Calor, Dolor, Functio laesa.	**Entzündungszeichen**	04
10	Fingertest negatif/pozitif?	Negatif: kızarıklık solar; pozitif: kalır (Dekubitus Kat. I).	**Fingertest**	04
11	Sık dekubitus yerleri?	Sakrum (Kreuzbein), topuk, kalça.	**Dekubitus**	04
12	ABCDE kuralı?	Asimetri, sınır belirsiz, renk, çap > 5 mm, değişim.	**ABCDE-Regel**	04
13	Mitoz ↔ mayoz?	Mitoz 2 aynı vücut hücresi; mayoz 4 farklı üreme hücresi.	**Mitose/Meiose**	04
14	Epitelde damar var mı?	Hayır, difüzyonla beslenir.	**Epithel**	04
15	D vitamini nerede yapılır?	Ciltte.	**Vitamin D**	04

Isı

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Normal çekirdek ısı?	≈ 37 °C (36–37,5).	**Kerntemperatur**	05
2	Isıyı kim düzenler?	Hipotalamus.	**Hypothalamus**	05
3	En doğru ölçüm yeri?	Rektal.	**rektal**	05
4	Axillar neyi ölçer?	Yalnız kabuk ısısını.	**axillar**	05
5	Ateş sınırı?	> 38,0 °C (hedef değer yükselmesi).	**Fieber**	05
6	Ateş ↔ hipertermi?	Ateş: yeni hedef değer; hipertermi: düzenleme yetersiz.	**Fieber/Hyperthermie**	05
7	Ateşin 3 evresi?	Artış – zirve – düşüş.	**Fieberstadien**	05
8	Artışta cilt ve bakım?	Soluk, soğuk, titreme → ısıt, soğutma yok.	**Fieberanstieg**	05
9	Lysis ↔ Krisis?	Yavaş ↔ ani düşüş; Krisis = dolaşım tehlikesi/acil.	**Lysis/Krisis**	05
10	Wadenwickel suyu?	Ilık, vücut ısısından en fazla 10 °C düşük.	**Wadenwickel**	05
11	Wadenwickel değişim ve kontrendikasyon?	5–10 dk'da değiştir; soğuk el/ayak, dolaşım bozukluğu.	**Kontraindikation**	05
12	Hipotermi tanımı?	Çekirdek ısı < 35 °C.	**Hypothermie**	05
13	Ateşte nabız artışı?	≈ +8–10 (–12)/dk her 1 °C'de.	**Puls**	05
14	Durstfieber nedir?	Bebekte sıvı eksikliğine bağlı; gerçek ateş değil.	**Durstfieber**	05
15	Neden aynı yerden ölçülür?	Değerlerin karşılaştırılabilirliği için.	**gleiche Messstelle**	05
16	Isı dokümantasyonu?	Saat, yer, sonuç, eşlik eden tedavi.	**Dokumentation**	05

Hareket

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Mobilite tanımı?	Bağımsız hareket ve pozisyon/yer değiştirme yeteneği.	**Mobilität**	06
2	Immobilität?	Bağımsız hareketin ileri derecede kısıtlı/yok olması.	**Immobilität**	06
3	Hareketsizliğin bedensel sonuçları?	Kas kaybı, düşme/tromboz/dekubitus/kontraktür riski, kabızlık.	**Folgen**	06
4	Prophylaxe ↔ Prävention?	Belirli komplikasyonu önleme ↔ önleme + sağlığı koruma/geliştirme.	**Prophylaxe/Prävention**	06

Düşme

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Sturz tanımı?	İstemeden yere/daha alçak seviyeye gelme.	**Sturz**	06
2	Absturz?	Yüksek konumdan düşme.	**Absturz**	06
3	5 düşme nedeni?	Denge, kas zayıflığı, görme, baş dönmesi, korku, ayakkabı, ilaç, inkontinans.	**Sturzursachen**	06
4	Hızlı tarama 3 soru?	Son yılda düştü mü? Güvensiz mi? Düşme korkusu?	**Screening**	06
5	Düşme sonrası ilk adım?	Sakinleştir, 2. kişiyi çağır, yaralanmalara bak.	**Notfall-Sturz**	06
6	24 saat kafa içi basınç belirtisi?	Pupil ışık tepkisizliği, Druckpuls (RR yüksek, nabız düşük).	**Hirndruckzeichen**	06
7	Sturzprotokoll içeriği?	Kişi, tarih/yer, ortam, durum, önceki etkinlik, önlemler, sonuçlar.	**Sturzprotokoll**	06

Tromboz

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Virchow üçlüsü?	Yavaş kan akışı, damar duvarı hasarı, artmış pıhtılaşma.	**Virchow-Trias**	07
2	Expositionell ↔ dispositionell?	Akut/geçici ↔ doğuştan-edinsel temel risk.	**Risikofaktoren**	07
3	Temel önlemler?	Erken mobilizasyon, egzersiz (aktif/pasif), yeterli sıvı.	**Basismaßnahmen**	07
4	Bacağı yukarı koymak/sıvazlamak?	Yukarı koymak profilaksi değil; sıvazlama yapılmaz (pıhtıyı koparabilir).	**nicht ausstreichen**	07
5	MTPS ne zaman etkili?	Yalnızca yatan hastada.	**MTPS**	07
6	MTPS kontrendikasyonları?	pAVK, ağır nöropati, belirgin ödem, lokal defekt/nekroz.	**Kontraindikationen**	07
7	Kopan pıhtı ne yapar?	Akciğer embolisi.	**Lungenembolie**	07

Pnömoni

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	LISA?	Akciğer havalandırma, enfeksiyon önleme, sekret mobilizasyonu, aspirasyon önleme.	**LISA**	07
2	Typische pnömoni?	Ani başlangıç, yüksek ateş/titreme, verimli öksürük, belirgin nefes darlığı.	**typisch**	07
3	Atypische pnömoni?	Sinsi, hafif ateş, kuru öksürük, grip belirtileri.	**atypisch**	07
4	CRB-65?	Konfüzyon, solunum ≥ 30, düşük tansiyon, yaş ≥ 65; ≥ 1 puan → yatış.	**CRB-65**	07
5	Aspirasyon pnömonisi enfeksiyöz mü?	Hayır (özel biçim); belirtiler 2–12 sa gecikmeli.	**Aspirationspneumonie**	07
6	Solunumu rahatlatan önlemler?	Lippenbremse, Kutschersitz, gövde yükseltme, VATI.	**atemerleichternd**	07

İlk yardım

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	Solunum kontrolü süre/yöntem?	En fazla 10 sn; bak–dinle–hisset.	**Sehen-Hören-Fühlen**	08
2	Tepki yok + normal solunum yok?	Dolaşım durması şüphesi → acil çağrı + CPR.	**Kreislaufstillstand**	08
3	Schnappatmung?	Normal solunum değil; dolaşım durmasında görülebilir.	**Schnappatmung**	08
4	Erişkin kalp masajı rakamları?	30:2, 100–120/dk, 5–6 cm, tam bırakma, 2 dk'da değişim.	**Herzdruckmassage**	08
5	Basınç noktası?	Göğüs ortası / alt sternum üçte biri.	**Druckpunkt**	08
6	Acil çağrıda W-soruları?	Wo? Wer? Was? Wie viele? Soruları bekle.	**Notruf**	08
7	AED adımları?	Aç, elektrot, talimat, dokunma yok, şok, hemen CPR.	**AED**	08
8	Yan yatış ne zaman?	Bilinçsiz ama normal soluyor.	**stabile Seitenlage**	08
9	§ 323c StGB?	Yardım etmeme: gerekli ve makul ise yardım zorunlu.	**unterlassene Hilfeleistung**	08
10	Garantenstellung?	Emanet edilen hastaya karşı özel yükümlülük.	**Garantenstellung**	08
11	§ 34 StGB?	Meşru zorunluluk: en hafif araç, korunan menfaat ağır basar.	**rechtfertigender Notstand**	08
12	4 şok biçimi?	Hipovolemik, kardiyojenik, obstrüktif, distributif.	**Schockformen**	08
13	Schockindex?	Kalp hızı ÷ sistolik RR; ≥ 1 şok olası; 0,5–0,7 normal.	**Schockindex**	08
14	Kalp krizi belirtileri?	Göğüs ağrısı/daralma + yayılma, nefes darlığı, soğuk ter, bulantı; kadında atipik.	**Herzinfarkt**	08
15	İnme belirtileri?	Tek taraflı yüz/kol felci, konuşma bozukluğu, görme sorunu, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı.	**Schlaganfall**	08
16	Akciğer embolisi belirtileri?	Ani nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, senkop; ± tek taraflı bacak şişliği.	**Lungenembolie**	08
17	ABCDE?	Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Environment.	**ABCDE**	08
18	Ventilasyon/Diffüzyon/Perfüzyon?	Havalandırma / gaz alışverişi / kanlanma.	**Gasaustausch**	08
19	SBAR?	Durum, Geçmiş, Değerlendirme, Öneri.	**SBAR**	08

Operatör

#	Soru	Cevap	Almanca terim	Böl.
1	ERKLÄREN ne ister?	Nedenleri/koşulları/sonuçları anlaşılır kılmak ("weil").	**erklären**	10
2	BESCHREIBEN ne ister?	Yapılandırılmış, tam cümle, meslek dili, değerlendirmesiz.	**beschreiben**	10
3	BEGRÜNDEN ne ister?	Neden öyle olduğunu mesleki argümanla göstermek.	**begründen**	10
4	AFB I/II/III?	Aktarma / yeniden düzenleme-uygulama / değerlendirme-çözüm üretme.	**Anforderungsbereiche**	10
5	Beobachten ↔ Beurteilen?	Yargısız algılama ↔ bilgiyle sonuç çıkarma.	**beobachten/beurteilen**	10

Ek 5 — Deneme sınavları (soru kitapçığı — cevapsız, Türkçe)

> Cevaplar: Ek5b_Cevaplar.md — **önce kendiniz çözün!** Gerçek sınavda cevaplar **Almanca** yazılacağı için cevaplarınızı Almanca yazmayı deneyin; anahtardaki "Almanca kalıp"larla karşılaştırın. **Türler:** MC çoktan seçmeli · RF doğru/yanlış · LT boşluk doldurma · ZO eşleştirme · KA kısa cevap · BG terim açıklama · FA vaka analizi · PP bakım planı · SD yazılı ifade/dokümantasyon · MD sözlü simülasyon. Her soruda **AFB** ve kaynak bölüm var. Süre ≈ 45–60 dk/Klausur. Operatör formatında vakalar için → Ek 5c.

Klausur 1 — Bakım temelleri, bakım süreci, operatörler, dokümantasyon *(01, 09, 10)*

1. (MC, AFB I) Frau Berger (78, düşme sonrası) hakkında hangi bilgi bir **Ressource**'tur? A) Sağ kalçada ağrı B) Gözlüğü evde C) Kızı düzenli ziyaret ediyor D) Yalnız yaşıyor **2. (MC, AFB I) ERKLÄREN** operatörü ne ister? A) kavramları anahtar kelimeyle saymak B) nedenleri/koşulları anlaşılır kılmak ("weil") C) benzerlik-farkları belirtmek D) gerekçeli yargı vermek **3. (RF, AFB I)** "Planlanmış bir bakım önleminin uygulanması otomatik olarak § 4 PflBG saklı görevidir." Doğru/yanlış? Tek cümle gerekçe. **4. (RF, AFB I)** "ABEDL kişisel görüşmenin yerini tutar." Doğru/yanlış? **5. (LT, AFB I)** Bakım süreci ___ aşamadan oluşur. İlk aşama ___, son aşama ___. Bakımın uyarlanması gerektiğinden süreç bir ___ olarak anlaşılır. **6. (ZO, AFB I)** Eşleştir: 1 gözlük yok · 2 kalkarken ağrı · 3 kızı yakında · 4 "Kendim yıkamak istiyorum" → a) ABEDL 12 b) ABEDL 11/1 c) ABEDL 2 d) özerklik **7. (KA, AFB I)** 13 ABEDL'den dördünü **nennen**. **8. (BG, AFB I)** "Ressource"u **definieren** ve örnek ver. **9. (KA, AFB II)** Bakımın "kişi adına mümkün olduğunca çok şey yapmak" olmadığını **erklären**. **10. (KA, AFB I)** § 4 PflBG'nin üç saklı görevini **nennen**. **11. (FA, AFB II)** *"Hemşireler yalnızca doktor talimatını uygular."* Doğru mu? **Begründen**. **12. (SD, AFB II)** Nesnel yeniden yaz: a) "Pat. ist heute schlecht drauf." b) "Pat. hat Fieber." c) "Pat. wurde mobilisiert." (mobilizasyon baş dönmesi nedeniyle yarıda kesildi). **13. (PP, AFB II)** Frau Berger (81; yavaş yürüyor, kalkarken birkaç deneme, koltukta kalıyor) için **6 satırlık bakım süreci** yaz. **14. (FA, AFB III)** "Zaman baskısında bakımı tamamen devralmak daha iyidir" — **Stellung beziehen** (özerklik ve ressource ile). **15. (MD, AFB II)** *Sözlü (3 dk):* Frau Berger'e kendini tanıt, mobilizasyonda isteklerini sor ve ne yapacağını açıkla.

Klausur 2 — İletişim, dokunma, yakınlık–mesafe *(02, 02b)*

1. (MC, AFB I) Laswell'e göre iletişimde her zaman kaç öğe vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 **2. (MC, AFB I)** Hangisi **Appell**'dir? A) "Saat 12." B) "Korkuyorum." C) "Lütfen bana dikkatli olun." D) "Daha gençsiniz." **3. (RF, AFB I)** "Susan kişi iletişim kurmaz." Doğru/yanlış? **4. (LT, AFB I)** Dijital iletişim ___ bilgiyi, analog (jest, mimik, ton) ___ düzeyini taşır. **5. (ZO, AFB I)** 1 symmetrisch · 2 komplementär · 3 kongruent · 4 inkongruent → a) hiyerarşik b) sözlü = sözsüz c) eşit d) sözlü ≠ sözsüz **6. (KA, AFB I)** Üç geri bildirim kuralını **nennen**. **7. (BG, AFB I)** "infantilisierende Sprache"yi **definieren**; örnek + daha iyi ifade. **8. (KA, AFB II)** "Wie alt sind Sie überhaupt?" cümlesinin 4 kulakla nasıl anlaşılabileceğini **erklären**. **9. (FA, AFB II)** *Fall Simon/Renate:* hemşire tek söz etmeden tansiyon ve şeker ölçüyor. Durumu **beschreiben**, **beurteilen**, **Konsequenz** çıkar. **10. (KA, AFB II)** Selamlamanın bakım ilişkisi için önemini **erklären**. **11. (KA, AFB I)** Dört sözsüz iletişim biçimini **nennen**. **12. (KA, AFB II)** Initialberührung ve achtsame Körperpflege'yi **erklären**. **13. (FA, AFB III)** Yakınlık–mesafe dengesini **diskutieren** (her yan için ≥ 2 argüman). **14. (SD, AFB II)** İlacı haber vermeden vermiş bir meslektaşa **Ich-Botschaft** yaz. **15. (MD, AFB II)** *Sözlü:* Gitmeniz gerekirken uzun konuşan hastayla görüşmeyi nazikçe bitir.

Klausur 3 — İlk yardım / BLS / acil durumlar *(08)* ⚠ rakamları güncel standardınızla kontrol edin

1. (MC, AFB I) Hasta tepki vermiyor ve normal solumuyor. Önlem/ansprache sonrası **ilk** ne yaparsın? A) 2 dk nabız aramak B) yardım/acil çağrı ve kalp masajına başlamak C) yan yatış D) O_2 ölçmek **2. (MC, AFB I)** Solunum kontrolü en fazla ne kadar sürer? A) 3 sn B) 10 sn C) 30 sn D) 1 dk **3. (MC, AFB I)** Erişkinde kalp masajı rakamları (Zusammenfassung)? A) 15:2, 60/dk B) 30:2, 100–120/dk, 5–6 cm C) 30:2, 60/dk, 2 cm D) 5:1, 80/dk **4. (RF, AFB I)** "AED kalp masajının yerini tutar." **5. (RF, AFB I)** "Bilinçsiz ve normal soluyan kişide stabil yan yatış uygulanır." **6. (LT, AFB I)** Acil çağrı W-soruları: ___ olay? ___ arıyor? ___ oldu? ___ kişi? Sonra Leitstelle'nin ___ beklenir. **7. (ZO, AFB I)** 1 hypovolämisch · 2 kardiogen · 3 obstruktiv · 4 distributiv → a) akciğer embolisi b) kan kaybı c) sepsis/anafilaksi d) kalp krizi **8. (BG, AFB I)** Ventilation, Diffusion, Perfusion'u **erklären**. **9. (KA, AFB I)** AED kullanım adımlarını **nennen**. **10. (KA, AFB II)** Kompresyonların neden kesintisiz olması ve neden 2 dk'da bir yardımcı değişimi gerektiğini **erklären**. **11. (KA, AFB II)** § 323c StGB, Garantenstellung ve rechtfertigender Notstand (§ 34)'i 1–2 cümleyle **beschreiben**. **12. (KA, AFB II)** Belirtilerden ön tanıyı **ermitteln**: a) tek taraflı sarkık ağız kenarı, konuşma bozukluğu b) ani nefes darlığı + tek taraflı bacak şişliği c) göğüs ağrısı, soğuk ter, kola yayılma. **13. (SD, AFB II)** Schockindex'i **hesapla**: nabız 120/dk, RR 80/50 mmHg. Sonucu **beurteilen**. **14. (FA, AFB II)** Odaya giriyorsun: hasta yatağın yanında yerde, tepkisiz. (A) normal solunum, (B) normal solunum yok için yaklaşımını **beschreiben**. **15. (FA, AFB III)** Stajyerin acilde neden kendi yetki alanında ve sorumlu PFK ile hareket etmesi gerektiğini **begründen**. **16. (MD, AFB II)** Gelen resüsitasyon ekibine yapılandırılmış **SBAR devri** yap (vaka serbest).

Klausur 4 — Hareket, düşme, tromboz/pnömoni, bakım süreci *(06, 07, 09)*

1. (MC, AFB I) Virchow üçlüsü: A) ağrı, kızarıklık, sıcaklık B) yavaş kan akışı, damar duvarı hasarı, artmış pıhtılaşma C) hava, su, toprak D) ventilasyon, difüzyon, perfüzyon **2. (MC, AFB I)** Hangisi tromboz profilaksisine **ait değildir**? A) erken mobilizasyon B) içme C) bacakları güçlü sıvazlama D) hareket egzersizleri **3. (MC, AFB I)** MTPS: A) yürüyenlerde en iyi B) yalnız yatan hastada C) hiç D) yalnız geceleri **4. (RF, AFB I)** "Aspirasyon pnömonisi primer olarak enfeksiyözdür." **5. (RF, AFB I)** "Yaşlılıkta hareket değişikliği hep normaldir, araştırılmaz." **6. (LT, AFB I)** LISA: **L___ I___ S___ A___**. **7. (ZO, AFB I)** 1 Mobilität · 2 eingeschränkte Mobilität · 3 Immobilität → a) ileri derece kısıtlı/yok b) bağımsız mümkün c) mümkün ama azalmış **8. (KA, AFB I)** Beş düşme nedenini **nennen**. **9. (KA, AFB I)** Frau Berger'in hareketliliği için beş gözlem ölçütünü **nennen**. **10. (KA, AFB II)** İmmobilitenin tromboz, pnömoni ve dekubitusa nasıl yol açtığını **erklären**. **11. (KA, AFB I)** MTPS/kompresyon sargısı için dört kontrendikasyonu **nennen**. **12. (BG, AFB II)** Typische ve atypische pnömoniyi (3 ölçüt) **vergleichen**. **13. (FA, AFB II)** *Odada düşme:* düşme sonrası yaklaşımı ve Sturzprotokoll içeriğini **beschreiben**. **14. (PP, AFB II)** Herr Schneider (düşme sonrası ağrı, az içmiş, yıkamayı reddediyor) için 6 aşamalı kısa **bakım planı**. **15. (FA, AFB III)** Profilaksiyle ilgili bilgilendirme/danışmanlığın neden dokümante edilmesi gerektiğini **begründen**. **16. (SD, AFB II)** Bir düşme için 3–4 cümlelik nesnel **dokümantasyon** yaz (kurgusal veri).

Klausur 5 — Hijyen, cilt, vücut ısısı *(03, 04, 05)*

1. (MC, AFB I) Etkenlerin ana bulaş yolu: A) hava B) eller C) su D) böcekler **2. (MC, AFB I)** Hijyenik el dezenfeksiyonunda asgari etki süresi (BGW): A) 5 sn B) 15 sn C) 30 sn D) 3 dk **3. (MC, AFB I)** Hangi cilt katmanında damar **yoktur**? A) Epidermis B) Dermis C) Subkutis D) hiçbiri **4. (MC, AFB II) Ateş artışında** titreyen, üşüyen hasta: A) soğuk wickel B) ört/ısıt C) pencere aç D) soğuk duş **5. (RF, AFB I)** "Eldiven el dezenfeksiyonunun yerini tutar." **6. (RF, AFB I)** "Axillar ısı çekirdek ısıya eşittir." **7. (LT, AFB I)** 5 iltihap bulgusu: Rubor, ___, Calor, ___, Functio laesa. **8. (ZO, AFB I)** 1 Reinigung · 2 Desinfektion · 3 Sterilisation → a) tüm mikroplar yok edilir b) etkenlerin çoğu öldürülür c) kir ve ≤ %80 mikrop **9. (KA, AFB I)** El dezenfeksiyonunun 5 anını **nennen**. **10. (KA, AFB II)** C. difficile'de neden ayrıca yıkandığını **erklären**. **11. (KA, AFB I)** Normal/azalmış turgor ve Recap süresi değerlerini **nennen**. **12. (KA, AFB II)** Koyu ciltte zyanozun neden gözden kaçabileceğini ve ek olarak nereye bakılacağını **erklären**. **13. (BG, AFB II)** Ateş ile hipertermiyi **vergleichen**. **14. (KA, AFB II)** Wadenwickel uygulamasını ve kontrendikasyonları **beschreiben**. **15. (FA, AFB II)** *Herr Schneider:* 38,6 °C axillar, sıcak cilt, terliyor, az içmiş. Üç bakım sorunu **ermitteln**; doktoru ne zaman bilgilendirirsin? **16. (FA, AFB III)** Ateşte her zaman ateş düşürücü önlem alınmalı mı? **Beurteilen** (metinden argüman). **17. (FA, AFB II)** İğne batmasından

sonra ilk adımları **beschreiben**. **18. (MD, AFB II)** *Sözlü:* Kulaktan ısı ölçmeden önce hastaya ne yaptığını açıkla.

Ek 5b — Deneme sınavları: cevap anahtarı ve açıklamalar (Türkçe)

> ← Sorular · Serbest cevaplarda (KA/FA/PP/SD/MD) **örnek cevap + puan kriterleri** verilmiştir; tek doğru yoktur. **Almanca kalıp** sınavda yazacağınız cümledir. ⚠ Rakamları standardınızla doğrulayın.

Klausur 1

1. C — Ressource = yetenek/destek; kızı = sosyal kaynak (Lernskript S. 2). A sorun/gözlem, B destek ihtiyacı (görme), D risk. *Almanca:* „Eine Ressource ist …, zum Beispiel …“ **2. B** — ERKLÄREN = neden/koşul/sonuç, "weil". A Nennen, C Vergleichen, D Stellung beziehen. **3. Yanlış** — Sadece ihtiyaç saptama/planlama, süreç yönetimi, kalite saklıdır; planlanmış önlemin uygulanması otomatik değildir (Lernskript S. 5). *Almanca:* „Dies ist falsch, da nur die Planung, Steuerung und Qualitätssicherung vorbehalten sind.“ **4. Yanlış** — ABEDL yapılandırma aracıdır, görüşmenin yerini tutmaz (S. 3). **5.** 6 aşama; Informationssammlung; Evaluation (etkiyi değerlendirme); Kreislauf (döngü). **6.** 1→b · 2→c · 3→a · 4→d. (ABEDL çoklu eşleşebilir: gözlük yok → 11; ağrı → 3.) **7.** örn. Kommunizieren; Sich bewegen; Essen und trinken; Ausscheiden. **8.** *Eine Ressource ist eine Fähigkeit, Stärke, Möglichkeit oder Unterstützung, die ein Mensch besitzt und nutzen kann. Beispiel: Frau Berger kann selbst essen und trinken.* **9.** *…weil professionelle Pflege Gesundheit, Wohlbefinden und Selbstständigkeit erhalten und fördern soll. Alles abzunehmen führt zu Fähigkeitsverlust (Muskelabbau, Abhängigkeit) und verletzt die Selbstbestimmung. Pflege nutzt Ressourcen.* Kriter: *weil* + özerklik/ressource. **10.** (1) Pflegebedarf erheben/feststellen + Pflege planen; (2) Pflegeprozess organisieren/gestalten/steuern; (3) Qualität analysieren/evaluieren/sichern/weiterentwickeln. **11.** *Die Aussage stimmt nicht: Pflegefachpersonen tragen Verantwortung für den Pflegeprozess (§ 4 PflBG): Bedarf erheben, planen, steuern, evaluieren. Ärztliche Anordnungen führen sie zusätzlich in Zusammenarbeit aus.* Kriter: § 4, öz sorumluluk, iş birliği. **12.** a) „Pat. wirkt traurig, spricht kaum und hat nur zwei Bissen vom Frühstück gegessen.“ b) „Körpertemperatur 38,6 °C axillar um 12:30 Uhr; Haut heiß und gerötet; Pat. schwitzt; Arzt informiert.“ c) „Mobilisation wegen Schwindels abgebrochen; Pat. sitzt an der Bettkante; Blutdruck … gemessen; PFK informiert.“ (ölçüm, zaman, yargı yok, **yapılmayanı yazma**) **13. Örnek:** 1) Info: 81 J., yavaş, kalkarken birkaç deneme, mobilyaya tutunuyor, koltukta kalıyor, odadan az çıkıyor. 2) Sorun/Ressource: kısıtlı mobilite + düşme/immobilite riski; eskiden rolatörle bağımsızdı, iş birliği yapar. 3) Ziel: 1 hafta içinde rolatörle güvenle kalkar, günde 1–2 kez yemek salonuna gider. 4) Maßnahmen: nedenleri araştır (ağrı, ilaç, görme), yürüyüş/denge gözlemi, hareket teklifleri, düşme riski kaydı, ortam güvenliği, rolatör/ayakkabı, görüşme, bilgilendirme. 5) Durchführung: birlikte, kayıt. 6) Evaluation: deneme sayısı, güvenlik, düşme olayı; plan uyarla. *+* „Bei Verschlechterung muss die PFK/der Arzt informiert werden.“ **14. Örnek:** *Meiner Einschätzung nach ist es nicht besser, die Körperpflege komplett zu übernehmen, weil Pflege Ressourcen und Autonomie erhalten soll. Wenn die Pflegekraft alles übernimmt, gehen Fähigkeiten verloren und die Person fühlt sich bevormundet. Andererseits spart es Zeit und kann bei akuter Erschöpfung/Schmerz sinnvoll sein. Ein Kompromiss ist die Teilübernahme.* (Pro/Contra + karar) **15.** „Guten Morgen, Frau Berger, mein Name ist …, ich bin Auszubildende und heute für Sie da. Darf ich hereinkommen? Ich möchte Sie gleich beim Aufstehen unterstützen. Möchten Sie das lieber selbst versuchen, und ich stehe daneben, oder soll ich helfen? Ich erkläre Ihnen jeden Schritt vorher.“ (tanışma, Konj. II, duyuru, seçenek)

Klausur 2

1. B (Nachricht, Sender, Empfänger). **2. C** (Appell = "Bunu yap"). **3. Yanlış** — iletişimsiz olunamaz (Axiom 1). **4.** Sachinformation; Beziehungsebene. **5.** 1→c · 2→a · 3→b · 4→d. **6.** Saygı; davranış (kişi değil); Ich-Botschaft; somut durum (immer/nie yok); istek. **7.** *Kindliche/abwertende Sprache gegenüber Erwachsenen.* Örnek „Und jetzt noch den Popo!“ → „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“ **8.** Sach: yaş; Selbstoffenbarung: güvensizlik/ağrı/korku; Beziehung: yetkinlik şüphesi; Appell: "Dikkatli olun/kim olduğunuzu söyleyin". Sadece **bir** kulak bilgiyi duyar. **9.** *Beschreibung:* hemşire odaya girer, kısa selam, manşeti takar, kan alır, ayakları kontrol eder, konuşmaz; sakin TV izler. *Beurteilung:* iyi: hedefe yönelik, hasta bağımsız; kötü: kendini tanıtma/açıklama/onay yok, ilişki yok, hasta

yok sayılıyor, sessizlik sorgulanmıyor. *Konsequenz:* kapıyı çal, tanış, açıkla, sor, TV'yi kıs, işitme/depresyon/dil nedenlerini düşün, gözlemi ilet. **10.** Selamlama güven/güvensizliği belirler; ilişkiyi hemşire şekillendirir (Mantz). **11.** Mimik, jest, göz teması, duruş, görünüm, mesafe, temas (4'ü). **12.** *Initialberührung:* bakım eyleminin bilinçli dokunuşla başlaması (omuza el) – yönelim/güven. *Achtsame Körperpflege:* dokunma biçimi (yumuşak/sağlam, geniş yüzeyli, cımbız tutuşu değil) duruma uyarlanır. **13. Örnek:** *Yakınlık:* güven, güvenlik, iyi oluş, yardım ilişkisinin koşulu. *Mesafe:* kendini koruma, mesleki değerlendirme, ruhsal denge. *Aşırı yakınlık:* sınır ihlali/yorgunluk; *aşırı mesafe:* soğukluk/güvensizlik. *Sonuç:* empati, sözsüz işaretler, zorlamama, öz yansıtma. **14.** „Ich habe mich gewundert, als ich gesehen habe, dass die Medikamente schon gegeben wurden, weil ich nicht wusste, ob es abgesprochen war. Ich wünsche mir, dass wir uns kurz absprechen." **15.** „Ich merke, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Leider muss ich jetzt zu einem anderen Patienten. Darf ich heute Nachmittag wiederkommen? Wir sprechen dann in Ruhe weiter."

Klausur 3

1. B (ZF S. 12–13; A yanlış: nabız zorunlu değil/≤ 10 sn; C normal solunumda; D öncelik değil). **2. B. 3. B** (⚠ Folie 137/140: 100 / 80–100). **4. Yanlış** (AED ersetzt die HDM nicht). **5. Doğru. 6.** Wo; Wer; Was; Wie viele; Rückfragen. **7.** 1→b · 2→d · 3→a · 4→c. **8.** Ventilation = havalandırma; Diffusion = alveol↔kan gaz alışverişi; Perfusion = akciğer kanlanması. **9.** aç → elektrot → talimat → analizde dokunma → şok önerildi: geri çekil + şok → hemen CPR; şok yoksa CPR. **10.** Akım yalnızca kısa aralıklarla sürer (RR ≈ 80 mmHg); yorgunlukla kalite 5 dk içinde > %90'dan %18'e düşer → 2 dk'da değişim. **11.** § 323c: gerekli ve makul ise yardım zorunlu; Garantenstellung: emanet edilen hastaya özel yükümlülük (§ 13 StGB); § 34: şimdiki tehlikede en hafif araçla, korunan menfaat ağır basıyorsa hukuka uygun. ⚠ hukuki tavsiye değil. **12.** a) inme b) akciğer embolisi (± TVT) c) kalp krizi. **13.** SI = 120/80 = **1,5** → ağır şok olası (≥ 1 şok olası, normal 0,5–0,7); yalnızca yönlendirme → acil çağrı, vital, kanama durdur. **14.** *A:* güvenlik, ansprache/sarsma, yardım çağır, hava yolu, yan yatış, acil çağrı, solunum izle, düşme sonuçlarına dikkat. *B:* dolaşım durması, Notruf/Reanimationsteam, CPR 30:2 (100–120/dk, 5–6 cm), AED, ekip gelene kadar, SBAR. **15.** Yetki sınırları, kurum standardı, hasta güvenliği; PFK sorumluluk taşır; ekip çalışması hatayı azaltır; yetkinlik kademeli kazanılır. **16.** „S: Frau X, 78, 10:05 Uhr bewusstlos am Boden gefunden, atmet nicht normal; CPR seit 10:06. B: Z. n. Hüft-OP, bekannte Herzinsuffizienz. A: Kreislaufstillstand, AED hat 1 Schock abgegeben. R: Bitte Übernahme, Atemwegssicherung, Zugang." (kurgusal)

Klausur 4

1. B. 2. C. 3. B. 4. Yanlış (enfeksiyöz değil). **5. Yanlış. 6.** Lungenbelüftung, Infektionen vermeiden, Sekret mobilisieren, Aspiration vermeiden. **7.** 1→b · 2→c · 3→a. **8.** denge; kas zayıflığı; görme; baş dönmesi; korku; ayakkabı; ilaç; inkontinans. **9.** yürüyüş/hız; denge; kalkma-oturma; transfer; yardımcı araç; ağrı; düşme olayı/korkusu; destek ihtiyacı; görme/işitme. **10.** İmmobilite → yavaş kan akışı/kas-ven pompası ↓ → tromboz; yüzeysel solunum/sekret → pnömoni; basınç → dekubitus. **11.** pAVK; ağır nöropati; belirgin ödem; lokal defekt/nekroz/yaralanma. **12.** Başlangıç ani/sinsi; ateş yüksek+titreme/hafif; öksürük produktif/kuru (+ nefes darlığı erken/yavaş; genel durum). **13.** Sakinleştir, 2. kişi, yaralar, kırık dışlanınca dikkatle kaldır (Vierfüßlerstand), nabız/RR sakinleştikten sonra, protokol, PFK/doktor/yakın, beyin sarsıntısı + 24 sa kafa içi basınç, gerekirse Notarzt. Protokol: kişi, tarih/saat/yer, ortam, durum, önceki etkinlik, önlemler, sonuçlar. **14. Örnek:** Info: 78, düşme, sağ kalça ağrısı, zor kalkıyor, az içmiş, terli, yıkamayı reddediyor. Sorun/Ressource: ağrı+hareket kısıtı, sıvı açığı, utanç/öz bakım; kaynak: ifade ediyor, bağımsızlık istiyor. Ziel: ağrı azalır/hareket güvenli, içme sağlanır, mahremiyet korunur. Maßnahmen: ağrı bildir, içecek teklifi, eşlikli mobilizasyon, seçenekli bakım, profilaksiler. Durchführung: birlikte, kayıt. Evaluation: ağrı, içme, memnuniyet, güvenlik. Kötüleşmede PFK/doktor. **15.** Prophylaxe bakım sürecinde planlanır/uygulanır/değerlendirilir; bilgilendirme-danışmanlık-eğitim **kanıtlanabilir** olmalı → izlenebilirlik, kalite, sorumluluk. **16.** „14:05 Uhr: Pat. sitzt im Bad auf dem Boden, gibt Schmerzen am rechten Handgelenk an. Keine sichtbare Kopfverletzung. Puls 88/min, RR 130/80 mmHg nach Beruhigung. PFK und Arzt informiert, Sturzprotokoll ausgefüllt, Tochter benachrichtigt." (kurgusal)

Klausur 5

1. B. 2. C. 3. A (epidermis damarsız). **4. B** (artışta ısıt; soğutma kontrendike). **5. Yanlış. 6. Yanlış** (yalnız kabuk). **7.** Tumor, Dolor. **8.** 1→c · 2→b · 3→a. **9.** Hasta temasından önce; aseptik işlem öncesi; enfekte materyal sonrası; hasta teması sonrası; hasta çevresi sonrası. **10.** C. difficile spor yapar; alkollü dezenfektan etkisiz → eller ek olarak iyice yıkanır (mekanik) + koruyucu giysi. **11.** Normal: cilt hemen geri döner; azalmış: ayakta kalan kıvrım → Exsikkose; Recap < 2–3 sn. **12.** Melanin mavi tonu maskeler; gri/kestane görünür; ayrıca dil, diş eti, ağız mukozası, konjonktiva, tırnak yatağı. **13.** Ateş: hipotalamus hedef değeri pirojenle yükselir; hipertermi: düzenleme yetersiz (ısı üretimi/alımı ≫ kaybı), hedef değer aynı; yaklaşım farklı. **14.** Su geçirmez altlık; 2 bez ılık su (en fazla 10 °C farklı), sıkılmış, baldıra gevşek/kırışıksız; 5–10 dk'da değiştir; 2–3×; kontrendike: soğuk el/ayak, dolaşım bozukluğu; ateş artışında yapılmaz; talimat/anlaşma. **15.** Sorunlar: ateş/sıvı açığı; terleme/dolaşım/düşme riski; bakım/cilt. Doktora: kötüleşme, delir, ağır titreme/kramp, dolaşım belirtileri. **16.** Hayır: ateş bağışıklığı destekler (antikor ↑, etken çoğalması ↓); özel durum/rahatsızlıkta; yavaş düşür; doktor karar verir; antipiretik riskleri (Reye, agranülositoz). **17.** Kan akışı, bol yıka/dezenfekte, hemen doktor/Durchgangsarzt, HBV/HCV/HIV riski, HIV-PEP ≤ 2 sa, bildirim, takip, dokümantasyon. **18.** „Frau X, ich möchte jetzt Ihre Temperatur im Ohr messen. Das dauert nur wenige Sekunden. Ich ziehe Ihr Ohr leicht nach oben, damit ich den Gehörgang gut erreiche. Ist das in Ordnung?“

Puanlama önerisi: MC/RF/LT/ZO 1 puan; KA/BG 2–3; FA/PP/SD 4–6 (yapı, bağlam, terim, gerekçe, güvenlik). **Ayrı:** Almanca hata türü (Artikel/Fall, fiil sırası, terim).

Ek 5c — Operatör formatlı vaka sınavları (Übungsheft tarzı) — soru kitapçığı (Türkçe)

> Cevaplar: Ek5d_Operator_Cevaplari.md · **Gerçek sınav formatı:** *Fallbeispiel → Aufgabe n – OPERATOR / AFB.* Operatör ne istiyorsa onu yazın (10). Sınavda cevaplar **Almanca** olacak: önce Almanca yazmayı deneyin. Vakalar kurgusaldır. Her vaka ≈ 20 dk. Operatör adları ve görev başlıkları **Almanca** bırakıldı (sınavda göreceğiniz biçim); açıklama Türkçe.

Fallbeispiel A: Frau Keller *(04, 06, 07)*

Durum: Frau Keller (82) kalça ameliyatından sonra cerrahi servise alınıyor. 3 gündür çoğunlukla yatakta, harekette ağrı belirtiyor, az içiyor: „Ich habe keinen Durst.“ Hemşire sakrumda **parmak basısıyla geçmeyen kızarıklık** fark ediyor. Yüzeysel soluyor, ara sıra kuru öksürüyor. Kızı: "Annem neden öylece yatamasın?" diye soruyor. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Hemşirenin Frau Keller'de algıladığı üç gözlemi sayın. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Sakrumdaki cilt bulgusunu meslek diliyle ve değerlendirmeden betimleyin. **Aufgabe 3 – DEFINIEREN | AFB I** — "Prophylaxe"yi tanımlayın. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Frau Keller'in immobilitesinden doğan üç riski saptayın. **Aufgabe 5 – ERKLÄREN | AFB II** — Erken mobilizasyonun hem tromboza hem pnömoniye neden karşı koruyabildiğini açıklayın. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — Hemşirenin kızı eğitmesi/danışmanlık yapması ve bunu dokümante etmesi neden gerekir? **Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III** — Frau Keller'in bağımsızlığını destekleyen iki önlem geliştirin ve gerekçelendirin.

Fallbeispiel B: Herr Hoffmann *(05, 03)*

Durum: Herr Hoffmann (74) enfeksiyon nedeniyle yatıyor. Sabah üşüyor, şiddetle titriyor, cildi soluk ve serin; axillar ısı 37,9 °C. İki saat sonra cildi sıcak, kuru, kızarık; ısı 39,2 °C. Susuzluktan, baş ağrısından yakınıyor, yorgun. „Bitte legen Sie mir kalte Wickel an, mir ist so heiß.“ **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Dört gözlemi sayın. **Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I** — İki zaman noktasını ateş evrelerine eşleştirin. **Aufgabe 3 – BESCHREIBEN | AFB I** — İkinci zaman noktasındaki durumu betimleyin. **Aufgabe 4 – VERGLEICHEN | AFB II** — Fieber ile Hyperthermie'yi karşılaştırın. **Aufgabe 5 – ANWENDEN | AFB II** — Sabah ve ikinci zaman noktasında hangi bakım önlemleri düşünülür? (doktor talimatına işaret edin.) **Aufgabe 6 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III** — Hastanın soğuk wickel isteğine görüş bildirin. **Aufgabe 7 – DEUTEN | AFB III** — Güçlü ateş düşüşünden sonra soğuk, yapışkan ter + solgun cildin neden uyarı işareti olabileceğini yorumlayın.

Fallbeispiel C: Stajyer Lena ve Herr Roth *(03)*

Durum: Lena (1. yıl), C. difficile nedeniyle izole Herr Roth'a bakıyor. Önlük ve eldiven giyiyor, tuvalet sandalyesinden sonra eldivenleri çıkarıyor, elleri **dezenfekte edip** odadan çıkıyor. Deneyimli meslektaşı: „Du hast etwas vergessen.“ Sonra Lena kullanılmış bir kanülü atarken parmağını batırıyor. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — El dezenfeksiyonunun beş anını sayın. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Eldiven çıkarma işlemini betimleyin. **Aufgabe 3 – ERMITTELN | AFB II** — Lena'nın neyi unuttuğunu saptayın. **Aufgabe 4 – ERKLÄREN | AFB II** — C. difficile'de alkollü el dezenfektanı neden yetmez? **Aufgabe 5 – ZUSAMMENFASSEN | AFB I** — İğne batması sonrası acil önlemleri özetleyin. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — Kanülün neden kapağına geri takılmayıp hemen atılması gerektiğini gerekçelendirin. **Aufgabe 7 – DISKUTIEREN | AFB III** — Eldiven takmak el dezenfeksiyonunun yerini tutabilir mi? Tartışın.

Fallbeispiel D: Frau Weber *(02, 02b)*

Durum: Uygulama eğitmeni Frau Weber'in (86) odasına kapıyı çalmadan giriyor, tansiyon ve şeker ölçüyor ve sonunda „Und jetzt noch den Popo.“ diyor. Frau Weber duvara bakıyor, cevap vermiyor.

Eğitmen stajyere: „Die redet nie.“ Sonra Frau Weber kısık sesle soruyor: „Wie lange bleiben Sie heute?“ **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Durumda var olan ya da eksik olan dört sözsüz iletişim biçimini sayın. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Konuşma akışını betimleyin. **Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II** — „Und jetzt noch den Popo“ ifadesinin neden sorunlu olduğunu açıklayın. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — „Wie lange bleiben Sie heute?“ sorusunun dört yönünü Vier-Seiten-Modell ile saptayın. **Aufgabe 5 – DEUTEN | AFB III** — Frau Weber'in sessizliğini onun bakış açısından yorumlayın. **Aufgabe 6 – ENTWICKELN | AFB III** — Onuru ve özerkliği koruyan bir selamlama ve intim bakım duyurusu geliştirin. **Aufgabe 7 – ANWENDEN | AFB II** — Stajyerin eğitmene yönelik bir Ich-Botschaft'ını yazın.

Fallbeispiel E: Herr Lang *(08, 02b)*

Durum: 12 numaralı odaya giriyorsunuz. Herr Lang (68) yatağın yanında yerde. Seslenince ve omzunu sarsınca tepki yok. Göğüs kafesi neredeyse hareketsiz, ara sıra gürültülü nefesler duyuyorsunuz. Koridorda bir AED var. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Odaya girdikten sonraki ilk adımları sayın. **Aufgabe 2 – BESCHREIBEN | AFB I** — Erişkinde kalp masajının uygulanışını betimleyin (Skript'inizdeki rakamlarla). **Aufgabe 3 – ERKLÄREN | AFB II** — Ara sıra nefeslerin neden normal solunum sayılmadığını açıklayın. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Alarm/acil çağrıda hangi bilgileri verirsiniz? **Aufgabe 5 – VERGLEICHEN | AFB II** — Normal solunumlu ve normal solunumsuz bilinçsiz kişide yaklaşımı karşılaştırın. **Aufgabe 6 – BEGRÜNDEN | AFB III** — AED neden kalp masajının yerini tutmaz? **Aufgabe 7 – STELLUNG BEZIEHEN | AFB III** — „Stajyerler acilde birşey yapamaz, çünkü hemşire değiller.“ görüşüne görüş bildirin.

Fallbeispiel F: Frau Berger — bakım süreci *(01, 06, 09)*

Durum: Frau Berger (78) evde düşme sonrası kabul ediliyor. Sağ kalçada ağrı, kalkarken destek gerekiyor, gözlüğü evde. „Ich möchte so viel wie möglich selbst machen.“ Yalnız yaşıyor, kızı yakında oturuyor. **Aufgabe 1 – NENNEN | AFB I** — Frau Berger'in üç kaynağını sayın. **Aufgabe 2 – ZUORDNEN | AFB I** — Vakadan üç bilgiyi uygun ABEDL'lere eşleştirin. **Aufgabe 3 – DEFINIEREN | AFB I** — "Selbstbestimmung (Autonomie)"yi tanımlayın. **Aufgabe 4 – ERMITTELN | AFB II** — Üç bakım sorunu/riski saptayın. **Aufgabe 5 – ANWENDEN | AFB II** — Bakım sürecinin 6 aşamasını Frau Berger'e basitçe uygulayın. **Aufgabe 6 – DISKUTIEREN | AFB III** — Hemşire kişisel bakımı tamamen mi devralmalı, yoksa Frau Berger'i dahil mi etmeli? Tartışın. **Aufgabe 7 – ENTWICKELN | AFB III** — Ölçülebilir bir bakım hedefi geliştirin ve gerekçelendirin.

Ek 5d — Operatör vakaları: örnek cevaplar (Türkçe açıklama + Almanca model cümle)

← Sorular · Örnekler **tek doğru değildir.** Puan kriterleri: *operatöre uygunluk – bağlam – Fachsprache – gerekçe (weil) – güvenlik.* ⚠ Rakamları standardınızla kontrol edin. **Sizin Herr-Schneider cevaplarınızın tarzı doğru yönde** (kısa NENNEN, tam cümleli BESCHREIBEN, *weil* ile ERKLÄREN).

Fall A: Frau Keller

1 NENNEN: (1) Schmerzen bei Bewegung. (2) Sie trinkt wenig. (3) Nicht wegdrückbare Rötung am Kreuzbein. *(ayrıca: flache Atmung, trockener Husten)* **2 BESCHREIBEN:** *Am Kreuzbein zeigt sich eine Rötung, die auf Fingerdruck nicht verblasst (positiver Fingertest). Größe und Hauttemperatur sollten ergänzt werden.* (yer + Fingertest; "kötü görünüyor" yok.) **3 DEFINIEREN:** *Prophylaxen sind Maßnahmen bzw. Interventionen, die geeignet sind, Krankheiten und Komplikationen vorzubeugen bzw. zu vermindern. Der Begriff steht in enger Verbindung mit Prävention (Vorsorge).* (Erwartungshorizont S. 4) **4 ERMITTELN:** (1) **Dekubitusrisiko** (basınç + kızarıklık). (2) **Thromboserisiko** (kalça ameliyatı = yüksek expositionelles Risiko, immobilisation, yaş, az içme). (3) **Pneumonierisiko** (yüzeysel solunum, öksürük, immobilite). (+ Exsikkose, Kontraktur, Obstipation.) **5 ERKLÄREN:** *Frühmobilisation beugt einer Thrombose vor, **weil** die Muskel-Venen-Pumpe der Beine aktiviert wird und das Blut schneller zum Herzen zurückfließt. Sie beugt einer Pneumonie vor, **weil** beim Aufsetzen und Gehen tiefer geatmet wird, die Lunge besser belüftet wird und Sekret leichter gelöst werden kann (LISA).* **6 BEGRÜNDEN:** *Prophylaktische Maßnahmen müssen im Pflegeprozess geplant, durchgeführt und evaluiert werden, und Informations-, Beratungs- und Anleitungsgespräche sollen nachweislich erfolgen. Die Tochter versteht, warum Bewegung wichtig ist, kann unterstützen, und die Umsetzung wird nachvollziehbar. Dokumentation sichert Qualität und Verantwortung.* **7 ENTWICKELN:** (a) *Unterstützung beim Aufsetzen an die Bettkante und Aufstehen mit Begleitung; Frau Keller bestimmt das Tempo — erhält Ressourcen, Thrombose-/Pneumonieprophylaxe, Autonomie.* (b) *Anleitung zu Eigenübungen (Fußkreisen, Beine auf-/abstellen) mehrmals täglich — Muskel-Venen-Pumpe, Selbstwirksamkeit.* (Ağrı yönetimi önce **doktorla**.)

Fall B: Herr Hoffmann

1: üşüme/titreme; soluk serin cilt; 37,9 → 39,2 °C axillar; sıcak-kuru-kızarık cilt; susuzluk; baş ağrısı; yorgunluk. **2 ZUORDNEN:** Sabah = **Fieberanstieg**; 2 saat sonra = **Fieberhöhe**. **3 BESCHREIBEN:** *Herr Hoffmann hat eine axillar gemessene Temperatur von 39,2 °C. Seine Haut ist heiß, trocken und gerötet. Er klagt über Durst und Kopfschmerzen und wirkt müde.* **4 VERGLEICHEN:** *Gemeinsam ist, dass die Körpertemperatur erhöht ist. Der Unterschied besteht darin, dass bei Fieber der Hypothalamus den Sollwert durch Pyrogene (Prostaglandin E) erhöht, während bei Hyperthermie die Wärmeregulation überfordert ist und der Sollwert unverändert bleibt.* **5 ANWENDEN:** *Morgens (Anstieg): wärmen (Decken), keine Kühlung, beruhigen, bei Schüttelfrost nicht allein lassen, Vitalzeichen kontrollieren. Zweiter Zeitpunkt (Höhe): Trinkangebot, leichte Bettdecke, kühlende Waschung oder Wadenwickel nur nach Absprache/ärztlicher Anordnung; Haut/Befinden beobachten; Arzt über Verlauf informieren; dokumentieren (Zeit, Ort, Ergebnis, Maßnahme).* **6 STELLUNG BEZIEHEN:** *Meiner Einschätzung nach können kühlende Waschungen/Wadenwickel in der Fieberhöhe sinnvoll sein, da Herr Hoffmann subjektiv Hitze empfindet und Verdunstungskälte entsteht. Im Fieberanstieg sind sie kontraindiziert; kalte Füße/Durchblutungsstörungen sind Kontraindikationen; die Wassertemperatur ist lauwarm (max. 10 °C unter Körpertemperatur). Fieber unterstützt das Immunsystem, daher soll die Senkung langsam und nach ärztlicher Entscheidung erfolgen. Ich würde lauwarme Wickel nach Rücksprache mit der PFK anbieten.* **7 DEUTEN:** *Kalter, klebriger Schweiß mit blasser Haut deutet auf eine **Krisis** hin: Die Temperatur fällt innerhalb weniger Stunden, der Energie- und Flüssigkeitsverlust ist hoch, der Kreislauf wird belastet (Puls steigt = drohender Kollaps). Für die Pflegekraft ist das ein Notfallzeichen; sie informiert sofort PFK/Arzt und überwacht die Vitalzeichen.* (Lysis: sıcak iri damlalı ter.)

Fall C: Lena ve Herr Roth

1: Hasta temasından önce; aseptik işlem öncesi; enfekte materyal sonrası; hasta teması sonrası; hasta çevresi sonrası. **2 BESCHREIBEN:** *Die Handschuhe werden am Handgelenk gegriffen und abwärts gestreift, sodass die Haut die Außenseite nicht berührt. Sie werden auf links gedreht, ineinandergezogen und sofort im Abwurf entsorgt. Anschließend erfolgt eine hygienische Händedesinfektion.* **3 ERMITTELN:** Lena eller **ek olarak iyice yıkamadı**; C. difficile spor yapar, dezenfeksiyon yetmez; yıkama mekanik uzaklaştırır. (Ayrıca koruyucu giysinin doğru çıkarılıp atılmasını kontrol et.) **4 ERKLÄREN:** *Übliche Händedesinfektionsmittel wirken bei C. difficile nicht ausreichend,* ***weil*** *das Bakterium Sporen bildet, die es bei ungünstigen Bedingungen einkapselt und sich später wieder in eine Bakterienzelle verwandeln kann. Daher werden die Keime durch gründliches Händewaschen mechanisch entfernt.* **5 ZUSAMMENFASSEN:** *Nach einer Nadelstichverletzung fördert man den Blutfluss und spült/desinfiziert die Wunde intensiv, informiert unverzüglich Arzt/Durchgangsarzt, klärt das Infektionsrisiko (HBV/HCV/HIV), beginnt ggf. die HIV-PEP innerhalb von 2 Stunden, meldet den Unfall, sorgt für Nachsorge und dokumentiert.* **6 BEGRÜNDEN:** *Gebrauchte spitze Instrumente müssen sofort in geeigneten Behältern entsorgt werden,* ***weil*** *beim Zurückstecken (Recapping) die Verletzungsgefahr hoch ist; NSV übertragen Hepatitis B (≈ 30 %), C (≈ 3 %), HIV (≈ 0,3 %). Überfüllte Behälter und Zeitdruck erhöhen das Risiko; Sicherheitsgeräte und ruhiges Arbeiten verringern es.* **7 DISKUTIEREN:** *Pro: Barriere, Eigenschutz. Contra Ersatz: Mikroperforationen, Kontamination beim Ausziehen, Hautprobleme. Fazit: Handschuhe ersetzen die hygienische Händedesinfektion nicht; bei C. difficile zusätzlich waschen.*

Fall D: Frau Weber

1: Göz teması (duvara bakıyor); duruş/yüz çevirme; mimik (yok); temas (duyurusuz); mesafe; görünüm; paraverbal: ton. **2 BESCHREIBEN:** *Die Praxisanleiterin betritt das Zimmer ohne anzuklopfen, misst Blutdruck und Blutzucker und kündigt zum Schluss „Und jetzt noch den Popo“ an. Frau Weber blickt zur Wand und antwortet nicht. Die Praxisanleiterin äußert „Die redet nie.“ Später fragt Frau Weber leise, wie lange die Auszubildende bleibt.* **3 ERKLÄREN:** *Die Formulierung ist problematisch,* ***weil*** *sie infantilisierend und respektlos ist, die Intimsphäre und Würde nicht wahrt und keine Wahlmöglichkeit lässt. Besser: „Ich wasche jetzt Ihren Intimbereich. Möchten Sie das selbst übernehmen?“* **4 ERMITTELN:** Sach: ne kadar kalacağını öğrenmek istiyor. Selbstoffenbarung: yalnız/güvensiz/korkuyor olabilir. Beziehung: stajyere güveniyor (onunla konuşuyor). Appell: „Bleiben Sie bitte / sprechen Sie mit mir.“ **5 DEUTEN:** *Aus Sicht von Frau Weber könnte das Schweigen bedeuten, dass sie sich übergangen fühlt, weil niemand sie anspricht oder erklärt; vielleicht ist sie ängstlich, beschämt oder schwerhörig. Möglicherweise prüft sie, ob jemand Zeit hat, denn sie spricht die Auszubildende später an. Schweigen ist Kommunikation.* **6 ENTWICKELN:** *„Guten Morgen, Frau Weber, ich bin … von der Pflege. Darf ich hereinkommen? Ich möchte jetzt Ihre Körperpflege durchführen. Möchten Sie Gesicht und Arme selbst waschen? Für den Intimbereich gebe ich Ihnen den Waschlappen; ich decke nur auf, was ich wasche. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn etwas unangenehm ist.“* Gerekçe: tanışma/kapı çalma güven; seçenek özerklik; örtme mahremiyet. **7 ANWENDEN:** *„Ich habe mich unwohl gefühlt, als ich gehört habe, dass Frau Weber ‚nie redet‘, weil sie dadurch auf ihr Schweigen reduziert wird. Ich wünsche mir, dass wir ihr vorher erklären, was wir tun, und sie ansprechen.“* (his – neden – somut istek; davranış eleştirisi.)

Fall E: Herr Lang

1: Eigensicherung/Umgebung; Reaktion prüfen; Hilfe rufen; Atemweg öffnen; Atmung ≤ 10 Sek.; Notruf/Reanimationsteam; CPR; AED holen lassen. **2 BESCHREIBEN:** *Herr Lang liegt auf harter Unterlage mit freiem Oberkörper. Die Helferin kniet daneben, legt den Handballen auf die Mitte des Brustkorbs (unteres Sternumdrittel), die zweite Hand darauf, Arme gestreckt. Sie drückt 5–6 cm tief mit 100–120/min, entlastet vollständig und wechselt nach 30 Kompressionen zu 2 Beatmungen (30:2) bzw. drückt kontinuierlich, wenn nicht beatmet wird. Unterbrechungen sind kurz; Helferwechsel alle 2 Minuten.* (⚠ Folie 140: 80–100/dk — öğretmene sor) **3 ERKLÄREN:** *Vereinzelte, geräuschvolle Atemzüge sind eine Schnappatmung; sie tritt in den ersten Minuten eines Kreislaufstillstands auf und ist keine normale Atmung,* ***weil*** *sie keine ausreichende Belüftung leistet. Würde man sie als normal werten, würde die Reanimation verzögert.* **4 ERMITTELN:** Wo (oda/servis)? Wer ruft an? Was ist geschehen (bilinçsiz, normal solumuyor)? Wie viele? Rückfragen bekle. Hastane içi: Reanimationsteam + defibrilatör. **5 VERGLEICHEN:** *Gemeinsam: Sicherheit, Reaktion, Atemweg, Atmung prüfen, Hilfe. Unterschied: bei normaler Atmung → stabile Seitenlage, Atmung regelmäßig kontrollieren; bei nicht normaler Atmung → Kreislaufstillstand: sofort Herzdruckmassage 30:2, AED, bis das Team übernimmt.* **6 BEGRÜNDEN:** *Der AED analysiert den Rhythmus und kann nur bei schockbarem Rhythmus (VF/VT) einen Schock abgeben; er ersetzt nicht die Herzdruckmassage, die den Kreislauf aufrechterhält. Beide ergänzen sich: CPR wird*

nach dem Schock sofort fortgesetzt. **7 STELLUNG BEZIEHEN:** *Die Aussage ist falsch. Nach § 323c StGB besteht eine Pflicht zur Hilfeleistung, wenn sie erforderlich und zumutbar ist; von Auszubildenden wird Hilfe nach ihren Kenntnissen erwartet, im Pflegekontext besteht zudem Verantwortung gegenüber anvertrauten Pat. Wer mit gebotener Sorgfalt hilft, muss grundsätzlich keine rechtlichen Folgen fürchten. Auszubildende handeln im eigenen Kompetenzbereich, nach Hausstandard und mit der zuständigen Pflegefachperson — aber sie handeln.* ⚠ hukuki tavsiye değil.

Fall F: Frau Berger

1: yemek/içmeyi kendisi yapıyor; ihtiyaçlarını söyleyebiliyor/iş birliği; yüksek motivasyon; kızı yakında. **2 ZUORDNEN:** ağrı/kalkma → ABEDL 2; gözlük yok → 11 ve 1; yalnız/kızı → 12; "kendim yapmak istiyorum" → 4/13 (gerekçe yaz). **3 DEFINIEREN:** *Selbstbestimmung (Autonomie) bedeutet, dass ein Mensch frei und eigenverantwortlich darüber entscheidet, wie er leben, handeln und sich verhalten möchte.* **4 ERMITTELN:** (1) güvensiz kalkış/ağrı → düşme/mobilite riski; (2) gözlük yok → görme/oryantasyon; (3) yalnız yaşıyor → taburculuk sonrası destek ihtiyacı. **5 ANWENDEN:** 1 Info: düşme, ağrı, kalkarken yardım, gözlük yok, bağımsızlık isteği, yalnız. 2 Sorun/Ressource: güvensiz kalkış; iş birliği/motivasyon. 3 Ziel: destekle güvenle kalkma. 4 Maßnahmen: ağrı/hareket gözlemi, güvenli ortam, destek, sürece katma, gözlük. 5 Durchführung: birlikte. 6 Evaluation: kalkış güvenli miydi? destek uyarlanır. **6 DISKUTIEREN:** *Für vollständige Übernahme: Zeitersparnis, bei starken Schmerzen entlastend. Dagegen: Autonomie und Ressourcen gehen verloren, Abhängigkeit steigt, Frau Berger wünscht ausdrücklich Beteiligung. Abwägung: Teilübernahme — Frau Berger wäscht, was sie kann. Fazit: Beteiligung ist vorzuziehen.* **7 ENTWICKELN:** *„Frau Berger steht innerhalb von drei Tagen mit einer Pflegekraft und Gehhilfe sicher vom Bett auf und äußert dabei höchstens leichte Schmerzen.“ Begründung: patientenorientiert, konkret, zeitlich überprüfbar, bei der Evaluation kontrollierbar.* (⚠ ağrı skalası kurum standardına)

Ek 6 — Klinik vaka dosyası (Bölüm G, Türkçe)

Uyarı: Vakalar **eğitim amaçlı ve kurgusaldır** (Frau Berger/Herr Schneider/Simon–Johanna kaynak PDF'lerden uyarlandı; diğerleri ders içeriğinden yazılmış örnekler). **Gerçek hasta talimatı değildir**: ilaç, doz, tedavi kararı → doktor/PFK/kurum standardı. Çözümler tek doğru değildir. **Kapsam notu:** Diyabet, demans, ağrı ölçeği, ameliyat sonrası ayrıntılı bakım ve dehidratasyon tedavisi dersinizde yeterince işlenmediği için bunlar için vaka **eklenmedi**. **Yorum şablonu:** 1 temel sorun · 2 eksik bilgi · 3 önemli belirti · 4 riskler · 5 kaynaklar · 6 hedefler · 7 önlemler · 8 değerlendirme · 9 eskalasyon (kime/ne zaman) · 10 dokümantasyon → 09.

Vaka 1 — Frau Berger (81): değişen hareketlilik

Öykü (DE): Frau Berger ist 81 Jahre alt. Früher ging sie selbstständig mit dem Rollator zum Speiseraum. Seit einiger Zeit geht sie langsamer, braucht beim Aufstehen mehrere Versuche, hält sich an Möbeln fest, bleibt häufiger im Sessel und verlässt das Zimmer seltener. *(EH S. 2)* **Önemli bulgular:** yavaş yürüme, kalkmada deneme ↑, mobilyaya tutunma, çekilme. **Örnek cevap:** 1) yeni/artan hareket kısıtlılığı + düşme ve immobilite riski. 2) ağrı? yeni ilaç? görme/işitme, ayakkabı, denge, düşme korkusu/olayı, ruh hali, beslenme/içme, boşaltım (tuvalete koşma?). 3) düşme, tromboz, dekubitus, kontraktür, pnömoni, izolasyon. 4) eski bağımsızlık, motivasyon?, ortam. 5) güvenli kalkma/yürüme, yemek salonuna katılım, düşmeme. 6) gözlem, nedenleri doktorla araştır, hareket/egzersiz, ortam (ışık, takılma), rolatör/fren, ayakkabı, bilgilendirme, sosyal katılım, düşme riski kaydı. 7) ani kötüleşme, düşme, ağrı, baş dönmesi, konfüzyon → PFK/doktor. **Güvenlik:** mobilizasyon eşlikle; "yaş normaldir" yok. → 06

Vaka 2 — Herr Schneider (78): düşme, korku, yıkanma, az içme

→ 06 §6 (cevaplarınıza geri bildirim), 09 §2 (bakım süreci), Ek5d Fall F/B. **İki yaklaşım:** a) bakımı şimdi kısmen devralarak sun ↔ b) önce içme/mobilizasyonu önceliklendir, yıkamayı sonra tekrar teklif et. İkisi de savunulabilir; ölçüt **güvenlik/akut risk** (içme, ağrı) > konfor; **özerklik** korunur. **Eksik bilgi:** ısı/vital bulgular, düşme nedeni, ağrı şiddeti, oryantasyon, cilt. **Güvenlik:** analjezik/infüzyon **sadece doktor**; delir/ateş/kötüleşmede PFK/doktor.

Vaka 3 — Herr Aksoy (72): yatağa bağımlı, tromboz/pnömoni riski

Öykü (kurgusal): 3 gün önce kalça protezi; ağrı nedeniyle az hareket ediyor, az içiyor, sigara içiyor, düz yatıyor, hafif kuru öksürük; „Mein linkes Bein fühlt sich schwer an.“ **Bulgular:** kalça ameliyatı (**yüksek expositionelles Risiko**), yaş > 60, sigara, immobilite, susuzluk riski, **tek taraflı ağırlık hissi** (IC S. 2–3), öksürük. **Cevap:** *Öncelik:* tek taraflı ağırlık hissi/şişlik = **olası TVT → hemen PFK/doktor**, masaj/mobilizasyon yok, embolizm belirtilerini izle (nefes darlığı, göğüs ağrısı); ani nefes darlığında acil çağrı. *Riskler:* TVT/emboli, pnömoni, dekubitus, susuzluk. *Profilaksi (plan/talimatla):* erken mobilizasyon, yatakta egzersiz (ayak daire), sıvı, MTPS **talimatla ve uygun ölçüyle**, ağrı yönetimi **(doktor)**, LISA (gövde yükseltme, solunum egzersizi, ağız bakımı, aspirasyon önleme). *Hedefler:* tromboz belirtisi yok, solunum sorunsuz, plana göre mobil. *Değerlendirme:* bacak çevresi/cilt/ağrı, solunum sayısı, ısı, içme. **Güvenlik:** antikoagülasyon/ilaç **doktor**; sıvazlama yok; MTPS kontrendikasyonları (pAVK vb.). → 07

Vaka 4 — Frau Wozny: C. difficile / el hijyeni

Öykü (Handout S. 8, sadeleştirilmiş): Sürekli kokulu ishal (C. difficile). Pflegefachfrau Nimra koruyucu giysi giyer; tuvalet sandalyesi temasından sonra elleri **dezenfekte eder ve yıkar**; odada uyarı levhası. **Sorular:** 1) Neden ek yıkama? 2) Hangi koruma? 3) Yakınlar nasıl dahil edilir? 4) Stajyerin hatası? **Cevap:** 1) spor yapar, olağan dezenfektanlar etkisiz; yıkama mekanik uzaklaştırır. 2) hastaya özgü koruyucu giysi, eldiven, HD **ve** yıkama, yüzey dezenfeksiyonu (Hygieneplan). 3) levha, bilgilendirme (Hygienefachkraft). 4) eldiven ≠ HD; giysiyi değiştirmemek. **Güvenlik:** kurum Hygieneplanı, Hygienefachkraft'a sor. → 03

Vaka 5 — Frau Demir (84): dekubitus riski ve cilt gözlemi

Öykü (kurgusal): Çoğunlukla yatakta, ince kuru cilt. Pozisyon verirken sakrumda kızarıklık; parmak basısında geçmiyor. **Bulgular: pozitif Fingertest → Dekubitus Kategorie I**; yaşlı cildi/Xerosis. **Cevap:** *Sorun:* başlayan basınç hasarı; *nedenler:* immobilite, basınç, kuru cilt. *Önlem (standart/PFK; DNQP Dekubitusprophylaxe ⚠ PDF'de yok):* PFK'ye haber, **bölgeyi rahatlat**, cilt gözlemi/dokümantasyon (yer, boyut, Fingertest), cilt bakımı, hareket teşviki. *Doku:* „Kreuzbein: Rötung ca. 3 × 2 cm, auf Fingerdruck nicht wegdrückbar, Haut intakt, Pat. gibt keine Schmerzen an. PFK informiert.“ **Güvenlik:** eğitimsiz kendi başına önlem yok; ovma/masajdan kaçın ⚠ (standart).

Vaka 6 — Yerde yatan hasta (hastane içi ilk yardım)

→ 08 §8, Klausur 3 Fr. 14. **Varyantlar:** (a) tepki var, göğüs ağrısı/nefes darlığı → Notfallteam, ABCDE; (b) tepkisiz ama normal soluyor → yan yatış; (c) normal solunum yok → CPR/AED. **Hedef:** karar ağacı + SBAR. **Güvenlik:** eldiven, yetki sınırı, kurum standardı.

Vaka 7 — Johanna: „Wie alt sind Sie überhaupt?“ (iletişim)

→ 02 §1.2. Görev: 4 kulağı analiz et, 2 alternatif cevap yaz. **Etik:** stajyer yalan söylemez/savuşturmaz; emin değilse PFK/Praxisanleiterin dahil edilir.

Vaka 8 — Herr Becker (66): yemekte öksürme (aspirasyon profilaksisi)

Öykü (kurgusal): İnme sonrası yatarken yemekte sık boğuluyor, öksürüyor, ses "ıslak". Dün akşam hafif ateş, bugün belirgin nefes darlığı. **Bulgular: Dysphagie**, aspirasyon riski; aspirasyon pnömonisi belirtileri **gecikmeli (2–12 sa):** öksürük, dispne, siyanoz, ateş (P S. 17–18). **Cevap:** *Önlem:* yemekte **dik oturt**, zaman tanı, oral beslenme değerlendirmesi (doktor/logopedi ⚠), ağız bakımı; *nefes darlığı/siyanoz/ateş → hemen PFK/doktor (acil)*; solunum sayısı/ısı/cilt gözlemi. *Dokümantasyon:* nesnel, saat, besin, belirtiler. **Güvenlik:** nefes darlığında beslemeye devam etme; sonda beslemesi/aspirasyon talimatsız yok.

Ek 7 — Kişisel gelişim takip tablosu

> Bu tabloyu kendi sürümünüzde (Markdown/Excel) doldurun. **Zayıf konu listesi** = yanlış yaptığınız her soru. **Durum:** ☐ yeni · ◐ öğreniyorum · ● biliyorum · ★ sınavda rahat. **Tekrar tarihleri:** gün 1 / 3 / 7 / 14.

1. Konu takibi

Konu	Bölüm	Durum	Son çalışma	Tekrar 1	Tekrar 3	Tekrar 7	Tekrar 14	Not
Bakım temelleri/ABEDL/PflBG	01	☐						
Bakım süreci	01/09	☐						
İletişim modelleri	02	☐						
Dokunma/yakınlık–mesafe	02	☐						
Hasta diyalogları	02b	☐						
Hijyen/HD/5 an	03	☐						
Enfeksiyon/MRE/BGW	03	☐						
Hücre/doku	04	☐						
Cilt/dekubitus	04	☐						
Vücut ısısı/ateş	05	☐						
Hareket/düşme	06	☐						
Tromboz profilaksisi	07	☐						
Pnömoni profilaksisi	07	☐						
İlk yardım BLS/AED	08	☐						
Şok/acil durumlar	08	☐						
Operatörler/dokümantasyon	10	☐						
Gramer	11	☐						

2. Yanlış yapılan sorular (Zayıf konu listesi)

Tarih	Klausur/Soru	Konu	Yanlış cevap	Neden? (bilgi / dil / dikkat)	Doğrusu	Tekrar planı

Neden kodları: **B** = Bilgi eksik · **D** = Almanca dil/terim · **O** = Operatörü yanlış anladım · **S** = Süre/Dikkat.
Öneriler: B → konu özeti + flashcard + 3 yeni soru; D → Ek 1 sözlük, cümleyi 3 kez yaz; O → 10; S → zamanlı pratik.

3. Almanca hata günlüğü

Cümleniz	Hata türü (Artikel/Fall/Verb/…)	Neden	Doğru cümle	Yeni örnek cümlem

4. Haftalık özet

Hafta	Çalışılan süre	Çözülen soru	Doğru %	En zayıf 2 konu	Gelecek hafta hedef
1					
2					
3					
4					

5. Öğretmene sorulacaklar listesi

- [ ] Kalp masajı frekansı 100–120 mi 80–100 mü? (00)

- [ ] Hipotermi tanımı / nosokomial 24 sa mi 48 sa mi?
- [ ] Hangi yeterlilik modeli (3 boyut mu 4 alan mı)?
- [ ] Sınav formatı (Operatoren? Fall? mündlich?)

Ek 8 — Kaynakça ve sayfa indeksi (Türkçe)

> "S." = PDF sayfası; "bas. S." = kitabın basılı sayfası.

1. Yüklenen kaynaklar ve önemli sayfalar

Dosya	Önemli sayfalar	Bölüm
Lernskript LF1A	S. 1 bakım biçimleri/yeterlilik; S. 2 Frau Berger; S. 3 ABEDL; S. 4 bakım süreci; S. 4–5 PflBG	01
Arbeitsblatt LF1A	S. 4 kavramlar; S. 6 ABEDL eşleştirme; S. 7–8 süreç; S. 9–10 § 4 vakaları	01
Handlungskompetenz (I care S. 47–48)	S. 1 tanım; S. 2 Abb. 2.7	01
Einstieg (9.10.2025), Fallbeispiel, Sequenz 2–5	Einstieg S. 4, 7–10; Fallbeispiel S. 1–2; Seq. 2 S. 2–9; Seq. 3 S. 2–17; Seq. 4 S. 3–7; Seq. 5 S. 3–4	02
PPP Berührung AI 02/04/05; Arbeitsinput 06b	AI 02 S. 3; AI 04 S. 5–9; AI 05 S. 2–5	02
Hyg. Grundlagen Teil I/II; Handout; Übung	T1 S. 2–5, 9, 11, 14–15, 17, 19–20; T2 S. 2–4, 16–17, 19; H S. 1–2, 5–9	03
BGW Take Care Infektionsschutz	S. 4–6 NSV; S. 7–9 HD/eldiven; S. 10–13 MRSA/TB/Skabies; S. 14; S. 18–23 Fall Johanna; S. 20 Leitfaden	03
Haut Teil 1/2	T1 S. 1–4; T2 S. 1–10 (Turgor S. 6; zyanose/Recap S. 7; dekubitus/ABCDE S. 8; yaş S. 9)	04
Thieme Körpertemperatur	S. 2–4 fizyoloji; 5–14 ölçüm; 15–17 hipotermi; 17–21 hipertermi; 21–29 ateş; 29–36 önlem/komplikasyon	05
Erwartungshorizont Bewegung im Alter	S. 1–4	06
Sturzprophylaxe PPP	Folie 3–14	06
Thromboseprophylaxe PPP / Auszug I care	PPP Folie 2–4; IC S. 1–6 (bas. S. 417–422)	07
Pneumonieprophylaxe PPP	Folie 2–21	07
Erste Hilfe (254 S.)	Anatomi 5–56; hukuk 58–79; kılavuz/acil çağrı 84–89; BLS 109–163; ALS 171–194; şok 195–204; acil durumlar 205–229; bakım 230–253	08
Zusammenfassung Erste Hilfe B2	S. 1–27	08
Fotoğraf #1 Operatoren-Training	Übungsheft S. 3	10
Fotoğraf #2 Herr Schneider	Übungsheft S. 4	06/10

2. Dış kaynaklar (PDF dışı ek bilgi)

- DNQP Expertenstandard Sturzprophylaxe, **2. Aktualisierung 2022**: Auszug · Pressemitteilung (slayt 2013 diyor).
- GRC Leitlinien 2025: Pressemitteilung — sayılar doğrulanmadı.
- § 323c StGB: https://dejure.org/gesetze/StGB/323c.html (Folie 69'daki link).
- PflBG: https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/ — bu oturumda açılamadı, **manuel kontrol**.
- RKI/KRINKO/BGW/IfSG: rki.de/krinko, bgw-online.de.
- Hall mesafe değerleri: genel bilgi ⚠ (PDF'de yok).

3. Doğrulanamayan / eksik

Erste Hilfe S. 1–57 ve S. 234–254 yalnızca taranmıştır; BGW S. 21–56 yalnızca taranmıştır; boş çalışma kâğıtlarının cevapları sizde; ilaçlar, pansuman tekniği, diyabet, demans, ağrı ölçekleri, delegation, hasta hakları PDF'lerde yok.